

Онкология и радиология Казахстана

№1 (27) 2013

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
К.Ш. Нургазиев, д.м.н.

Редакционная коллегия
Адилбаев Г.Б., Есентаева С.Е. (зам.гл.редактора), Жолдыбай Ж.Ж., Ижанов Е.Б.,
Кайрбаев М.Р. (административный редактор), Ким В.Б., Сейтказина Г.Д., Талаева
Ш.Ж., Чичуа Н.А., Нурғалиев Н.С., Жылқайдарова А.Ж., Иманғалиева Н.Т.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. Казахстан	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь
Кабдрахманов К.Б.

Редакторы переводов
Галушкин М.А., Утельбаева А.Е., Шалбаева Р.Ш.

Адрес редакции
г. Алматы, 050022, пр. Абая, 91
Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК
Тел. (327) 292 10 63
«Онкология и радиология Казахстана», №1 (27), 2013 г.
Собственник - РГКП на ПХВ «Казахский НИИ онкологии и радиологии» МЗ РК
Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г.
Тип. «Идан», ул. Коммунальная, 39
Тираж 200 экз.
Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Содержание

Вопросы диагностики

Ж.Ж. Жолдыбай, Г.С. Ахметова. Компьютерная томография в диагностике образований печени. (3)

Е.Б. Ижанов, Ж.Ж. Жолдыбай, Г.С. Ахметова, Р.З. Абдрахманов, Е.Ш. Абзалбек. Лучевые методы исследования в оценке распространенности процесса и эффективности лечения рака пищевода. (6)

А.К. Адильшин, Ш.К. Адильшина. Синдром Мейгса. Ошибки диагностики. (9)

Т.Т. Аманов. Возможности и перспективы диагностики рака молочной железы в Западно-Казахстанской области. (11)

Л.Ж. Беламанова. Роль субоперационного цитологического исследования абластичности при новообразованиях кожи. (14)

Лечение

К.Ш. Нургазиев, С.Е. Есентаева, Ж.К. Чингисова, Г.Ж. Сейтказина, Г.Т. Сейсенбаева, Ж.Ж. Жолдыбай, И. Тажединов. Обоснование радионуклидной терапии метастазов в костях рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин в Казахстане. (18)

Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований. Алматы, 2012 . Клинический протокол «Рак молочной железы». (22)

Н.Н. Мезинова. Рак тела матки. Настоящее и прошлое (33)

М.Р. Кайрбаев, Ж.К. Чингисова, Е.К. Кукубасов, Р.Ш.

Шалбаева, Ж. Досаханов. Роль неоадъювантной полихимиотерапии в лечении онкогинекологического рака. (37)

Ж.К. Чингисова, М.Р. Кайрбаев, Е.К. Кукубасов, Р.Ш. Шалбаева, Ж. Досаханов. Выживаемость больных раком шейки и тела матки при комплексном лечении. (44)

А.А. Бейсебаев, Э.Т. Баймухаметов, М.И. Карасаев. Опыт выполнения одномоментной двусторонней лимфодиссекции при раке легкого. (49)

Е.Б. Ижанов. Неоадъювантная химиотерапия местнораспространенного рака желудка. (51)

В помощь практическому врачу

Г.М. Курманова. Состояние тромбоцитограммы у больных пурпурной Шенгейн-Геноха. (55)

Г.М. Курманова. Тромбофилические маски острого лейкоза. (57)

Сестринское дело

С. Аширова. Современное состояние и перспективы развития онкологических кабинетов. (59)

Юбилей

Нариман Ажигалиевич Ажигалиев (61)

Доспул Хайназарович Савхатов (62)

УДК:616.36-006-073.75

Ж.Ж.Жолдыбай, Г.С.Ахметова
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Компьютерная томография в диагностике образований печени

Аннотация. Статья посвящена компьютерной диагностике образований печени. В диагностике образований печени важное значение имеют лучевые методы исследования. Компьютерная томография является уточняющим методом в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей печени. В статье представлены данные об анатомии, сегментарном строении печени. Представлена классификация образований печени. Описаны признаки образований печени при компьютерно-томографическом исследовании, методики исследования, включающие в себя нативное исследование и исследование с применением контрастных препаратов. Изложена дифференциальная диагностика образований печени.

Ключевые слова: образование печени, компьютерная томография, сегментарное строение печени.

Актуальность

Проблема диагностики очаговых образований печени является актуальной. В большинстве случаев это связано с бессимптомным течением и случайным выявлением, а так же с трудностями дифференциальной диагностики даже при применении современных лучевых методов исследования. Важное значение в диагностике образований печени имеет компьютерно-томографическое исследование (КТ) с болюсным контрастированием, позволяющее проводить дифференциальную диагностику, что имеет важное значение в выборе тактики лечения.

Анатомия

Печень - является самым большим паренхиматозным органом (объем – 1400-1700 см³), размеры вариабельны (зависят от роста и поперечника тела). Краниокаудальный размер печени по правой среднеключичной линии составляет не более 15см, переднезадний размер по правой паравертебральной линии менее 5см. Наибольшие размеры печень имеет на уровне ее ворот. Соотношение размеров правой и левой долей составляет 3:2. В ворота печени входит воротная вена (v.portae). В печени воротная вена делится на правую и левую ветви, которые дают 8 крупных сегментарных ветвей. Вместе с воротной веной проходит печеночная артерия, ветви которой сопровождают ветви воротной вены. Сегменты печени: I. хвостатая доля; II. левый верхний латеральный сегмент; III. левый нижний латеральный сегмент; IV.квadratная доля (левый медиальный сегмент); V. правый нижний передний сегмент; VI. правый нижний задний сегмент; VII. правый верхний задний сегмент; VIII. правый верхний передний сегмент. I сегмент – это хвостатая доля, II и III сегменты – части

левой доли, которые расположены слева от серповидной связки, IV сегмент (квadratная доля) – медиальная часть левой доли печени – расположена между серповидной связкой и линией, проведенной между нижней полой веной и желчным пузырем через среднюю печеночную вену. Правая доля: V-VIII сегменты – по часовой стрелке от V сегмента, имеющего нижне-медиальное расположение сразу справа от желчного пузыря.

Методики КТ исследования: а) нативное (бесконтрастное) получение изображений - проводится после предварительного перорального контрастирования желудочно-кишечного тракта (250 мл 5% раствора водорастворимого рентгеноконтрастного препарата или 500-600 мл воды в течение получаса); б) методика контрастного усиления – исследование проводится после внутривенного введения рентгеноконтрастного препарата. Для дифференциальной диагностики образований печени необходимо проведение болюсного контрастирования с проведением исследований в артериальную, портовенозную, отсроченную фазы.

Классификация образований печени

Доброкачественные образования: киста, гемангиома, фокальная нодулярная гиперплазия, аденома, гамартома, поликистоз. Первичные злокачественные образования печени: гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокарцинома, гепатобластома, ангиосаркома, лимфома. Вторичные злокачественные образования печени: метастатическое поражение.

Доброкачественные образования печени

Кистозные поражения печени: врожденные и приобретенные (вторичного характера). Врожденные кисты: солитарные и множественные, могут быть изолированные поражения или в сочетании с кистами других органов. Приобретенные (вторичного характера): посттравматические (серомы, биломы, гематомы), паразитарные, воспалительные (абсцесс).

КТ картина: а) простая киста - гиподенсивное образование (0-30 ед.Н), с четкими контурами, без внутренних перегородок, повышение плотности возможно при наличии участков кровоизлияний и кальцинатов (осложненные кисты), в некоторых случаях может визуализироваться кальцификация стенки кисты; б) абсцесс - гиподенсивная зона, без четкого отграничения от окружающей паренхимы печени, неравномерная дольчатость, пузырьки воздуха, иногда уровень жидкости, при внутривенном контрастировании возникает усиление сигнала от капсулы образования; в) эхинококковая киста – тонкая краевая линия обызвествления, контрастное усиление капсулы и септ, дочерние кисты, денситометрическая плотность кисты повышается после гибели паразита.

Гемангиома - наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль печени, разновидности: капиллярная и кавернозная.

КТ картина (обычно образования печени сравниваются с плотностью печени, при гемангиомах лучше сравнивать с плотностью сосудов в каждой фазе): на нативных сканах - гиподенсивное образование (сравнимо с плотностью сосудов печени); артериальная фаза - образование с периферическим усилением, капиллярные гемангиомы могут выглядеть как гомогенные гиперденсивные образования (сравнимо с плотностью аорты); портовонозная, отсроченная фазы - накопление контрастного вещества от периферии к центру (сравнимо с плотностью воротной вены). Если плотность образований не соответствует плотности сосудов в каждой фазе контрастного усиления, то можно исключить гемангиому.

Фокальная нодулярная гиперплазия (FNH) - опухолеподобная патология, развивается из различных структур печени (гепатоциты, клетки желчевыводящих протоков, соединительнотканые элементы), чаще встречается у женщин, может быть солитарной и множественной.

КТ картина: при нативном исследовании - хорошо очерченное гиподенсивное или изоденсивное образование без капсулы, с невыраженным центральным рубцом; артериальная фаза - интенсивное контрастное усиление с наличием гиподенсивной центральной зоны рубца; портовонозная фаза - образование изоденсивно паренхиме печени, с гиподенсивным центральным рубцом; отсроченная фаза - относительно гиперденсивный центральный рубец.

Первичные злокачественные образования печени - могут развиваться из гепатоцитов, эпителия желчных протоков, эндотелиальных клеток и лимфоидных клеток. Наиболее часто встречаются образования эпителиального происхождения (гепатоцеллюлярная карцинома и холангиокарцинома). Мезенхимальные опухоли встречаются гораздо реже и представляют всего 1% всех первичных злокачественных образований печени.

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) - наиболее часто встречающаяся первичная опухоль печени, развивается из гепатоцитов, часто возникает на фоне хронических заболеваний печени: хронического вирусного гепатита, алкогольного цирроза, гемохроматоза. Различают узловую, диффузно-узловую, диффузную формы ГЦК.

КТ картина: на нативных сканах - гиподенсивное или изоденсивное образование; артериальная фаза - гиперденсивное образование или образование неоднородной плотности, капсула образования встречается в 30-67% случаев и визуализируется в виде изо- гиподенсивного ободка, центральный рубец - линейной или лучистой формы структура в толще опухоли, который может быть обусловлен воспалением, некрозом или фиброзом. Центральный рубец, обусловленный воспалением и некрозом - имеет низкую плотность, обусловленный фиброзом имеет высокую плотность. В обоих случаях не накапливает контрастное вещество. В структуре образования может быть жировая трансформация - участок в толще опухоли, имеющий плотность одинаковую с плотностью подкожной жировой клетчатки; портовонозная фаза - образование изо- или гиподенсивное относительно нормальной печени; отсроченная фаза - образование изо- или гиподенсивное относительно печени, капсула и фиброзные септы относительно гиперденсивны.

Холангиокарцинома - злокачественное образование, развивающееся из эпителия желчных протоков, может

локализоваться в мелких внутрипеченочных протоках, на уровне ворот печени или во внепеченочных желчных протоках. Различают опухолеобразующий, околопротоковый инфильтрирующий и внутрипротоковый типы. Опухолообразующий тип холангиокарциномы - на нативных КТ сканах чаще визуализируется солитарное, гиподенсивное образование с неровными краями, без капсулы, могут быть гиперденсивные очаги в структуре образования, которые обусловлены кальцинатами. При внутривенном контрастировании отмечается медленное накопление от периферии к центру, с прогрессирующим контрастным усилением в отсроченную фазу. Околопротоковый инфильтрирующий тип холангиокарциномы - формируется вдоль мелких желчных протоков, данный вид опухоли имеет чаще множественное поражение с признаками инфильтрации печеночных вен и ветвей портальной вены. Основным признаком при КТ исследовании является расширение желчных протоков проксимальнее опухоли и сужение (вплоть до тотального) пораженных протоков. Сложно визуализировать на ранних стадиях, на поздних стадиях вовлекается паренхима и ворота печени. Внутрипротоковый тип холангиокарциномы - чаще всего единичная полипообразная внутрипротоковая опухоль, может распространяться по слизистой оболочке (папилломатоз), при КТ - желчные протоки расширены из-за обструкции опухолью, сама опухоль (при достаточных размерах) может визуализироваться в виде внутрипротокового гиперденсивного участка по сравнению с желчью. При внутривенном контрастировании отмечается накопление в портальную и отсроченную фазы.

Ангиосаркома - редкая опухоль, в 40% случаев выявляется связь с одним из канцерогенных факторов: торотраст, винилхлорид, мышьяк, радиационное поражение. В 15% всех случаев опухоль выявляется на поздних стадиях с наличием отдаленных метастазов (легкие, селезенка). В большинстве случаев имеет множественное поражение печени с признаками кровоизлияний внутри очагов. На нативной КТ - солитарное или множественные гиподенсивные образования с гиперденсивным компонентом за счет кровоизлияний, часто отмечается свободная жидкость в брюшной полости. При контрастировании отмечается заметное и длительное контрастное усиление по периферии опухоли без заполнения контрастным веществом до центра.

Вторичные злокачественные образования печени - это метастатическое поражение печени. Наиболее часто в печень метастазируют рак толстого кишечника, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак молочной железы, рак легкого. Дифференциальная диагностика метастатического поражения печени проводится с гемангиомами, локальным и очаговым вариантом жировой инфильтрации, очаговой узловой гиперплазией, аденомами, очаговым фиброзом, гематомами печени, гепатоцеллюлярным и холангиоцеллюлярным раком, диффузными поражениями печени (цирроз и фиброз печени), простыми, нагноившимися и малигнизированными кистами, абсцессом, эхинококкозом, специфическим поражением печени (туберкуломы, саркоидоз), с вторичным поражением печени при ряде заболеваний.

Дифференциальная диагностика. Для дифференциальной диагностики гепатоцеллюлярной карциномы с доброкачественными образованиями важное значение имеет отсроченная фаза. При доброкачественных образованиях быстрого вымывания контрастного вещества из опухоли не наблюдается, что связано с отсутствием усиленной васкуляризации. При фокальной нодулярной гиперплазии и аденоме визуализируется быстрое

накопление в артериальной фазе, образования становятся изоденсивными в портовоенозной фазе, и будет оставаться изоденсивным с печенью в отсроченной фазе. Особенно у больных с циррозом печени отсроченная фаза помогает в дифференциальной диагностике доброкачественных образований от гепатоцеллюлярной карциномы.

Гиперваскулярные образования, которые быстро накапливают контрастное вещество в артериальную фазу, могут быть как доброкачественными (FNH, аденома, гемангиома), так и злокачественными (ГЦК, метастазы меланомы, рака почки, молочной железы, саркомы, нейроэндокринных опухолей). Эти образования могут иметь идентичную картину в артериальной фазе. Дифференциальная диагностика возможна при проведении исследований в других фазах, изучении дополнительных признаков, вместе с клиническими данными. Так, гиперваскулярные метастазы могут рассматриваться у пациентов с известной первичной опухолью.

Некоторые образования печени могут иметь капсулу: наиболее часто ГЦК, аденома. При КТ исследовании в артериальной и в портовоенозной фазах капсула будет гиподенсивной, так как фиброзная ткань накапливает контрастное вещество очень медленно. В отсроченной фазе капсула образования хорошо визуализируется и будет гиперденсивной.

Тұжырым

Ж.Ж.Жолдыбай, Г.С.Ахметова

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Бауыр түзілісі кезіндегі компьютерлік томография

Мақала бауырдағы түзілістерді компьютерлі анықтауға арналған. Бауырдағы түзілістерді анықтауда сәулемі зерттеу әдістерінің маңызы зор. Бауырдың қатерлі және қатерлі емес ісктерінің дифференциалды

диагностикасында компьютерлі томография анықтаушы әдіс болып табылады. Мақалада бауырдың анатомиясы, сегментарлы құрылымы жайлы мәліметтер берілген. Бауырдың түзілістерінің жіктелуі көрсетілген. Компьютерлі томографиялық зерттеу кезіндегі бауырдың түзілістерінің белгілері, нативті зерттеу және контрастты препараттарды қолданумен жүргізілетін зерттеу әдістері жазылған. Бауырдың түзілістерінің дифференциалды диагностикасы түсіндірілген.

Түйінді сөздер: бауыр түзілісі, жіктелуі, компьютерлік томография, диагностика.

Summary

Z.Z. Zholdyba, G.S.Akhmetova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Computed tomography in the diagnosis of the liver

This article is devoted to computer diagnostics of liver tumours. In diagnosis of liver tumours important place takes radiologic studies. CT scan is the main diagnostic method in differential diagnosis of malignant and benign tumors of liver. This abstract shows anatomical and segmental and structure of liver? Introduces the classification of tumors. Also describes criteries of tumors in CT, research methods. Including native methods and with using contrast agents.

Keywords: Education liver, classification, computed tomography, diagnostic.

structure of liver? Introduces the classification of tumors. Also describes criteries of tumors in CT, research methods. Including native methods and with using contrast agents.

УДК: 616.329-006.6-073.75:615-036.8

Е.Б.Ижсанов, Ж.Ж. Жолдыбай, Г.С. Ахметова, Р.З. Абдрахманов, Е.Ш.Абзалбек
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Лучевые методы исследования в оценке распространенности процесса и эффективности лечения рака пищевода

Аннотация. Лучевые методы исследования (рентген-контрастное исследование, компьютерная томография) улучшают диагностику рака пищевода и позволяют провести объективную достоверную оценку состояния стенок органа и окружающих регионарных зон, что позволяет изначально выработать оптимальную тактику лечения. Проведение

РКТ при раке пищевода целесообразно всем пациентам, планируемым на оперативное лечение, в целях оценки распространенности и резектабельности опухолевого процесса. РКТ в сочетании с рентгенконтрастным ис-

следованием позволяют оценить результаты неoadъювантной химиолучевой терапии рака пищевода по схеме таксотер+цисплатин в комбинации с конформной лучевой терапией.

Ключевые слова: рак пищевода, рентгенконтрастное исследование, компьютерная томография

Рентгенологическое исследование остается одним из ведущих методов, используемых в диагностике органического поражения пищевода. По данным ряда авторов, специфичность метода составляет 97-99% [1,2].

В настоящее время в обследовании больных раком пищевода для оценки распространенности процесса, изучения состояния лимфатических узлов ведущую роль имеет рентгеновская компьютерная томография (РКТ) [3,4].

Для выбора адекватного метода лечения необходимо изучение состояния как первичного очага, так и определения распространенности процесса.

Цель работы: оценить возможности лучевых методов исследования в определении распространенности процесса и оценке эффективности химиолучевой терапии рака пищевода.

Материалы и методы: исследования выполнены 30 больным раком пищевода в возрасте от 47 до 63 лет, средний

возраст составил 52,4 лет.

Исследования проводились пациентам, находившимся на стационарном лечении в отделении химиотерапии КазНИИ онкологии и радиологии.

Рентгенологические исследования и компьютерная томография выполнялись в отделении рентгенодиагностики.

Всем пациентам до начала противоопухолевой терапии и после ее завершения проводилось рентгенконтрастное исследование пищевода на рентгеновском аппарате с цифровой приставкой (Agfa), рентгеновская компьютерная томография пищевода на компьютерном томографе «Aura» (Philips).

Учитывались следующие важные критерии оценки опухолевого процесса: локализация и характер роста опухоли; протяженность опухолевого процесса; характер изменений слизистой оболочки пищевода; степень сужения просвета пищевода, а также состояние окружающих органов и регионарных зон.

В неoadъювантном режиме пациентам проводилось 3 курса химиотерапии по схеме: доцетаксел (таксотер) 75 мг/м², цисплатин 75 мг/м² с межкурсовым интервалом 21 день и в сочетании с 3-м курсом лекарственного лечения курс конформной лучевой терапии РОД-2Гр, 5 фракций в неделю, СОД-50Гр. Спустя 3 недели после завершения химиолучевой терапии выполнялось оперативное лечение



до лечения



после лечения (через 4 месяца)

Рисунок 1- Рентгенконтрастное исследование пищевода



Рисунок 2 - Компьютерная томография пищевода

в объеме субтотальной резекции пищевода с одновременной гастропластикой и расширенной двухзональной лимфодиссекцией.

Результаты: по локализации процесса в пищеводе распределение больных выглядело следующим образом: среднегрудной отдел – 19 (63,3%) пациентов, нижнегрудной отдел – 11 (36,7%) пациентов.

Экзофитный рост отмечен в 21 (70%) случае, опухолевый рост смешанного характера наблюдался у 9 (30%) больных.

Протяженность опухоли до 4 см отмечена у 2 (6,7%) пациентов; от 4 до 6 см у 21 (70%) больных; свыше 6 см – в 7 (23,3%) случаях.

Пациентов с сужением просвета пищевода более 1,5 см было 16 (53,3%); от 1,0 см до 1,5 см – 11 (36,7%); менее 1,0 см – 3 (10%).

При контрольном рентгенологическом исследовании пищевода установлено, что общий объективный эффект получен у 19 (63,3%) больных, из них у 5 (16,6%) достигнута полная регрессия опухоли (рисунок №1), подтвержденная результатами морфологического послеоперационного исследования, частичная регрессия – у 14 (46,7%) больных, у 11 (36,7%) – стабилизация процесса.

Опухолевая инфильтрация на РКТ-срезах выглядела в виде неравномерного утолщения стенок и неровности контуров сужения просвета пищевода, толщина стенки при этом колебалась в пределах 7-22 мм, что наблюдалось у 19 (63,3%) больных (рисунок №2). У 11 (36,7%) пациентов при местно-распространенном процессе толщина стенок пищевода варьировала в пределах 26-28 мм.

При прорастании опухоли в смежные органы и структуры, наблюдаемое в нашем исследовании у 1 (3,3%) пациента, на РКТ-сканах выявлялась нечеткость контуров пищевода и окружающих тканей, что с определенной уверенностью позволяло утверждать о распространенном процессе.

Выводы

Лучевые методы исследования (рентгенконтрастное исследование, компьютерная томография) улучшают диагностику рака пищевода и позволяют провести объ-

ективную достоверную оценку состояния стенок органа и окружающих регионарных зон, что позволяет изначально выработать оптимальную тактику лечения. Проведение РКТ при раке пищевода целесообразно всем пациентам, планируемым на оперативное лечение, в целях оценки распространенности и резектабельности опухолевого процесса. РКТ в сочетании с рентгенконтрастным исследованием позволяют оценить результаты неоадьювантной химиолучевой терапии рака пищевода по схеме таксотер+цисплатин в комбинации с конформной лучевой терапией.

Список литературы

1. Прокоп М.В., Галаксин М.С. Спиральная и многослойная компьютерная томография. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - Т. 1. - С. 11.
2. Кишковский А.Н. Дифференциальная рентгенодиагностика в гастроэнтерологии. - М.: Медицина, 1984. - С. 55.
3. Соколов Ю.Н., Антонович В.Б. Рентгенодиагностика опухолей пищеварительного тракта. - М.: Медицина, 1981. - С. 7.
4. Жолдыбай Ж.Ж., Жакенова Ж.Ж., Потапов О.В., Коростелева О.В. Комплексная лучевая диагностика во оценке эффективности лечения рака желудка // Мат. Республиканской научно-практической конф. «Актуальные проблемы клинической онкологии». - Семей, 2007. - С. 68-69.

Тұжырым

Е.Б.Ижсанов, Ж.Ж.Жолдыбай, Г.С.Ахметов,
Р.З.Абдрахманов, Е.Ш.Абзалбек

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Өңеш қатерлі ісігі кезінде емдеу тиімділігі мен сәуелі зерттеу әдістерін тексеру

Өңеш қатерлі ісігінде сәуелі зерттеу әдісі (рентгеноконтрастты зерттеу, компьютерлік томография) өңештің қабырғаларын және қоршаған аймақ жағдайын бағалауға көмектеседі. Өңештің жайылған және резектабельді қатерлі ісігі бар науқастарға оперативті ем кезінде РКТ жүргізген дұрыс болып саналады. Рентгеноконтрастты РКТ адьювантты емес химиосәуелі терапияны

таксотер+цисплатин конформды сәулелі терапияда қолдануға болады.

Түйінді сөздер: өңеш қатерлі ісігі, компьютерлі томография.

Summary

E.B. Izhanov, Z.Z. Zholdybai, G.S.Akhmetova, R.Z. Abdrahmanov, E.Sh.Abzalbek

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Radiological methods in the evaluation of the distribution process and the effectiveness of treatment for esophageal cancer.

The radial methods of investigation (x-ray contrast

examination, computed tomography) enhance esophageal cancer diagnosis and enable to perform an objective reliable assessment of organ walls conditions and surrounding regional zones, which makes it possible to develop an optimal therapeutic approach. In esophageal cancer it is reasonable to conduct roentgen computed tomography (RCT) to all patients intended for open treatment in order to assess the extension and respectability of tumor process. RCT in combination with x-ray contrast examination enables to assess the results of neoadjuvant chemo - radiation therapy in esophageal cancer; which makes it possible to perform a timely adjustment in the treatment provided.

Key words: oncology, esophageal cancer, chemotherapy

УДК: 618.11-002-07

А.К.Адилышин, Ш.К.Адилышина

Северо-Казахстанский облонкодиспансер

Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова

Синдром Мейгса. Ошибки диагностики

Аннотация. В статье приводится картина синдрома Мейгса, а также обсуждаются причины ошибок диагностики данного состояния. Демонстрируется случай из клинической практики.

Ключевые слова: Синдром Мейгса, диагностика, ошибки.

Синдром Мейгса – Meigs, синдром Meigs-Cass, синдром Demons- Meigs – описан американским хирургом Meigs Joe Vincent (1892-1963) и Мейгсом и Касса в 1935 году, как сочетание доброкачественной опухоли яичника, асцита и гидроторакса (1,4). Полная триада наблюдается не всегда.

Чаше встречается при фибромах яичника.

Соответственно гистологической классификации опухолей яичников (ВОЗ, Женева, 1977), данная опухоль – «аденофиброма и цистаденофиброма», описывается как «эпителиальные опухоли» в группе как доброкачественных, так и пограничных опухолей (3).

Фибромы составляют около 4% всех опухолей яичников, не обладают выраженной гормональной активностью, поражают чаще лиц пожилого возраста, сопровождаясь полисерозитом – гидроторакс, асцит, крайне редко и гидроперикард – синдром Мейгса (1).

Субъективная картина заболевания скудная. Жалобы на односторонние боли в нижней части живота неинтенсивного характера, зачастую описываемые как «дискомфорт в животе», сменяются жалобами на распирание брюшной стенки, нарастающую одышку, сердцебиение.

Объективное обследование выявляет клиническую картину, иногда приводящую к ошибочному диагнозу. Так, при аускультации легких выявляется картина «плеврита», чаще правостороннего. При исследовании органов брюшной полости-асцит. При гинекологическом обследовании – опухоль яичника.

Фиброма яичника – достаточно редкое заболевание, всего 4% среди всех опухолей этого органа. Мы не нашли сведений о частоте синдрома Мейгса,

С синдромом Мейгса более знакомы онкогинекологи, менее – гинекологи общей лечебной сети и совсем редко-терапевты, участковые и семейные врачи.

Все вышеуказанное является поводом для демонстрации нашего случая из практики.

Б-ая У.Б., 51г. поступила в Северо –Казахстанский онкодиспансер с жалобами на дискомфорт в животе, увеличение живота в объеме. Из анамнеза : считает себя больной с марта 2012 г, при обращении к гинекологу был поставлен диагноз «миома матки», диагноз подтвержден при УЗИ-исследовании. В апреле 2012 г. по поводу увеличения живота обратилась к терапевту, проводилась симптоматическая терапия.

В связи с отсутствием лечебного эффекта самостоятельно прошла УЗИ-исследование, был поставлен диагноз – гепатоз, гепатомегалия, асцит. Терапевтом

направлена к гастроэнтерологу , проведен курс терапии по поводу данного состояния, однако улучшения не было, асцит не поддавался терапии. При динамическом УЗИ - исследовании органов брюшной полости 18.07. 2012г. выставлен диагноз «гепатомегалия, цирроз печени, асцит», лечение продолжено у гастроэнтеролога другой поликлиники. Из- за неэффективности проводимой терапии в сентябре 2012 г. направлена на стационар в гастроэнтерологическое отделение Северо-Казахстанской областной больницы.

УЗИ гениталий от 10.09.2012г- миома матки, асцит, объемное образование , исходящее из малого таза. ФГДС от 10.09.2012 – без патологии. Ирригоскопия от 12.09.2012- спастический колит. МРТ органов брюшной полости 11.09.2012г, заключение - 2-хсторонний гидроторакс, асцит, объемное образование малого таза солидного характера, распространяющееся в брюшную полость. Стацлечение в течение 9 дней. Осмотрена торакальным хирургом, сделаны УЗИ плевральных полостей с торакоцентезом, ПЗС с взятием жидкости на онкоцитологию. Цитологически - без атипии,

Первичный осмотр онкогинекологом 13.09.2012 г. Рекомендовано перевести в облонкодиспансер.

Стацлечение в облонкодиспансере с 14.09.12г., госпитализирована на диагностическую лапаротомию. Проведен курс дезинтоксикационной терапии, витаминно - общестимулирующая терапия. 14.09.2012г. сделан лапароскопический осмотр, проведены УЗИ плевральных полостей, рентгенография легких, консультации торакального хирурга и терапевта. Заключение терапевта - АГ II ст, хронический бронхит, киста левой почки ХПН 0, полиартроз , варикозная болезнь. Спирометрия 18.09.2012 – нарушение функции внешнего дыхания I-II ст. Осмотр ангиохирурга от 14.09.2012- варикозная болезнь, ХВН 1 кл.

Маммография по скринингу от VII -2010г. – без патологии. Р –графия легких от 04.09.2012- плеврит справа.

Данные лабораторного обследования – Общий анализ крови 26.09.2012-Гемоглобин-110 г/л, эрит-4,2*10¹²/л. Цв .пок-0,82. Лейк- 8,6*10⁹/л. Пал-5, сегм-74,мон-5,лимф-16. СОЭ-23 мм/час. Общий анализ мочи-24/09/2012- кол-100мл цвет-желтый, прозрачность-полная, отр. плотность-1030, реакция-кислая, сахар-отр, белок-отр, микроскопия осадка- эпит.плоск- 0-2-4 в п/зр , лейкоц-14-16 в п/зр, эритро-0, слизь-отр, соли-отр, ураты-отр,бактерии-отр.. Биохимическое исследование крови -03.09.2012- общий белок-77 г/л, мочевины -6,6 ммоль/л, креатинин-0,077 ммоль/л, глюкоза- 5,84 ммоль/л, тимоловая проба-3,7 ед, холестерин- 4,1 ммоль/л, фибриноген-3,1 г/л, протр. индекс-87%, билирубин-8,5 мкмоль/л, АЛТ-0,44 ед, АСТ-0,21 ед. Мазок на онко/цитологию от 13.09.2012- без атипии. HBsAg и HCV от 05.04.12-отр. RW от 28/08/12 г.№106-отр, ВИЧ от 06.09.12 № 3564- отр.

Подготовлена к операции, операция - 20.09.2012 г. Произведена экстирпация матки с придатками, экстирпация большого сальника, дренирование. В постоперационном

периоде проведен курс дезинтоксикационной, антибактериальной, гемостатической, антикоагулянтной терапий, профилактика осложнений варикозной болезни. Сделано контрольное УЗ- исследование плевральных полостей 26.09.2012г- жидкости нет. В послеоперационном периоде на 6-е сутки—цистит, получила курс противовоспалительной терапии. Заживление — per grima.

Морфологически - данные ИГХ. Картина клеточной фибромы яичника.

Выписана с рекомендацией - наблюдение у гинеколога в ООД. При повторном осмотре с инструментальным обследованием через 1 и 3 месяца после выписки самочувствие хорошее, признаков асцита и гидроторакса не выявлено.

Как нам кажется, стандартное мышление о том, что в пожилом возрасте увеличение живота и не интенсивные боли в животе связаны чаще с миомой матки привели к первичному диагнозу — « миома матки». Однако, уже через месяц появилось более значительное увеличение живота асцит без указаний в анамнезе сердечной патологии и тогда мысль врача склоняется в пользу гепатоза, гепатомегалии, цирроза печени. Хотя следовало бы подумывать о том, что правосторонний гидроторакс не свойственен гепатогенному асциту, а при сердечном гидротораксе — если он односторонний, то как правило жидкость определяется в левой плевральной полости.

Все это при недостаточном сборе анамнеза, неполном клиническом обследовании - не достаточно полном гинекологическом обследовании - недооценка состояния придатков матки при влагалищном обследовании, не проведены бимануальное влагалищно-прямокишечное исследование и динамическое влагалищное обследование после парацентеза и освобождения брюшной полости от асцитической жидкости, гипероценке роли лабораторных инструментальных исследований привело к врачебной ошибке — диагнозу « миома матки», « цирроз печени». А морфологическое исследование удаленного яичника, исчезновение гидроторакса и асцита после операции и отсутствие их при ретроспективном наблюдении через 1 и 3 месяца говорят в пользу синдрома Мейгса.

Когда диагноз непонятен, необходимо как можно раньше созывать консилиум с участием врачей различного профиля.

Ошибка в диагнозе могла стоить человеку жизни, так как полисерозит, прогрессируя, мог привести к сердечной недостаточности, а синдром Мейгса к кахексии, даже при всей его доброкачественности.

Список литературы

1. Лазовский И.Р. Справочник клинических симптомов и синдромов.- М.: Медицина, 1981.
2. Махаринская Е.С. Березняков Е.С. Диагностика и лечения асцита и его осложнений //Болезни и антибиотики.- 2011.-№ 2(05).
3. Селезнева Э., Железнов Б. Доброкачественные опухоли яичников.- М., 1982.
4. Словарь - справочник синдромов и симптомов заболеваний /Под ред. проф. М.Фейгина. - Варшава: Варшавское государственное медицинское издательство, 1965.
5. Тополянская А.В., Бородулин В.И. Синдромы и симптомы в клинической практике: эпонимический словарь справочник.- М., 2010.
6. Тейлор Р.Б. Трудный диагноз /Перевод с англ.- М.: Медицина, 1988.-Т1.-С. 168

Тұжырым

А.К.Адилшин, Ш.К. Адилшина

Солтүстік Қазақстан Аудандық онкодиспансер, С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Мейгс синдромы. Диагностика қателіктері

Мақалада Мейгс синдромының көрнісі жазылған, сонымен қатар берілген жаздайды анық таудазы қателіктердің себебі талцаланған. Клиникалық тәжірибедегі болған жаздай баяндалған.

Түйінді сөздер: Мейгс синдромы, диагностика. Қателіктер.

Summary

A.K.Adilshin, S.K.Adilshina

North Kazakhstan Regional Oncology Center, Kazakhsky National Medical University S.D. Asfendiyarov

Meigs' syndrome. Error diagnosis

Using personal experience and analysis of literature the authors give an elucidation of the clinical picture and problem of diagnosis Meigs' syndrome and discusses about reason of diagnostic errors. Also authors demonstrates the case from clinical practice.

Keywords: Meigs' syndrome, diagnostics, error.

УДК: 618.19-006.6-07(574.1)

Т.Т.Аманов

Западно-Казахстанский областной онкологический диспансер

Возможности и перспективы диагностики рака молочной железы в Западно-Казахстанской области

Аннотация. В статье показано использование комплекса для стереотаксической биопсии -MammoTest, который позволяет получить верификацию опухолевого процесса не только образований до 0,5 см, но и образований, локализованных близко к большой грудной мышце и аксиллярных областях. Диагностику обычным методом пункционной биопсии провести крайне сложно с учетом малых размеров опухоли. Метод доступен широкой возрастной группе и менее травматичен, а в экономическом плане обоюдно выгоден как для медицинской организации, так и для больного в целом.

Ключевые слова: рак молочной железы, комплекс для стереотаксической биопсии.

Ежегодно в мире регистрируется около 10 млн. новых случаев онкологических заболеваний, и более 6,2 млн. человек умирают от рака. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире выявляется около 1 млн. новых случаев рака молочной железы (РМЖ).

Рак молочной железы — злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы.

Эпидемиология

В мире это наиболее частая форма рака среди женщин. Заболеванию подвержены женщины в возрасте от 13 до 90 лет. Это также второе по частоте после рака лёгких онкологическое заболевание в общей популяции (считая и мужское население).

РМЖ относится к агрессивной злокачественной опухоли, склонной к быстрой диссеминации преимущественно лимфогенным путем. Тревогу вызывает тот факт, что происходит рост числа заболеваний женщин фертильного возраста. В последние годы РМЖ занимает первое место в структуре онкологической патологии у всех женщин во всех индустриальных странах, включая Казахстан.

В Западно-Казахстанской области удельный вес женщин, больных РМЖ, в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями составляет 10,5%, а удельный вес смертности от РМЖ составляет 6,8%, что представляет собой актуальную проблему региона. В области за 10 лет наблюдается рост заболеваемости РМЖ с 15,5 на 100 тыс. населения в 2002 году до 29,9 на 100 тыс. населения в 2012 г.

Проявления рака молочной железы могут быть настолько разными, насколько и сами женщины, страдающие им. Высокая заболеваемость определяет стратегию борьбы, которая ориентирована на сокращение

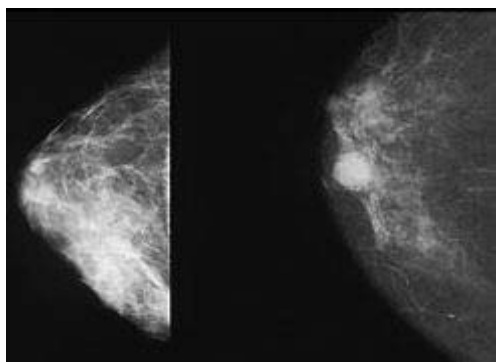
смертности, увеличение безрецидивного периода и улучшение качества жизни.

Диагностика

Возникновение рака в органе, удобном для осмотра и пальпации, могло бы быть вполне доступным для своевременного распознавания. Однако, как свидетельствует опыт клинической онкологии, процент запущенных случаев к моменту постановки диагноза достигает 30-40%. Это обусловлено многообразием проявлений клинических, рентгенологических, сонографических и патоморфологических форм злокачественных новообразований МЖ, что затрудняет правильность постановки диагноза и что в определенной степени может объяснять неудачные результаты лечения. Сегодня невозможно акцентировать внимание на диагностике доклинических форм РМЖ без применения современных лучевых методов исследования. Современная лучевая диагностика заболеваний молочной железы включает целый ряд методов визуализации, основным из которых является рентгеновская маммография (ММГ) — «золотой стандарт», старейший и надежный метод, благодаря которому выявляется большинство злокачественных новообразований молочной железы. Чувствительность доходит до 95%, а специфичность — до 90%. ММГ не информативна в молодом возрасте в связи с повышенной плотностью ткани молочной железы. Ультразвуковое исследование молочной железы — безопасный метод диагностики у женщин молодого возраста, позволяющий использовать его многократно, даже у беременных и кормящих молодых женщин. Позволяет оценить состояние молочных желез у молодых женщин с плотными молочными железами, диагностировать рентгенонегативные новообразования, образования расположенные вблизи грудной стенки, что невозможно при маммографии, а также выполнять пункционные биопсии непальпируемых образований под визуальным контролем.

Доказана ценность МРТ при многих заболеваниях, включая обнаружение и определение стадии рака молочной железы. С помощью МРТ можно обследовать плотные образования молочных желез у молодых женщин, а также импланты молочных желез, что трудно сделать с помощью обычной маммографии, возможна дифференциальная диагностика между соединительной тканью послеоперационных шрамов и рецидивирующими опухолями молочной железы, оценка множественных опухолей перед нерадикальными операциями с сохранением груди.

Позитронно-эмиссионная томография может



определить первичную локализацию рака груди, локорегионарные и отдаленные метастазы. При оценке отдаленных метастазов рака молочной железы, ПЭТ превосходит анатомические методы визуализации и очень чувствительна при локализации очагов рака груди в мягких тканях. Отрицательным моментом является дороговизна этого метода диагностики.

Остеосцинтиграфия позволяет определять участки накопления радиофармпрепарата в костях с дальнейшей верификацией данных участков на наличие в них метастазов.

Сегодня в рамках улучшения выявления ранних форм РМЖ проводится регулярно исследование целевой группы женщин, что уже приносит позитивные результаты. Однако в ходе проводимой работы проблематичным моментом становится диагностика непальпируемых образований, т.е. наличие опухоли на рентгенологическом снимке, но отсутствие его при объективном осмотре. Ранее единственным способом диагностики было назначение оперативного вмешательства. Однако и у данного метода без учета его положительных моментов есть ряд отрицательных, которые стоит перечислить. Во-первых, это оперативный и анестезиологический риск; во-вторых, трудность в определении локализации патологического участка при проведении операции; в-третьих, травматичность метода и наконец, эмоциональное напряжение, которое испытывает обследуемая женщина. И сегодня в целях повышения эффективности ранней диагностики заболеваний молочных желез, использование аппаратов для проведения стереотаксической биопсии является как экономически целесообразным, так и удобным для населения.

Материал и методы

На базе областного онкологического диспансера введена в полную эксплуатацию система комплекса для стереотаксической биопсии - MammoTest. Особенностью данного оборудования является свободный доступ в 360° к месту пункции по кратчайшему расстоянию, а также цифровая система визуализации, обеспечивающая прекрасные контрастные изображения с высоким пространственным разрешением. Все вышеперечисленное дает возможность проводить биопсию образований, расположенных близко к большой грудной мышце или в аксиллярных областях.

Исследованию подлежали женщины с непальпируемыми образованиями размерами до 0,5 см и с образованиями, расположенными в труднодоступных локализациях, а именно, в непосредственной близости к большой грудной мышце и аксиллярным областям, что зачастую требует в тактическом плане проведение

оперативного лечения. Возрастной предел подлежащих обследованию колебался от 34-х до 77-ми лет.

Результаты и обсуждение

За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. проведено всего 57 исследований на данном аппарате. Средняя длительность одного обследования составляет 40-50 минут. По результатам диагностики, с учетом рентгенологической структуры с подозрением на рак, получены следующие данные. Выявлено 14 случаев рака, все гистологически верифицированные. В разрезе возрастов среди женщин, подвергшихся обследованию, выявлены в возрастном коридоре с 72 до 77 лет - 2 случая, с 62 до 71 года - 2 случая, с 52 до 60 лет - 5 случаев, с 42 лет до 51 года - 4 и 1 случай в возрастной группе 32-41 лет. Кроме того выявлены 2 случая с доброкачественными образованиями - фиброаденомы, жировые изменения (липома) - 4 случая, фиброзно-кистозные изменения 17 случаев, образования воспалительного генеза 2 случая. Также важным моментом следует отметить, что 15 случаев при



рентгенологическом подозрении на рак, гистологическая структура соответствовала норме. И лишь в 3-х случаях гистологический материал был неинформативен.

Выводы

Таким образом, использование стереотаксической приставки является удобным методом диагностики, как для пациента, так и для врача. Использование стереотаксического метода позволяет получить верификацию опухолевого процесса не только образований до 0,5 см, но и образований, локализованных близко к большой грудной мышце и аксиллярных областях. Диагностику обычным методом пункционной биопсии провести крайне сложно с учетом малых размеров опухоли. Метод доступен широкой возрастной группе и менее травматичен, а в экономическом плане обоюдно выгоден как для медицинской организации, так и для больного в целом.

Список литературы

1. Хасанов Р.Ш. *Современные методы диагностики и лечения рака молочной железы* // Ремеდიум Приволжье. - 2009. - № 6.
2. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В. *Скрининг рака молочной железы* // Практическая онкология. - 2010. - Т. 11, №2. - С. 60-65
4. Мат. V Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные вопросы клинической и экспериментальной онкологии». - М.: НИИ-Природа, 2005. - С. 101, 252 с.
5. Особенности морфологической верификации в диагностике рака молочной железы // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2008. - Т. 4, №2

Тужырым

Т.Т.Аманов

Батыс Қазақстан облыстық онкологиялық диспансері

Батыс Қазақстан облысындағы сүт безі қатерлі ісігін анықтаудың мүмкіндіктері мен келешегі

Мақалада 0,5 см дейінгі түзілістерді ғана емес, Үлкен кеуде булыңы етте және аксиллярлы аймаққа жақын орналасқан ісіктік үрдістердің верификациясын алуға мүмкіндік беретін, стереотаксикалық биопсияға арналған кешен — MammoTest — ті қолдану көрсетілген. Шкіц өлшемдері кішкене болғандықтан қарапайым пункционды биопсия әдісімен анықтау өте қиын. Бертген әді әр түрлі жастағы топтарда қолдануға тиімді және жарақат алу мүмкіндігі төмен, ал экономикалық жағынан медициналық мекемеге де науқасқа да тиімді.

Түйінді сөздер: сүт безі, стереотаксикалық биопсияға арналған кешен.

Summary

Possibilities and perspectives of breast cancer diagnostics in West Kazakhstan.

West Kazakhstan Regional Oncology Center

The article shows how to use the complex for stereotactic biopsy-Mammotest — that allows to get histological verification of tumor process in small size of tumors (0.5 cm), tumors with close localization to muscles, and axillary. This procedure is available for extensive age category and low traumatic, beneficial to medical organization and for patient also.

Key words: breast cancer, complex for stereotaxis biopsy.

УДК: 616.5-006.6-076.4

Л.Ж.Беламанова

Региональный диагностический центр

Роль субоперационного цитологического метода исследования абластичности при новообразованиях КОЖИ

Аннотация. Проанализированы результаты интраоперационного экспресс-цитологического метода исследования 40 больных с новообразованиями кожи. Показано, что результаты цитологического исследования определяют дальнейшую тактику лечения в зависимости от абластичности операционной раны.

Ключевые слова: новообразования кожи, цитологический метод.

Злокачественные новообразования кожи являются одним из наиболее частых онкологических заболеваний, а в некоторых странах они занимают первое место. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями рак кожи составляет до 50% (Арзыкулов Ж.А. и соавт., 2007) [1].

Несмотря на наружную локализацию рака кожи и доступность опухоли для исследования, до настоящего времени нередко встречаются распространенные, запущенные формы заболевания, лечение которых является сложным и не всегда приводит к удовлетворительным результатам. Лечение данных форм рака кожи нередко представляет значительные трудности, особенно при локализации заболевания в области головы и лица (Пустынский И.Н. и др., 2002; Демидов Л.В. и др., 2004) [2,3]. Несмотря на то, что с момента первого иссечения рака кожи прошло более 140 лет, до настоящего времени нет единого мнения об адекватных границах иссечения рака кожи, т.е. о необходимом объеме удаляемых вместе с опухолью видимо здоровых тканей. Как правило, лечащему врачу ничего неизвестно о глубине инвазии, что и предопределяет возникновение рецидива. В связи с этим, важно разработать детальный план хирургического лечения, чтобы максимально предупредить возникновение продолженного роста и рецидива (Ахметов И.Р. и др., 2006; Лемехов В.Г., 2001; Михнин А.Е., 2001; Барчук А.С., 2001) [4,5,6,7].

В настоящее время вопрос об эффективности цитологической диагностики рака кожи решается однозначно и ценность этого метода в практической деятельности не вызывает сомнений. Во время операций очень часто возникают трудности при решении вопроса о степени распространенности рака, абластичности и радикальности проведенного оперативного вмешательства (Максимова Н.Е. и др., 1999; Савельев А.Е. и др., 2003) [8,9]. В связи с вышеизложенным важную роль в улучшении хирургического лечения рака кожи можно достичь, используя экспресс-цитологический метод исследования краев послеоперационной раны.

Цель

- определить ценность цитологической диагностики при срочных исследованиях с краев послеоперационной раны при новообразованиях кожи.

Материалы и методы исследования

Проанализированы результаты интраоперационного экспресс-цитологического метода исследования у 40 больных, получивших лечение в отделении опухолей костей и мягких тканей Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии с 2006 по 2009 гг. с диагнозом рак кожи.

В анализируемой группе больных было женщин – 28 (70%) и мужчин – 12 (30%). Средний возраст больных составил 57 лет.

Из 40 больных установлены цитологически следующие варианты: плоскоклеточный рак – 22 больных (55%), базальноклеточный рак кожи – 16 больных (40%), меланома кожи – 2 больных (5%). В дальнейшем все они получили гистологическое подтверждение. Цитологические препараты окрашивали по Паппенгейму.

Результаты и обсуждение

Цитологически плоскоклеточный рак характеризовался полиморфными атипичными эпителиальными клетками, с четко выраженными критериями злокачественности, и клеточными элементами, сходными с клетками многослойного плоского эпителия. При этом клетки округлые, овальные, полигональные, лентовидные, веретенообразные. Ядра клеток округлые или овальные, полиморфные, с грубым строением хроматина, гиперхромные. Увеличенные ядрышки определялись в единичных относительно светлых клетках. Цитоплазма большинства клеток обильная, гомогенная или слегка зернистая.

Клетки располагались разрозненно, группами комплексами. В большинстве комплексов, особенно крупных, клетки имели хорошо различимые межклеточные мостики. Фон мазков был представлен, в основном, элементами выраженной воспалительной инфильтрации. Так выглядел плоскоклеточный ороговевающий рак кожи (рисунок 1).

Цитологическая картина плоскоклеточного неороговевающего рака была представлена клетками опухоли с выраженными признаками анаплазии. Клетки крупных размеров, в основном, неправильной округлой формы. Ядра клеток очень крупные, с неровными конту-

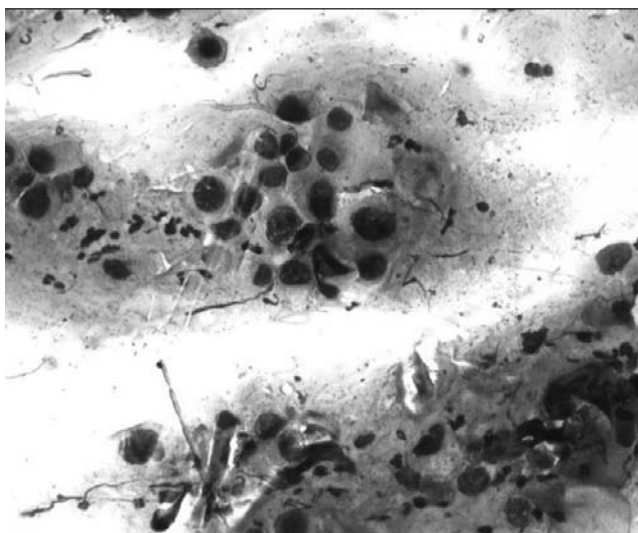


Рисунок 1 – Плоскоклеточный ороговевающий рак кожи.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

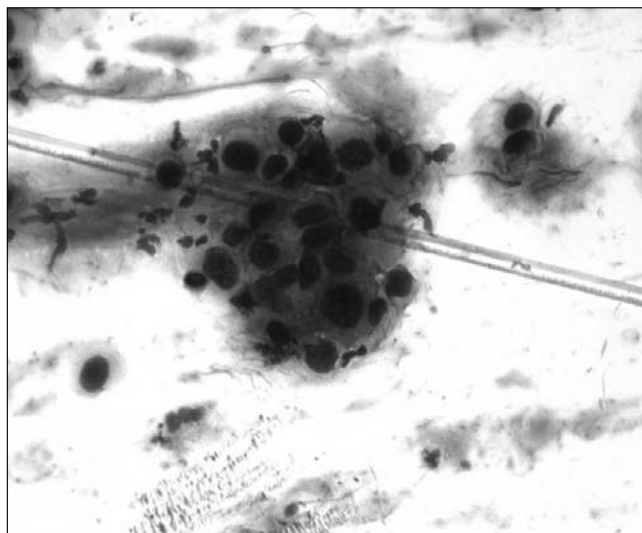


Рисунок 2 – Плоскоклеточный неороговевающий рак кожи.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

рами, светлые. Хроматин тяжистый, распределялся неравномерно, иногда в виде глыбок черного цвета. В ядрах часто определялись 1-2 крупных неправильной формы ядрышка. Хроматин тяжистый, распределен неравномерно. Цитоплазма клеток обильная, от светло-голубого до ярко-синего цвета, гомогенная, иногда без четких границ, как бы сливается с общим фоном мазка (рисунок 2).

Для цитогрaмм базалиом было характерно наличие плотных тканевых клочков, тяжей а также трабекулярных, солидных структур, комплексов и полей с фестончатыми краями. Клетки в комплексах и тяжах базалиомы были различной величины и формы, но преобладали мелкие, с темной базофильной цитоплазмой. Ядра были невелики по размерам, округлой, овальной или вытянутой формы, гиперхромно и диффузно окрашенные, так что структуры хроматина и ядрышки незаметны. Хроматин ядер грубоглыбчатый. Цитоплазма клеток скудная и негомогенная. Иногда ядра приобретали веретенообразную форму, слегка напоминая фибробласты. Помимо мелких гиперхромных клеток встречались более светлые клетки среднего размера, округлой или полигональной формы с центрально расположенными ядрами, напоминающими

клетки плоскоклеточного рака.

В препаратах много элементов воспаления — лейкоцитов, гистиоцитов (рисунок 3,4).

При меланоме кожи цитологическая картина была крупными клетками округлой, неправильной формы. В клетках обнаруживался пигмент меланин, который, заполняя всю клетку, придавал ей вид кляксы. В отдельных клетках пигмент в виде пылевидной зернистости равномерно заполнял цитоплазму и придавал ей серовато-зеленоватый оттенок. Ядра клеток полиморфные, с резко увеличенными ядрышками. Хроматин ядер мелкоглыбчатый, окрашен гиперхромно. Цитоплазма клеток базофильная. В зависимости от содержания пигмента цвет ее варьировал от аспидно-серого до черноватого. Встречались резко полиморфные двуждерные клетки (рисунок 5,6).

Во время операции изучались соскобы с краев и дна послеоперационной раны, а также с поверхности опухоли. При этом в мазках-отпечатках с краев, дна раны и с поверхности опухоли у 12 больных были выявлены опухолевые клетки.

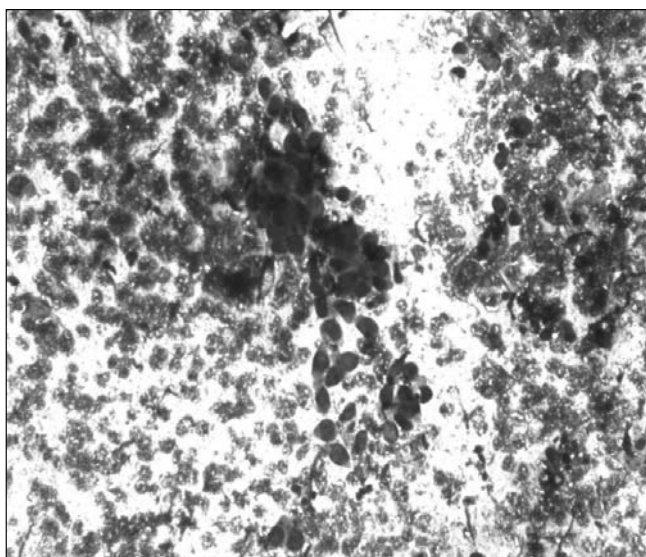


Рисунок 3 – Базалиома.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

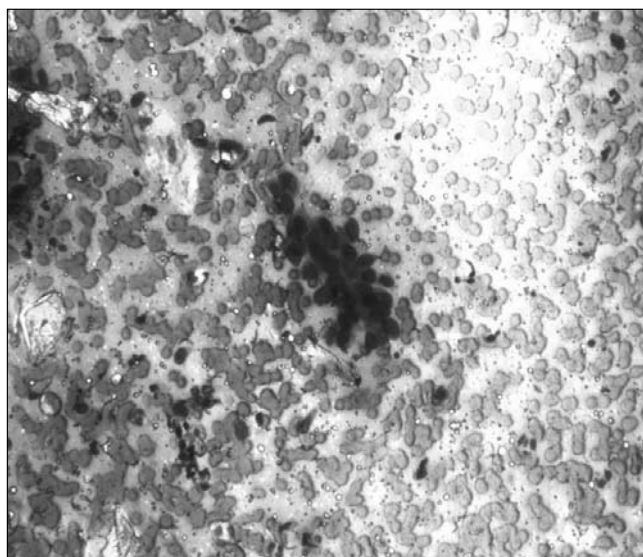


Рисунок 4 – Базалиома.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

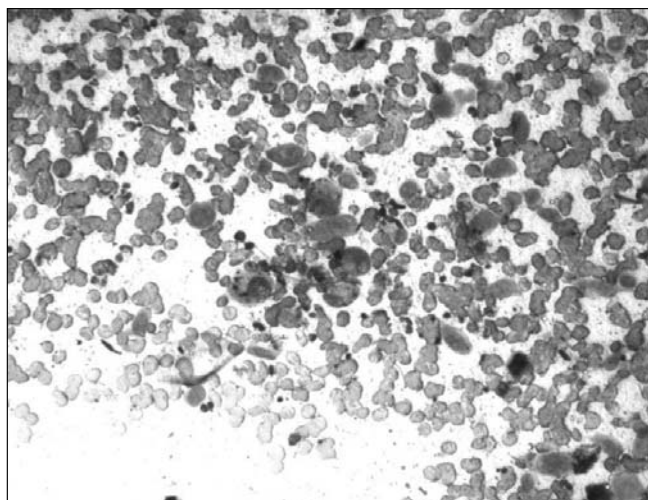


Рисунок 5 – Меланома кожи.
Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

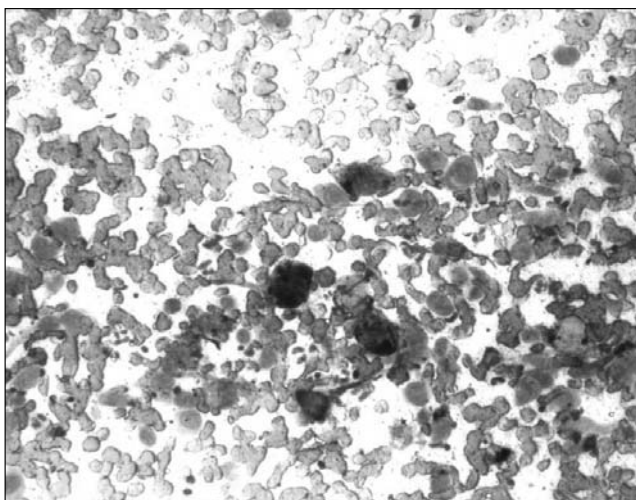


Рисунок 6 – Меланома кожи. Окраска по Паппенгейму. Ув. × 400

Из 12 больных в 8 случаях (66,7%) при цитологическом исследовании картина была представлена полиморфными атипичными эпителиальными клетками, сходными с клетками многослойного плоского эпителия. Клетки опухоли были округлой, овальной, полигональной формы. Ядра клеток полиморфные, с грубым строением хроматина, гиперхромные. Цитоплазма большинства клеток обильная, однородная или слегка зернистая. Клетки располагались разрозненно, группами комплексами. Данная цитогарма была характерна для плоскоклеточного рака кожи.

У 3-х (25%) оперированных больных с краев раны при экспресс-цитологическом исследовании были обнаружены плотные тканевые клочки и комплексы, характерные для базалиомы. Преобладали мелкие, с темной базофильной цитоплазмой клетки. Ядра небольшие, округлой, овальной и вытянутой формы, гиперхромно и диффузно окрашенные. Хроматин ядер грубоглыбчатый. Цитоплазма клеток скудная и неомогенная.

У одного пациента (8,3%) злокачественные клетки обнаруживались со дна послеоперационной раны, которые были представлены крупными клетками округлой, неправильной формы. В единичных клетках определялся пигмент. Ядра клеток были полиморфные, с резко увеличенными ядрышками. Цитоплазма клеток базофильная. Встречались резко полиморфные двуклеточные клетки. Данная картина была характерна для меланомы.

Всем этим больным было повторно произведено иссечение ткани для исследования до полного исчезновения опухолевых клеток.

В послеоперационном периоде на 5-7 сутки наблюдалось осложнение в виде краевого некроза у 4 больных, что объясняется недостаточным кровоснабжением в периферической части лоскута. У остальных больных заживление раны первичным натяжением. При сроке наблюдения через 6-12 месяцев – рецидивов и метастазов не отмечено.

Таким образом, правильная цитологическая диагностика гистогенеза опухолей кожи имеет определяющую роль в выборе тактики лечения. Кроме того, применение субоперационного цитологического исследования на абластичность из краев резекции позволяет провести дальнейшую корригирующую терапию опухолей кожи.

Список литературы

1. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2007 году (статистические материалы). - Алматы, 2007. - 52с.
2. Пустынский И.Н., Шенталь В.В., Пачес А.С. и др. Клинико-морфологические особенности распространенных форм рака кожи // Мат. VI Российской онкологической конф. - М., 2002.
3. Демидов Л.В., Алиев М.Д., Мартынова Е.В. и др. Прогностические факторы в оценке первичной меланомы кожи и их значение для выбора объема оперативного вмешательства // Мат. VIII Российского онкологического конгресса. - М., 2004.
4. Ахметов И.Р., Важенин А.В., Привалов А.В., Анищенко И.С. Меланома кожи: тактика хирургического лечения в отношении регионарных лимфатических узлов (обзор литературы) // Сибирский онкологический журнал. - 2006. - Т.19, №3. - С.68-72.
5. Лемехов В.Т. Эпидемиология, факторы риска, скрининг меланомы кожи // Практическая онкология. - 2001. - Т.8, №4. - С.3-11.
6. Михнин А.Е. Злокачественная меланома кожи: поиски стандартов лечения // Практическая онкология. - 2001. - Т.8, №3. - С.69-72.
7. Барчук А.С. Хирургическое лечение меланом // Практическая онкология. - 2001. - Т.№8, № 4. - С.30-36.
8. Максимова Н.Е., Шабанов А.М. Прогнозирование частоты базалиом. Актуальные проблемы пато- и морфогенеза. Системные аспекты патологии и вопросы преподавания патологической анатомии // Сб. трудов науч. конф., посвященной 100-летию каф. патол. анатомии С-Петерб. гос. мед. ун-в. им. И.П. Павлова. - СПб., 1999. - С.46-47.
9. Савельева А.Е., Ковалев Ю.Н., Важенин Д.В. Факторы риска развития рецидивов базально-клеточного рака кожи лица // Сибирский онкологический журнал. - 2003. - Т.2, №18. - С.14-16.

Тұжырым

Л.Ж.Беламанова

Жергілікті диагностикалық орталығы

Операция үстіндегі абластикалық зерттеудің цитологиялық әдісінің терісінің ісігі кезінде қолданылуы
Тері ісігімен ауырған 40 аурудың интраоперациялық экспресс-цитологиялық әдісі зерттеуінің нәтижелері анализ жасалынған. Цитологиялық зерттеудің нәтижелері емдеудің одан әрі тактикасын амал жарақатынаң абластикадан анықтайды.

Түйінді сөздері: экспресс-цитология, абластика, терінің ісігі

Summary

L.Zh.Belamanova

Regional Diagnostic Centre

Role of cytology method researching ablastica during the surgery with skin tumors

40 patients' with skin tumor intraoperative express

cytology method results were analyzed. Results of cytology research define further treatment according to ablastica of surgery injury.

Key words: express-cytology, ablastica, skin tumor

УДК:618.19.1-616.65.2:615.849.2

К.Ш.Нургазиев, С.Е. Есентаева, Ж.К.Чингисова, Г.Ж.Сейтказина, Г.Т.Сейсенбаева,
Ж.Ж. Жолдыбай, И.Тажединов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Обоснование радионуклидной терапии метастазов в костях рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин в Казахстане

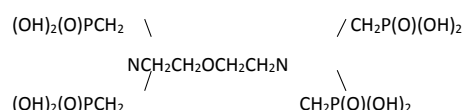
Аннотация. Для планирования радионуклидной терапии (РНТ) с ^{153}Sm -ЭДТМФ, для терапии изучали количество больных раком молочной железы (РМЖ) и раком предстательной железы (РПЖ) с вероятными метастазами в костях по Республике. В 2011 году больные с РМЖ и РПЖ в III и IV стадиях, где больше всего вероятности метастатических очагов в костях, в Центральном регионе составили 3609 больных, Южном — 3463, Восточном — 1256 и Западном — 1054 больной. Сцинтиграфия скелета выявляет метастазы в костях даже их в клинко-рентгенологических «немых» стадиях развития. В Республике больные РМЖ и РПЖ IV стадии 1439 и III стадии 7943, всего 9382 больных в 2011 году 1-2 раза должны были проходить сцинтиграфию скелета. Следовательно, лаборатории радионуклидной диагностики должны открыться во всех областных центрах и крупных городах.

Ключевые слова: рак молочной железы, рак простаты, метастазы, радионуклидная терапия.

В лечении метастазов в костях скелета широко применяется радионуклидная терапия с остеотропными радиофармпрепаратами (РФП). Наиболее часто метастазирует в кость рак молочной железы (РМЖ) у женщин и рак предстательной железы (РПЖ) у мужчин. Реже метастазируют в кость рак щитовидной железы, рак легкого, рак почки, меланома и миелома. Еще реже в кость могут метастазировать опухоли других локализаций.

Радионуклидную терапию (РНТ) можно отнести к системной радиотерапии, основанной на способности некоторых «чистых» β -излучающих или «смешанных» радионуклидов (^{90}Y , ^{186}Re , ^{188}Re , $^{117\text{m}}\text{Sn}$, ^{153}Sm , ^{89}Sr), а также ими меченых остеотропных РФП, накапливающихся в метастатических очагах, главным образом, остеобластического и смешанного характера, предварительно визуализируемых при диагностическом сканировании костей скелета (Наркевич Б.Я., Ширяев С.В., 2003; Ядерная медицина, 2008; Liepe K, Kotzerke J., 2007 [1, 2, 3].

^{153}Sm является β -эмиттером с высоким коэффициентом линейной передачи энергии и малой глубине поглощения; разрушает и уничтожает больные клетки в целом организме. Наличие в спектре γ -излучения позволяет провести сцинтиграфию скелета и определение степени накопления, а также и характер распределения препарата в патологических очагах и необходимые для вычисления дозы. РНТ с ^{153}Sm -ЭДТМФ [1, 2, 3].



^{153}Sm -ЕДТМФ (EDTMP)

– Ethylenediaminetetramethylenphosphonat

Применяется высокими дозами в терапии (паллиативная) болевого синдрома при костных метастазах. Препарат применяется при прогрессирующем обширном метастазировании в кости, когда другие методы по подавлению боли не дают желаемого эффекта. Эффект наступает в 60-90% через несколько дней с длительностью до полугода. Осложнения или побочные эффекты, связанные с применением терапевтической дозы ^{153}Sm -ЕДТМФ, не бывают. Если медицинских противопоказаний нет, лечение можно проводить в амбулаторных условиях (Morris M. Et al., 2008, McGregor B. et al., 1978, O'Donoghue EP et al., 1978) [4, 5, 6].

В Институте ядерной физики РК налажено производство Этилендиаминтетраметилефосфонат (ЭДТМФ) меченый ^{153}Sm , предназначенный для терапии метастазов рака в кости. В ближайшее время планируются экспериментальные исследования « ^{153}Sm -ЭДТМФ, для терапии» на крысах. « ^{153}Sm -ЭДТМФ, для терапии» – стерильный, бесцветный раствор. ^{153}Sm -ЭДТМФ в литературе известен еще под названием оксабифор. Выпускается с объемной активностью не менее 37 МБк/мл. Введенный внутривенно 0,4-0,8 ГБк ^{153}Sm -ЭДТМФ, поступая в организм с кровью, накапливается в костной ткани скелета. ^{153}Sm распадается с $T_{1/2}=46,8$ часа (1,95 суток). В момент β^- распада атом ^{153}Sm испускает спектр β -излучения (0,63МэВ -26%; 0,70 МэВ -53%; 0,80 МэВ-20%) из которого складается лечебный эффект. Спектр γ -излучения: $E_\gamma=0,07$ МэВ-4% и рабочая энергия для визуализации (сцинтиграфия на гамма-камере) – $E_\gamma=0,103$ МэВ (28%).

Для планирования РНТ с ^{153}Sm -ЕДТМФ по Республике необходимо определить количество больных с метастатическими поражениями костей скелета. Притом, важно знать количество пациентов, состоявших на учете и вновь выявленных с разными показателями метастазирования в костях. Среди пациентов, состоящих на учете, чаще встречаются с метастазами в костях, чем среди впервые выявленных больных. При III и IV стадиях заболевания чаще встречаются метастазы в костях с показаниями к РНТ. Остеосцинтиграфия остается наиболее чувствительным методом диагностики метастазов в костной ткани, превосходя по эффективности клинические проявления,

рентгенографию скелета, уровень щелочной фосфатазы в сыворотке [6, 7].

В таблице 1 приведено число больных с диагнозом РМЖ в 2011 году по областям, а также по городам Астаны и Алматы. Поскольку, в планировании РНТ необходимы абсолютные показатели, в таблице приведены абсолютные числа больных, состоящих на учете (4 столбец) и вновь выявленных больных (7), в том числе III и IV стадиях (5 и 8) РМЖ. Самые высокие показатели были г. Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областях. Средние числа больных имелись в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актыбинской и Жамбылской областях, а также г. Астана. В Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях показатели были низкими.

Если условно разделить Республику на 4 региона (2 столбец), больные, состоящие на учете (6) и вновь выявленные (9) а также III и IV стадиях РМЖ в 2011 году по регионам приведены в табл. 1. В столбце 10 таблицы суммировано количество больных РМЖ и РПЖ в III и IV стадиях по регионам. Эти показатели в Южном и Центральном регионах были высокими, средние – Восточном, ниже среднего Западном регионе. В Центральном регионе общее количество больных составило 10153 (33,7%), из них 2512 в III и 269 IV стадиях; в Южном регионе из 10719 (35,6%) больных у 2299 III и 353 IV стадиях. Из 5721 (19%) больные с Восточного региона у 699 III и 274 – IV стадиях заболеваний. В Западном регионе из 3547 (11,8%) больных 819 в III и 116 в IV стадиях РМЖ. В Республике, в итоге, из 30140 (100%) больных РМЖ у 6402 с III и у 1069 IV стадиями заболевания.

Таблица 2 составлена, по выше использованному принципу, для больных с РПЖ. Самые высокие показатели были г. Алматы, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Алматинской областей. Средние числа больных имелись в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской, г. Астана, Акмолинской, Северо-

Казахстанской областях. Жамбылской, Актыбинской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях показатели были низкими.

Количество больных РПЖ по регионам, а также из них число больных с III и IV стадиях заболевания суммировано в столбце 10 табл. 2. В Южном и Центральном регионах эти показатели были высокими, средние – Восточном, низкие Западном регионе. В Центральном регионе общее количество больных составило 1266 (33,5%), из них 638 в III и 190 IV стадиях. В Южном регионе из 1274 (34,7%) больных у 700 III и 111 IV стадиях РПЖ. Из 747 (20,4%) больного с Восточного региона у 192 III и 91 – IV стадиях заболевания. В Западном регионе из 383 (10,4%) больных 85 в III и 85 в IV стадиях РМЖ. В Республике из 3670 (100%) больных у 1615 в III и у 427 в IV стадиями РПЖ.

В итоговой табл. 3 приведены абсолютные числа больных с РМЖ и РПЖ по регионам. РМЖ и РПЖ в IV стадиях, где больше всего вероятности метастатических очагов в костях, в Центральном регионе составили 459 больных, Южном – 464, Восточном – 365 и Западном – 151 больной. В Республике больные в IV стадии составляют 1439. В действительности эти цифры должны быть намного больше.

Для определения истинной распространенности этих патологий необходимо проведение радионуклидной визуализации – ОФЭКТ-сканирования всего скелета с остеотропным РФП, которое проводится только в Алматы и Астане, и то не в полную нагрузку из-за нехватки препаратов и не регулярной работы лаборатории. В других регионах вовсе не производится ОФЭКТ-сканирование, из-за отсутствия лаборатории радионуклидной диагностики.

Общеизвестно, что скитиграфия скелета выявляет метастазы в костях в клинко-рентгенологических «немых» стадиях развития. Среди больных с III стадией, приведенные в табл. 3 имеются больные с метастазами в костях, т. е. в истине у них IV стадия. Нуждающихся в скитиграфии скелета в Республике составляют в IV стадии 1439 и III стадии 7943 больных. Всего только РМЖ

Таблица 1 – Больные с диагнозом РМЖ, состоящие на учете и вновь выявленные в 2011 году по регионам

№	Регионы	Области и города	Контин. на учете	Из них III-IV ст.	По регионам	Первичный	Из них III-IV ст.	По регионам	Итого по регионам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Центральный	г. Астана	1111	364-22	8974 (Из них III-IV ст 2219-197)	158	33 – 10	1179 (293-72)	10153-33,7% III–2512 IV–269
		Акмолинская	1405	609-14		160	68 – 2		
		С-Казахстанская	1465	274-19		194	35 – 3		
		Костанайская	1779	257-55		245	49 – 16		
		Карагандинская	3214	715-87		422	108 – 41		
2	Южный	г. Алматы	4035	864-92	9462 (2092-286)	472	85 – 12	1257 (207-67)	10719-35,5% III–2299 IV–353
		Алматинская	2069	576-76		247	51 – 17		
		Жамбылская	1017	265-36		164	24 – 12		
		Ю-Казахстанская	1799	285-61		287	34 – 17		
		Кызылординская	542	102-21		87	13 – 9		
3	Восточный	В- Казахстанская	3237	306-41	5111 (699-57)	370	20 – 151	610 (73-274)	5721-19% III–699 IV–274
		Павлодарская	1874	393-16		240	53 – 123		
4	Западный	Актюбинская	1032	304-49	3093 (740-92)	172	38 – 11	454 (79-24)	3547-11,8% III–819 IV–116
		З-Казахстанская	1189	186-24		137	21 – 4		
		Атырауская	479	93-8		84	3 – 4		
		Мангистауская	393	157-11		61	17 – 5		
По Республике			26640	(5750-632)	26640 (5750-632)	3500	662 – 437	3500 (652-437)	30140-100% III–6402 IV–1069

Таблица 2 – Больные с диагнозом РПЖ, состоящие на учете и вновь выявленные в 2011 году по регионам

№	Регионы	Области и города	Контингент на учете	Из них III-IV ст	По регионам	Первичный	Из них III-IV ст.	По регионам	Итого по регионам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Центральный	г. Астана	132	36-9	990 (512-126)	28	5 + 3	276 (126-64)	1266-34,5% III-638 IV-190
		Акмолинская	126	42-12		37	11 + 6		
		С-Казахстанская	119	61-10		39	21 + 7		
		Костанайская	296	181-17		79	50 + 9		
		Карагандинская	317	192-78		93	39 + 39		
2	Южный	г. Алматы	552	307-35	984 (540-70)	140	76 + 22	290 (160-41)	1274-34,7% III-700 IV-111
		Алматинская	201	96-30		57	20 + 15		
		Жамбылская	73	33-5		37	20 + 2		
		Ю-Казахстанская	132	95-0		46	41 + 1		
		Кызылординская	26	9-0		10	3 + 1		
3	Восточный	В- Казахстанская	428	130-25	583 (159-52)	123	29 + 23	164 (33-39)	747-20,4% III-192 IV-91
		Павлодарская	155	29-27		41	4 + 16		
4	Западный	Актюбинская	63	27-5	295 (65-25)	21	6 + 2	88 (20-10)	383-10,4% III-85 IV-35
		З-Казахстанская	181	21-15		55	10 + 6		
		Атырауская	26	12-2		4	1 + 1		
		Мангистауская	25	5-3		8	3 + 1		
По Республике			2852	1276-273	2852 (1276-273)	818	339 + 154	818 (339-154)	3670-100% III-1615 IV-427

Таблица 3 – Больные с возможными метастазами в костях РМЖ и РПЖ, среди состоящих на учете и вновь выявленных в 2011 году по регионам

№	Регионы – админ. или условн. центры регионов	Всего РМЖ по регионам	Всего РПЖ по регионам	РМЖ и РПЖ в IV и III стадиях
1	Центральный – Астана	10153-33,7% III-2512 IV-269	1266-34,5% III-638 IV-190	IV- 459 III-3150
2	Южный – Алматы	10719-35,5% III-2299 IV-353	1274-34,7% III-700 IV-111	IV- 464 III – 2999
3	Восточный – Семей	5721-19% III-699 IV-274	747-20,4% III-192 IV-91	IV- 365 III – 891
4	Западный – Актобе	3547-11,8% III-819 IV-116	383-10,4% III-85 IV-35	IV- 151 III – 903
	По республике	30140-100% III-6402 IV-1069	3670-100% III-1615 IV-427	IV-1439 III – 7943

и РПЖ 9382 больные должны проходить скintiграфию скелета 1-2 раза в год, независимо от отсутствия боли в костях. В тоже время больные с другими формами злокачественного роста с жалобами боли в костях также нуждаются в скintiграфии скелета. Следовательно, в полной мере обеспечение скintiграфией скелета значительно повышает количество нуждающихся в РНТ больных с метастазами в костях.

Как базовый метод в Ядерной медицине, лаборатории радионуклидной диагностики должны открываться во всех областных центрах и крупных городах. Все Центры ядерной медицины, которые состоят из лаборатории радионуклидной диагностики, ПЭТ-отделения и отделения РНТ, должны находиться при онкологических учреждениях и должны быть базами кафедр медицинских ВУЗ-ов Республики. Преподавать должны сотрудники ЦЯМ.

Список литературы

- 1 Наркевич Б.Я., Ширяев С.В. Методические основы радионуклидной терапии // Мед. радиол. и радиац. безопасность. - 2003. - Т. 49, № 5. - С. 35 - 44.
- 2 Радионуклиды для терапии / В кн.: Ядерная медицина. Учебное пособие. I часть. Перевод с немец. Под ред. к.м.н. О.Е. Шлыгиной, А.Р. Борисенко. - Алматы, 2008. - С. 38-39.
- 3 Терапия открытыми радиоактивными веществами / В кн.: Ядерная медицина. Учебное пособие. II часть. Перевод с немец. Под ред. к.м.н. О.Е. Шлыгиной, А.Р. Борисенко. - Алматы, 2008. - С. 273-278.
- 4 K.Liepe, Kotzerke J. A comparative study of ^{188}Re -HEDP, ^{186}Re -HEDP, ^{153}Sm -EDTMP and ^{89}Sr in treatment of painful skeletal metastases // Nucl. Med. Commun. - 2007. - Vol. 28, N8. - С. 623-30.
- 5 Morris M., Pandit-Taskar Stephenson R. et al. Phase I study of docetaxel (Tax) and ^{153}Sm repetitively administered for castrate metastatic prostate cancer (CMPC) // J. Clin. Oncol. - 2008. - Vol. 26,

(15S).

6 McGregor B., Tulloch A.G., Quinlan M.F., Lovegrove F. The role of bone scanning in the assessment of prostatic carcinoma // Br. J. Urol. - 1978. - Vol.50, N 3. - С.178-81.

7 O'Donoghue E.P., Constable A.R., Sherwood T., Stevenson J.J. Bone scanning and plasma phosphatases in carcinoma of the prostate // Br. J. Urol. - 1978. - Vol.50, N 3. - С.172-177.

Тұжырым

К.Ш.Нургазиев, С.Е.Есентаева, Ж.К.Чингисова, Г.Ж.Сейтказина, Г.Т.Сейсенбаева, Ж.Ж.Жолдыбай, И.Тажединов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қазақстандағы әйелдердің сүт безі қатерлі ісігінің сүйектегі метастазы және ер адамдардағы қуық үсті безінің радионуклидты терапиясын зерттеу негізі.

«¹⁵³Sm - ЭДТМФ, емдеуге арналған» - мен радионуклеидті емді жобалау үшін Республика бойынша Сүйекке метастаз беруі Мүмкін Сүт безінің қатерлі ісігімен және қуық асты безінің қатерлі ісігімен ауыратын науқастар саны зерттелді. 2011 жылы, Сүйекке метастаз беру Мүмкіндігі жозары, Сүт безінің қатерлі және қуық асты безінің қатерлі ісігінің III және IV сатысымен ауыратын науқастар саны Орталық аймақта 3609 науқасты құрады, Оңтүстікте - 3463, Шығыста - 1256 және Батыста - 1054 науқасты құрады. Скелеттің сцинтиграфиясы Сүйектегі метастаз ошақтарын олардың клинико-рентгенологиялық керінбейтін сатыларында анықтайды. Республика бойынша Сүт безінің қатерлі ісігінің және қуық асты безінің қатерлі ісігінің IV сатысымен ауыратын науқастар саны 1439 және III сатысымен ауыратын науқастар саны 7943, барлығы 2011 жылы 9382 науқас 1-2 рет скелет сцинтиграфия-

сын ету керек болатын. Демек, радионуклеидті анықтау зертханалары барлық облыс орталықтарында және ірі қалаларда ашылуы керек.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, қуық үсті безінің қатерлі ісігі, метастаз, радионуклидты терапия.

Summary

K.S. Nurgaziev, S.E. Yesentayeva, Z.K. Chingissova, G.Z. Seytkazina, G.T. Seysenbaeva, Z.Z. Zholdybai, I. Tazhedinov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Rationale for radionuclide therapy of bone metastases of breast cancer in women and prostate cancer in men in Kazakhstan

For planning of radio nuclide therapy (RNT) with “¹⁵³Sm-EDTMP, for therapy» studied number of patients with cancer of breast cancer (BC) and the cancer of prostatic carcinoma (PC) with probable in bone metastases on the Republic. In 2011 patients with BC and PC in III and the IV stages where most of all probabilities of the bone metastases centers in, in the Central region made 3609 patients, South - 3463, East - 1256 and Western - the 1054 th patient. Scintigraphy of a skeleton reveals metastases in bones even them in kliniko-radiological «mute» stages of development. In the Republic patients with BC and PC in the IV stage 1439 and the III stages 7943, only 9382 patients in 2011-2 times had to pass a skeleton scintigraphy. Therefore, laboratories of radio nuclide diagnostics have to open in all regional.

Keywords: breast cancer, prostate cancer, metastasis, radionuclide therapy.

Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований Алматы, 2012

Клинический протокол «Рак молочной железы»

1. Название протокола: Рак молочной железы
2. Код протокола
3. Код МКБ: С 50 (Злокачественное новообразование молочной железы):

1. Сосок (С 50.0).
2. Центральная часть (С 50.1).
3. Верхневнутренний квадрант (С 50.2).
4. Нижневнутренний квадрант (С 50.3).
5. Верхненаружный квадрант (С 50.4).
6. Нижненаружный квадрант (С 50.5).
7. Подмышечный хвост (С 50.6).

4. Список сокращений:

РМЖ – рак молочной железы
ОК – оральные контрацептивы
ГЗТ –гормон-заместительная терапия
РЭ – рецептор эстрогена
РП – рецептор прогестерона
ЭКГ – электрокардиография,
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АСТ – аспартатаминотрансфераза
УЗИ – ультразвуковое исследование,
MTS – метастаз,
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
RW – реакция Вассермана
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ГЭБ – гемато-энцефалический барьер
ПХТ – полихимотерапия
ЛТ – лучевая терапия
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
ОГК – органы грудной клетки
КТ – компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография

5. Определение

РМЖ - самая частая опухоль у женщин, относящаяся к классическим гормонообусловленным онкологическим заболеваниям, - развивается в органе, являющемся частью репродуктивной системы организма. Эти опухоли происходят из эпителиальной ткани протоков или долек молочной железы - «мишени» для гормонов, вырабатываемых яичниками (эстрогены и прогестины).

В среднем в Республике Казахстан ежегодно выявляется около 3000 больных раком молочной железы, из которых умирают более 1380 женщин. В частности, в 2011 году зарегистрировано 3525 случаев рака молочной железы, что составило 11,6 на 100000 населения. Летальность на 1 году жизни составляет 8%, а 5-летняя выживаемость 52,93%.

6. Дата разработки протокола: 2011г.

7. Категория пациентов: больные с опухолями молочных желез.

8. Пользователи протокола: районколог, врач-онколог поликлиники диспансера, врач-онколог стационара диспансера.

9. Указание на отсутствие конфликта интересов:

Не имеем финансовую или другую заинтересованность в теме обсуждаемого документа - Не имели в последние 4 года отношение к продаже, производству или распространению препаратов, оборудования и т.п.

10. Международная классификация TNM

VII пересмотр от декабря 2009 г.

В настоящее время используется классификация опухолей по системе TNM международного противоракового союза (2002 г.). Стадия рака устанавливается при первичном обследовании больной, а затем уточняется после операции (pTNM). Классификация относится только к карциномам и касается как мужской груди, так и женской молочной железы.

В случае наличия первично-множественных синхронных опухолей в одной молочной железе, для классификации должна быть взята опухоль с самой высокой категорией Т. Синхронные двусторонние опухоли молочной железы, должны классифицироваться независимо друг от друга, чтобы дать возможность разделения случаев по гистологическому типу.

Для оценки категорий Т, N и M должны использоваться следующие методы:

Категория Т – физикальное исследование и визуализация, например маммография.

Категория N – физикальное исследование и визуализация.

Категория M – физикальное исследование и визуализация.

Анатомические области:

1. Сосок (С 50.0).
2. Центральная часть (С 50.1).
3. Верхневнутренний квадрант (С 50.2).
4. Нижневнутренний квадрант (С 50.3).
5. Верхненаружный квадрант (С 50.4).
6. Нижненаружный квадрант (С 50.5).
7. Подмышечный хвост (С 50.6).

Регионарные лимфоузлы:

1. Подмышечные (ипсилатеральные), межгрудные узлы (Роттера) и лимфоузлы вдоль подмышечной вены и ее ветвей, которые могут быть разделены на следующие

уровни:

а) Уровень I (нижняя часть подмышечной ямки): лимфоузлы, расположенные латерально по отношению к латеральной границе малой грудной мышцы.

б) Уровень II (средняя часть подмышечной ямки): лимфоузлы, расположенные между медиальной и латеральной границами малой грудной мышцы, и межгрудные лимфоузлы (Роттера).

в) Уровень III (верхушечная часть подмышечной ямки): апикальные лимфоузлы и узлы, расположенные медиально по отношению к медиальному краю малой грудной мышцы, за исключением тех, которые определяются как подключичные.

Примечание. Внутримаммарные лимфоузлы кодируются как подмышечные лимфоузлы.

2. Подключичные (ипсилатеральные) лимфоузлы.

3. Внутримаммарные (ипсилатеральные) лимфоузлы: лимфоузлы в межреберных областях по краю грудины в эндоторакальной фасции.

4. Надключичные (ипсилатеральные) лимфоузлы.

Метастазы в любых других лимфоузлах определяются как отдаленные метастазы (M1), включая шейные или контралатеральные внутримаммарные лимфоузлы.

Под символами TNM подразумевают:

T – первичная опухоль

Tx	недостаточно данных для оценки первичной опухоли
T0	опухоль в молочной железе не определяется
Tis	прединвазивная карцинома (carcinomain situ)
	Tis(DCIS) – протоковая карцинома in situ
	(LCIS) – дольковая карцинома in situ
	Tis(Paget) – болезнь Педжета (соска) без опухоли
	Примечание: Болезнь Педжета с наличием опухоли классифицируется в соответствии с размерами опухоли
T1	опухоль не более 2 см в наибольшем измерении
T1mic	микроинвазия до 0,1 см в наибольшем измерении
	Примечание. Микроинвазией считают распространение раковых клеток за пределы базальной мембраны с очагами менее 0,1 см.
	Если очаги микроинвазии множественные, классифицируется наибольший по размеру очаг (нельзя суммировать размеры микроочагов). Наличие множественных очагов микроинвазии следует отмечать дополнительно
T1a	опухоль более 0,1 см, но не более 0,5 см в наибольшем измерении
T1b	опухоль более 0,5 см, но не более 1 см в наибольшем измерении
T1c	опухоль более 1 см, но не более 2 см в наибольшем измерении
T2	опухоль более 2 см, но не более 5 см в наибольшем измерении
T3	опухоль более 5 см в наибольшем измерении
T4	опухоль любого размера с прямым распространением на грудную стенку или кожу
	Примечание. Грудная стенка включает ребра, межреберные мышцы и переднюю зубчатую мышцу, но не грудную мышцу
T4a	распространение на грудную стенку
T4b	отек (включая «лимфатическую корочку»), или изъязвление кожи молочной железы, или сателлиты в коже молочной железы
T4c	признаки, перечисленные в 4a и 4b вместе
T4d	воспалительная форма рака молочной железы

Примечание: Воспалительная карцинома молочной железы характеризуется диффузной бурой индурацией кожи с

эризилоидным краем, обычно без подлежащей массы. Если биопсия кожи указывает на отсутствие вовлеченности в процесс и нет локализованного, с определяемыми размерами первичного рака, категория T есть pTx при патогистологическом стадировании воспалительной карциномы (T4d). Кожа, покрытая ямочками, втяжение соска или другие изменения кожи, за исключением тех, что бывают при T4b и T4d, могут оцениваться как T1, T2, или T3, не влияя при этом на классификацию.

N – регионарные лимфатические узлы

N _x	недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов
N ₀	нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов
N1	метастазы в смещаемых подмышечных лимфатических узлах (e) на стороне поражения
N2	метастаз в неподвижном ипсилатеральном подмышечном лимфатическом узле (ax) или в клинически явном ипсилатеральном внутримаммарном лимфоузле (ax) при отсутствии клинически явных метастазов в подмышечных лимфоузлах
	метастаз в подмышечном лимфатическом узле (ax), сцепленных друг с другом или с другими структурами
	метастаз только в клинически явном внутримаммарном лимфоузле (ax) при отсутствии клинически явного метастаза в подмышечном лимфоузле
N2a	
N2b	
N3	метастаз в ипсилатеральном подключичном лимфатическом узле (ax) с поражением подмышечных лимфоузлов или без них; или в клинически явном ипсилатеральном внутримаммарном лимфоузле(ax) при наличии клинически явных метастазов в подмышечных лимфоузлах; или метастаз в ипсилатеральном надключичном лимфоузле(ax) с поражением подмышечных или внутримаммарных лимфоузлов или без них
N3 _a	метастаз в подключичном лимфоузле (ax)
N3b	метастазы во внутримаммарных и подмышечных лимфоузлах
	метастаз в надключичном лимфоузле (ax)
N3c	
	Примечание. «Клинически явные» означает выявленные в результате клинического исследования или применения средств визуализации (за исключением лимфосцинтиграфии)

M – отдаленные метастазы

M _x	данных для суждения о наличии отдаленных метастазов недостаточно
M0	признаков отдаленных метастазов нет
M1	имеются отдаленные метастазы

Категории M1 и pM1 могут быть более уточнены в соответствии со следующими условными обозначениями:

Легкие	PUL	Костный мозг	MAR
Кости	OSS	Плевра	PLE
Печень	HEP	Брюшина	PER
Мозг	BRA	Надпочечники	ADR
Лимфоузлы	LUM	Кожа	SKI
Другие	OTN		

pTNM патогистологическая классификация

pT – первичная опухоль

Для патогистологической классификации требуется исследование первичной карциномы при отсутствии ма-

кроскопической опухоли по краям резекции. Случай можно классифицировать как pT, если по краю имеется только микроскопическая опухоль.

Категории pT соответствуют категориям T.

Примечание. При классификации pT размер опухоли есть величина инвазивного компонента. Если имеется большой компонент *in situ* (например, 4 см) и малый инвазивный компонент (например, 0,5 см), опухоль классифицируется как pT1a.

pN – регионарные лимфатические узлы

Для гистопатологической классификации может быть предпринято исследование одного или более сторожевых лимфоузлов. Если классификация основывается только на биопсии сторожевого лимфоузла без последующей диссекции подмышечных лимфоузлов, то ее следует обозначать (sn) (sentinel node – сторожевой узел), например: pN1 (sn).

pN1 _{mi}	микрочелюсть (более 0,2 мм, но не больше 2 мм в наибольшем измерении)
PN1	метастазы в 1–3 ипсилатеральных подмышечных лимфоузлах (е) и/или в ипсилатеральных внутримаммарных узлах с микроскопическими метастазами, выявленными в результате диссекции сторожевого лимфоузла, но клинически не явными
pN1 _a	метастазы в 1–3 подмышечных лимфоузлах (е), среди них, по крайней мере, один более 2 мм в наибольшем измерении
pN1 _b pN1c	внутримаммарные лимфоузлы с микроскопическими метастазами, выявленными в результате диссекции сторожевого лимфоузла, но клинически не явными. Метастазы в 1–3 подмышечных лимфоузлах и внутримаммарных лимфоузлах с микроскопическими метастазами, выявленными в результате диссекции сторожевого лимфоузла, но клинически не явными
pN2	метастазы в 4–9 ипсилатеральных подмышечных лимфоузлах или в клинически явных ипсилатеральных внутримаммарных лимфоузлах при отсутствии метастазов в подмышечных лимфоузлах
	Примечание. «Клинически не явные» означает не выявленные в результате клинического исследования или применения средств визуализации (за исключением лимфосцинтиграфии); «клинически явные» означает выявленные в результате клинического исследования или применения средств визуализации (за исключением лимфосцинтиграфии), или макроскопически визуальные
pN2 _a	метастазы в 4–9 подмышечных лимфоузлах, среди них, по крайней мере, один размером более 2 мм
pN2 _b	метастаз в клинически явном внутримаммарном лимфоузле (ах) при отсутствии метастазов в подмышечных лимфоузлах
pN3	метастазы в 10 или более ипсилатеральных подмышечных лимфоузлах; или в ипсилатеральных подключичных лимфоузлах; или в клинически явных ипсилатеральных внутримаммарных лимфоузлах при наличии одного или более пораженных подмышечных лимфоузлов; или в более чем 3 подмышечных лимфоузлах с клинически не явными микроскопическими метастазами во внутримаммарных лимфоузлах; или в ипсилатеральных надключичных лимфоузлах
pN3a	метастазы в 10 или более подмышечных лимфоузлах (по крайней мере, один из них больше 2 мм) или метастазы в подключичных лимфоузлах

pN3b	метастаз в клинически явном внутримаммарном лимфоузле (ах) при наличии пораженного подмышечного лимфоузла (ов); или метастазы в более чем 3 подмышечных лимфоузлах и во внутримаммарных лимфоузлах с микроскопическим метастазом, выявленным при диссекции сторожевого лимфоузла, но клинически не явным
pN3c	метастаз в надключичном лимфоузле (ах)

pM – отдаленные метастазы. Категории pM соответствуют категориям M.

G гистопатологическая классификация

G1 – высокая степень дифференцировки.

G2 – средняя степень дифференцировки.

G3 – низкая степень дифференцировки.

R классификация

Отсутствие или наличие остаточной опухоли после лечения описывается символом R. Определения R классификации:

RX – наличие остаточной опухоли не может быть установлено.

R0 – остаточная опухоль отсутствует.

R1 – микроскопическая остаточная опухоль.

R2 – макроскопическая остаточная опухоль.

Группировка по стадиям

Стадия 0	Tis	N0	M0
Стадия I	T1*	N0	M0
Стадия IIA	T0	N1	M0
	T1*	N1	M0
	T2	N0	M0
Стадия IIB	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
Стадия IIIA	T0	N2	M0
	T1*	N2	M0
	T2	N2	M0
	T3	N1, N2	M0
Стадия IIIB	T4	N0, N1, N2	M0
Стадия IIIC	любая T	N3	M0
Стадия IV	любая T	любая N	M1

Примечание: *T1 включает T1mic (микроинвазия 0,1 см или менее в наибольшем измерении).

Tis	In situ
T1	> 2см
T1mic	> 0,1 см
T1a	> 0,1 до 0,5 см
T1b	> 0,5 до 1 см
T1c	> 1 до 2 см
T2	> 2 до 5 см
T3	> 5 см
T4	грудная стенка/кожа
T4a	грудная стенка
T4b	отек кожи/изъязвление, сателлитные узелки на коже

T4c	признаки, характерные для T4a и T4b
T4d	воспалительная карцинома

N1	Подвижные подмышечные	pN1mi pN1a pN1b pN1c	Микрометастазы, > 0,2 мм ? 2 мм 1–3 подмышечных узла внутриmamмарные узлы с микрометастазом, выявленном при биопсии сторожевого узла, но клинически неопределяемом 1–3 подмышечных узла внутри-mamмарные узлы с микрометастазом, выявленном при биопсии сторожевого узла, но клинически неопределяемом
N2a	Неподвижные подмышечные	pN2a	4–9 подмышечных узлов
N2b	Внутриmamмарные клинически определяемые	pN2b	Внутриmamмарные узлы, клинически определяемые без подмышечных узлов
N3a	pN3a	pN3a	> 10 подмышечных узлов или подключичный узел (узлы)
N3b	Внутриmamмарные и подмышечные	pN3b	Внутриmamмарные узлы, клинически определяемые с подмышечным узлом (узлами) или > 3 подмышечных узлов и внутри-mamмарных узлов с микрометастазами, которые выявляются при биопсии с е н т и н е л ь н о г о (сторожевого узла), но клинически неопределяемых
N3c	Надключичные	pN3c	Надключичные

Гистологическая классификация опухолей молочной железы

В настоящее время принято использовать гистологическую классификацию Международного противоракового союза (2002 г., 6-е издание).

A	Неинвазивный рак (in situ):
	Внутрипротоковый (интраканаликулярный) рак in situ;
	дольковый (лобулярный) рак in situ
B	Инвазивный рак (инфильтрирующая карцинома):
	протоковый;
	дольковый;
	слизистый (муцинозный);
	медуллярный (мозговидный);
	тубулярный;
	апокриновый;
	другие формы (папиллярный, плоскоклеточный, ювенильный, веретенноклеточный, псевдосаркоматозный и др.).
C	Особые (анатомо-клинические) формы:
	рак Педжета;
	воспалительный рак

Чаще всего у больных встречается инвазивный протоковый рак (50–70%), затем дольковый (20%). Протоковый рак характеризуется более частым распространением по молочным ходам, а дольковый –

первичной множественностью и двусторонностью.

В 2011г StGallen была утверждена классификация по фенотипу

С точки зрения биологических особенностей, определяющих возможности лечения, все больные РМЖ делятся на:

№	Фенотипы	Описание
1	Люминальный А	Опухоли с положительными рецепторами стероидных гормонов и отсутствием экспрессии и амплификации Her-2/neu (в лечение данной группы больных, как правило используется ГТ)
2	Люминальный В	Опухоли с положительными рецепторами стероидных гормонов, отрицательным статусом Her-2/neu, но высоким (>14%) индексом ki67 Опухоли с положительными рецепторами стероидных гормонов (РЭ(+), РП(+)) и гиперэкспрессией или амплификацией Her2/neu (Этим больным показано лечение трастузумабом, гормонами и химиопрепаратами)
3	Трижды негативный	Опухоль не содержит ни рецепторов стероидных гормонов, ни гиперэкспрессии Her2/neu статуса. (В этом случае наиболее целесообразна цитостатическая ХТ)
4	Her-позитивный	Опухоли с гиперэкспрессией или амплификацией Her-2/neu и отрицательными рецепторами эстрогенов и прогестерона. Этой категории пациентов показана химиотаргетная терапия

11. Показания для госпитализации

- Наличие верифицированной опухоли молочной железы.
- Наличие убедительных маммографических, УЗИ данных опухоли молочной железы.
- Относительно удовлетворительное состояние больного.

12. Клиническая диагностика рака молочной железы

12.1. Жалобы

На наличие образование в молочной железе, увеличение подмышечных, над- и подключичных лимфатических узлов, Наличие кожных изменений на молочной железе, отечность молочной железы.

12.2. Анамнез (наличие онкологических заболеваний у близких родственников, начало месячных, возраст первой беременности и первых родов, прием ОК или ГЗТ, гинекологические заболевания).

12.3. Осмотр молочных желез. При осмотре определяют: – симметричность расположения и форму молочных желез;

– уровень стояния сосков и их вид (втяжение, отклонение в сторону);

– состояние кожи (гиперемия, отек, морщинистость, втяжения или выпячивания на ней, сужение ареолярного поля и т.д.);

– патологические выделения из соска (количество,

цвет, длительность);

- наличие отека руки на стороне поражения.
- Пальпация молочных желез (в вертикальном и горизонтальном положениях).
- Пальпация регионарных и шейно-надключичных лимфатических узлов (как правило, производят в вертикальном положении).

12.4. Инструментальные обследования

– Рентгенологическая диагностика является одним из ведущих методов выявления рака молочной железы, особенно если опухоль небольших размеров и не пальпируется.

– Маммография показана всем больным раком молочной железы.

Методы обследования, которые необходимо выполнить больной до начала лечения:

- а) трепан-биопсия с определением уровня экспрессии ЭР, ПР, Her-2/neu, ki67 и других генетических факторов;
- б) ультразвуковое исследование органов брюшной полости;
- в) рентгенологическое исследование легких;
- г) остеосцинтиграфия (в учреждениях, оснащенных радиоизотопной лабораторией);
- д) ультразвуковое исследование молочных желез, регионарных лимфоузлов.

Маммография и УЗИ дополняют друг друга, т.к. при маммографии могут быть видны опухоли, которые не определяются при УЗИ, и наоборот.

12.5 Лабораторные исследования

Лабораторные исследования, которые необходимо выполнять при первичном обращении больной до начала лечения:

- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Биохимическое исследование крови
- Коагулограмма
- ЭКГ
- рентгенографическое исследование органов грудной клетки;

– Кровь на ВИЧ

– Кровь на RW

– Кровь на гепатит В и С

– Группа крови и резус-фактор

12.6 Морфологическая диагностика

1. Цитологическая (пункционная) биопсия (тонкоигольная биопсия).

2. Трепан-биопсия или секторальная резекция молочной железы

12.7 Показания для консультации онколога

Наличие опухолевого образования молочной железы. Наличие рентгенологических данных опухолевого поражения молочной железы.

Дифференциальный диагноз

«№»	Доброкачественные опухоли молочной железы	Злокачественные опухоли молочной железы
	Фиброаденома, мастит, кисты молочной желез	РМЖ

12.8. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

- тщательный сбор анамнеза;
- физикальное обследование;
- УЗИ молочных желез и регионарных зон метастазирования
- Маммография молочных желез
- Р-графия органов грудной клетки
- компьютерную томографию (при подозрении на на-

личие мтс поражения)

– магнитно-резонансную томографию пораженной области; (при подозрении на наличие мтс поражения)

– морфологическая верификация заболевания с установлением гистологического типа и степени дифференцировки опухоли (пункционная или трепан - биопсия):

– ИГХ – исследование:

– РЭ

– РП

– Her2/neu

– Ki67

– ультразвуковое исследование органов брюшной полости. (при подозрении на наличие мтс поражения)

– ЭКГ;

– сцинтиграфию скелета; (при подозрении на наличие мтс поражения)

– ПЭТ по показаниям.

12.9 Перечень обследований необходимых для плановой госпитализации

- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Биохимическое исследование крови
- Коагулограмма
- ЭКГ
- рентгенографическое исследование органов грудной клетки;
- Кровь на ВИЧ
- Кровь на RW
- Кровь на гепатит В и С
- Группа крови и резус-фактор
- морфологическая верификация заболевания с установлением гистологического типа и степени дифференцировки опухоли (пункционная или трепан - биопсия):
- Маммография молочных желез
- Рентгенография органов грудной клетки
- УЗИ молочных желез и регионарных зон метастазирования.

13. Цели лечения: Удаление опухоли; комплексное воздействие на опухоль, для улучшения условий проведения хирургического этапа; профилактика отдаленного метастазирования.

14. Общие принципы лечения РМЖ

15. Немедикаментозное лечение

15.1. РМЖ – одно из немногих онкологических заболеваний, при котором лечение всех стадий многовариантно.

Несмотря на значительный прогресс в разработке новых методов лечения РМЖ, хирургическое вмешательство по-прежнему остается основным, а в ряде случаев – единственным методом лечения этого заболевания (Ca in situ).

Выбор того или иного вида радикальной операции определяется не только степенью распространения опухолевого процесса, но и клинической формой, локализацией опухоли, возрастом больных и некоторыми другими факторами, характеризующими их общее состояние.

В последнее время все большее значение придается вопросам улучшения качества жизни, которое достигается выполнением органосохраняющих операций на молочной железе, а также реконструктивно-восстановительных операций с использованием местных тканей.

Органосохраняющие операции при РМЖ обеспечивают, наряду с высокими показателями выживаемости, хорошие косметические и функциональные результаты. Социально-

трудова́я реабилитация больных после радикальной резекции молочной железы происходит быстрее, чем после мастэктомии.

Показания к выполнению органосохраняющих операций на молочной железе:

а) наличие узловой формы рака размером до 2,5 см;
б) отсутствие мультицентричности и мультифокальности опухолевого роста (на маммо-граммах, УЗИ клинически);
в) медленный и умеренный темпы роста, удвоение размера опухоли не быстрее чем за 3 месяца (по данным анамнеза);

г) благоприятное соотношение размеров молочной железы и опухоли для получения хорошего косметического результата операции;

д) отсутствие отдаленных метастазов;

ж) допустимо наличие одиночных метастазов в подмышечной области;

з) желание больной сохранить молочную железу.

• Реконструктивно-восстановительные операции могут выполняться при I–III стадии РМЖ по желанию пациентки при любой локализации опухоли.

15.3 Адьювантная терапия рака молочной железы.

Рекомендации по адьювантной системной терапии подтипов рака молочной железы (Сент-Галлен 2011)

Подтип РМЖ	Тип терапии	комментарии
Люминальный А	Только гормональная терапия	Только отдельным пациентам может потребоваться цитотоксическая терапия (например, при обширном поражении лимфатических узлов или с другими показателями высокого риска)
Люминальный В (Her-негативный с высоким индексом ki67)	Гормональная + цитотоксическая терапия	Решение о проведении и типе цитотоксической терапии может приниматься в зависимости от уровня экспрессии эндокринных рецепторов, риска и предпочтений пациента
Люминальный В (Her-позитивный)	Цитотоксическая + таргетная + гормональная терапия	Данных в поддержку отказа от цитотоксической терапии в данной группе не существует
Трижды негативный	Цитотоксическая терапия	

NB! При медулярном раке и аденокистозной карциноме адьювантная химиотерапия может не потребоваться (при отсутствии поражения лимфатических узлов)

Схемы адьювантной химиотерапии РМЖ: FAC, AC, TAC, CMF, Доцетаксел + Трастузумаб; Паклитоксел + Трастузумаб. Применение Герцептина в сочетании с препаратами антрациклинового ряда невозможно, поскольку оба препарата обладают кардиотоксическим действием.

С 2011г., StGallen, рекомендовано применение Трастузумаба (Герцептин), в адьювантной терапии РМЖ при высокой экспрессии Her2/neu и размере образования от 1 см.

Лечение по стадиям

Хирургическое лечение производится в объеме

радикальных мастэктомий по Madden, Patey, а также в объеме органосохраняющих операций с подмышечно-подлопаточной лимфаденэктомией, реконструктивно-восстановительной операцией или без нее.

0, I стадия

1. Органосохраняющее лечение

После органосохраняющей операции, с учетом уровня экспрессии ЭР, ПР, Her-2/neu, назначается один из видов системного лечения. Лишь только при отсутствии необходимости проведения системного лечения возможно на

значение лучевой терапии. Облучение молочной железы осуществляется с помощью фотонного излучения (6 МэВ) линейного ускорителя или гамма-излучения ⁶⁰Со-установки (1,25 МэВ) с двух тангенциально расположенных полей, имеющих целью обеспечить максимально

гомогенное облучение железы. РОД 2 Гр, СОД 60 Гр. Послеоперационная зона дополнительно облучается в дозе 12 Гр (по 2 Гр). Предпочтительно облучение электронным

пучком.

2. Радикальная мастэктомия

При всех вышеперечисленных локализациях I стадии заболевания возможно выполнение радикальной мастэктомии с восстановлением формы железы или без восстановления (по желанию пациентки).

Системное лечение предусматривает: химиотерапию у больных до 50 лет при инвазивных формах, гормонотерапию антиэстрогенами (тамоксифеном, торемифеном) или ингибиторами ароматазы у постменопаузальных больных с рецептор положительными опухолями в течение 5 лет. Больным младше 50 лет с сохраненной менструальной функцией:

- Двухсторонняя овариэктомия.

- LHRH-аналоги (диферелин, золадекс) ежемесячно в течение 2 лет

В дальнейшем – назначение антиэстрогена (тамоксифен, торемифен)

Больным с отрицательными ER, ПР с неблагоприятными прогностическими факторами с положительным Her2-neu, гормонотерапия не проводится, рекомендована химиотерапия или химиотаргетная терапия.

Схемы химиотерапии при 0 и I стадиях:

AC

доксорубин 60мг/м² в/в 1 дн

циклофосфан 600мг/м² в/в 1 дн

повторять каждые 3-4 недели в зависимости от восстановления гематологических показателей.

FAC

фторурацил 500 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

доксорубин 50мг/м² в/в длительная инфузия 72 часа

с 1-го по 3-й дни

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять 21, если восстановлены гематологические показатели

FEC

фторурацил 500 мг/м² в/в в 1-й день

эпирубин 50-100 мг/м² в/в в 1-й день

циклофосфамид 500 мг/м² в/в в 1-й день

повторять через 3 недели

TAC

доцетаксел 75мг/м² в/в 1-й день

доксорубин 50мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21 день

ТА

доцетаксел 75мг/м² в/в 1-й день

доксорубицин 50мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21 день

ТС

доцетаксел 75мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21 день

САФ

циклофосфамид 600 мг/м² в/в 1-й день

доксорубицин 60мг/м² в/в 1-й день

фторурацил 600 мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21-28 дней

СМФ

циклофосфан 100 мг/м² перорально 1-14дн

метотрексат 40мг/м² в/в 1 и 8 дн

5ФУ 600мг/м² в/в 1 и 8дн

преднизолон 40мг/м² перорально 1и 14дн

повторять каждые 4 недели 6 циклов.

При гиперэкспрессии Her2/neu проводится таргетная терапия трастузумабом 8 мг/кг – нагрузочная доза, затем по 6 мг/кг 1 раз в 3 недели. Длительность таргетной терапии в адьювантном режиме – 1 год.

II стадия

Лечение, идентичное таковому при I стадии, однако у больных с N0, но с наличием неблагоприятных прогностических признаков (возраст до 35 лет, отрицательные гормональные рецепторы) в послеоперационном периоде, кроме всей молочной железы, при локализации опухоли во внутренних квадрантах или центральной зоне, а также у всех больных с N+ (при метастатическом поражении трех и менее подмышечных лимфатических узлов) дополнительно облучаются парастернальная и надключичная зоны со стороны основного очага.

Послеоперационная ЛТ проводится в режиме классического фракционирования дозы (РОД 2 Гр, СОД 30 Гр) после выполнения органосохраняющей операции и проведения системной терапии. Послеоперационная зона дополнительно облучается в дозе 12 Гр (по 2 Гр).

У больных с N+ при поражении четырех и более подмышечных лимфатических узлов и/или при прорастании опухоли капсулы лимфатического узла, кроме оставшейся молочной железы, облучается парастернальная, надподключично-подмышечная зона со стороны поражения.

Все пациенты со II стадией должны получать адьювантную системную химиотерапию (АС, ТАС, АС+Т, FAC, САФ, FEC, СМФ)

При +ER – гормонотерапия: антиэстрогены (тамоксифен или торемифен) в течение 5 лет, у женщин в постменопаузе в адьювантном режиме могут назначаться так же ингибиторы ароматазы – анастрозол, летрозол.

При -ER – химиотерапия

Схемы химиотерапии:

FAC

фторурацил 500 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

доксорубицин 50мг/м² в/в длительная инфузия 72 часа с 1-го по 3-й дни

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять 21, если восстановлены гематологические показатели

FEC

фторурацил 500 мг/м² в/в в 1-й день

эпирубицин 50-100 мг/м² в/в в 1-й день

циклофосфамид 500 мг/м² в/в в 1-й день

Повторять через 3 недели

VC

Винорельбин – 25 мг/м² в/в в 1, 8, 15, 22-й дни

Капицитабин – 1000 мг/м² внутрь 2 раза в сутки (2 г/м²/сут) с 1-го по 14-й дни

Интервал между курсами 1 неделя.

ТАС

доцетаксел 75мг/м² в/в 1-й день

доксорубицин 50мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21 день

САФ

циклофосфамид 600 мг/м² в/в 1-й день

доксорубицин 60мг/м² в/в 1-й день

фторурацил 600 мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21-28 дней

АС

доксорубицин 60мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 600мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 3-4 недели в зависимости от восстановления гематологических показателей.

АС-Т

доксорубицин 60мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 600мг/м² в/в 1-й день x 4 цикла

затем

паклитаксел 175 мг/м² в/в, 3-х часовая инфузия 1 раз в 3 недели x4 цикла

СМФ

циклофосфамид 100 мг/м² перорально с 1-го по 14-й дни

метотрексат 40 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

фторурацил 600 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

повторять каждые 28 дней

или

циклофосфамид 600 мг/м² в/в 1-й день

метотрексат 40 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

фторурацил 600 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

повторять каждые 21-28 дней

каждые 3 недели повторять 8 циклов.

При гиперэкспрессии Her2/neu проводится таргетная терапия трастузумабом 8 мг/кг – нагрузочная доза, затем по 6 мг/кг каждые 3 недели в течение одного года.

При IIA стадии общие воздействия назначают в соответствии с табл. 2.

У женщин в пременопаузе при наличии 8 и более метастатических лимфатических узлов после завершения 6 курсов ПХТ и продолжающейся менструальной функции показано выполнение двусторонней овариэктомии или выключение функции яичников назначением агонистов релизинг-гормона ЛГГ (гизерелин – 3,6 мг подкожно в области брюшной стенки каждые 28 дней или 10,8 мг каждые 3 месяца в течение 2 лет, трипторелин по 3,75 мг каждые 28 дней или 11,25 мг каждые 3 месяца в течение 2 лет) с последующим назначением антиэстрогена: тамоксифен по 20 мг в сутки или торемифен 60 мг в сутки в течение 5 лет. При прекращении менструальной функции после 6 курсов ПХТ и определения уровня эстрадиола в крови для подтверждения истинной менопаузы назначают антиэстроген: тамоксифен по 20 мг в сутки или торемифен по 60 мг в сутки в течение 5 лет.

IIIa и IIIb, IIIc (при N3a, N3b) стадии

Необходим мультимодальный подход

Таблица 2 - Отсутствие метастазов в подмышечных лимфатических узлах

Менструальный статус	Низкий риск	Высокий риск
Гормоночувствительные опухоли		
Менструирующие	Тамоксифен Торемифен Гозерилин трипторелин	Химиотерапия: Химиотерапия + антиэстроген (тамоксифен или торемифен) (при выключении функции яичников)
Постменопауза	Антиэстрогены (тамоксифен, торемифен) Ингибиторы ароматазы (аримидекс, летрозол)	Гормонотерапия: антиэстрогены (тамоксифен, торемифен); ингибиторы ароматазы (анастрозолс, летрозол) или химиотерапия + антиэстрогены (тамоксифен, торемифен); ингибиторы ароматазы (анастрозолс, летрозол)
Гормонорезистентные опухоли		
Менструирующие	-	Химиотерапия
Постменопауза	-	Химиотерапия

Не менее 4-6 курсов ПХТ (до достижения максимального лечебного эффекта)

↓ ↓

Ответ нет ответа

операция ЛТ (60Гр)

(выбор операции зависит от опухолевого ответа, но всегда проводится ↓ с лимфодиссекцией) операция

↓

Дополнительные курсы ↓ системной химиотерапии (4-6 курсов ПХТ с учетом биологических особенностей)

↓

ЛТ химиотерапия с учетом биологических особенностей

↓

Для женщин старше 50 лет с ER+рецепторами - антиэстрогены (тамоксифен по 20мг, или торемифен по 60 мг) в течение 5 лет.

Оперативное вмешательство через 3 недели после окончания лечения в объеме РМЭ по Мадену, радикальной резекции молочной железы, органосохраняющей или реконструктивно-пластической операции.

Оперативное лечение. Оперативное пособие выполняется по общепринятой методике в объеме радикальной мастэктомии (по Madden, Patey). Объем хирургического вмешательства (вариант мастэктомии) определяется распространенностью опухолевого процесса. Во всех случаях показано удаление регионарных лимфатических узлов трех уровней: подмышечных, подключичных, подлопаточных с их последующей маркировкой. Опухоль подлечит маркировке в соответствии с размерами и локализацией по квадрантам молочной железы.

Возможно одномоментное или отсроченное выполнение

реконструктивно-восстановительной операции (по желанию пациентки).

Послеоперационная лучевая терапия. Послеоперационная ЛТ проводится в режиме классического фракционирования дозы (РОД 2 Гр, СОД до эквивалентной дозы 40 Гр). Поля облучения: надподключичное, подмышечное, парастернальное, грудная стенка (при рТЗ, 4).

Неоадьювантная терапия РМЖ

Клинически часто приходится встречаться со сложнейшим выбором лечения больных местнораспространенным РМЖ. Удельный вес таких опухолей колеблется от 5% до 40%. Обоснованиями для назначения неоадьювантной системной терапии МРРМЖ являются:

- 1) высокая вероятность скрытого (микрометастатического) распространения,
- 2) возможность сократить объем хирургического вмешательства в пределах «чистых» хирургических краев,
- 3) возможность оценить клинический ответ на терапию in vivo,
- 4) доступность точной патоморфологической оценки степени регрессии опухоли,
- 5) возможность специальных исследований биопсийного опухолевого материала до, во время и после завершения первичного системного лечения.

Целями данного вида системного лечения являются:

- 1) Добиться регресса опухоли и провести радикальное местно-регионарное лечение,
- 2) с учетом крайне неблагоприятного прогноза у этой группы пациентов с помощью системной терапии добиться улучшения отдаленных результатов лечения.

Схема проведения неоадьювантного системного лечения:

Маммография, УЗИ, трепан-биопсия с определением уровня ЭР, ПР, Her 2/neu, ki67.

4 курса неоадьювантной химиотерапии – операция – 4 курса адьювантной химиотерапии. При отсутствии эффекта после 4 курсов неоадьювантной химиотерапии необходимо сменить схему химиотерапии. При гиперэкспрессии Her2/neu в неоадьювантном режиме проводится таргетная терапия трастузумабом 8 мг/кг – нагрузочная доза в последующем по 6 мг/кг каждые 3 недели. После которой следует адьювантное назначение трастузумаба 8 мг/кг – нагрузочная доза в последующем по 6 мг/кг каждые 3 недели.

Метастатический РМЖ

Лечебная полихимиотерапия

Общие принципы лечения при обязательном определении рецепторного статуса: РП, РЭ, Her-2, ki67.

При положительных гормональных рецепторах – люминальном А типе РМЖ, первым этапом проводят гормонотерапию антиэстрогенами (тамоксифен, торемифен) или ингибиторами ароматазы (анастрозол, летрозол) у больных в постменопаузе. При этом эффект химиотерапии должен оцениваться не ранее, чем через 3 месяца после начала лечения. При прогрессировании заболевания на фоне 1-й линии гормонотерапии, больную переводят на 2, затем 3-ю линии химиотерапии.

Химиотерапия мРМЖ назначается пациенткам с отрицательными РЭ и РП, а также у больных с высоким уровнем ki67>15% и Her(3+). В качестве химиотерапии 1 линии используют антрациклин содержащие схемы: AC, FAC, FEC, CAF, AT, CT

При прогрессировании процесса 2-3 линия

химиотерапии с включением таксанов, винорельбина, капецитабина, препаратов платины, гемцитабина.

При противопоказаниях к антрациклинам CMF, монотерапия капецитабином

Высокий риск: 1) пациенты с быстро прогрессирующим заболеванием, висцеральным поражением, гормонотрицательными рецепторами: FAC, CAF, AT, CT, капецитабин;

2) при прогрессировании процесса проведение 2-3 линии химиотерапии с таксановыми препаратами;

3) при резистентности к таксанам в схему подключают капецитабин, гемцитабин, винорельбин, препараты платины, липосомальный доксорубин. Химиопрепараты могут быть использованы в комбинации или в монорежиме, а так же в комбинации с таргетными препаратами при гиперэкспрессии Her-2-neu (трастузумаб, лапатиниб);

4) при частичном или отрицательном ответе продолжают пробные курсы химиотерапии препаратами, проявляющими чувствительность к РМЖ;

5) при отсутствии ответа на все линии противоопухолевой терапии, больные переводятся на поддерживающую терапию.

Кроме того, в качестве второй линии химиотерапии рекомендуется:

доцетаксел 75 мг/м ² 1-й день, доксорубин 50 мг/м ² 1-й день, циклофосфан 500 мг/м ² 1-й день
доцетаксел 75 мг/м ² 1-й день, цисплатин 75 мг/м ² 1-й день
доцетаксел 75 мг/м ² 1-й день, винорельбин 20 мг/м ² в 1-й, 5-й дни
доцетаксел 75 мг/м ² 11-й день, фторурацил 500 мг/м ² 2-й, 3-й, 4-й дни
капецитабин 2500 мг/м ² с 1-го по 14 дни доцетаксел 75 мг/м ² 1-й день
паклитаксел 90 мг/м ² 1-й день, цисплатин 60 мг/м ² 1-й день
паклитаксел 135 мг/м ² 1-й день, винорельбин 20 мг/м ² в 1-й, 8-й дни
паклитаксел 135 мг/м ² 1-й день, винорельбин 20 мг/м ² в 1-й, 8-й дни
винорельбин 30 мг/м ² с 1-го по 5-й дни, доксорубин 50 мг/м ² 1-й день
винорельбин 20-25 мг/м ² в 1-й и 15-й дни, цисплатин 80 мг/м ² 1-й день
винорельбин 25 мг/м ² в 1-й и 8-й дни, митомицин С 7 мг/м ² 1-й день
винорельбин 25 мг/м ² в 1-й и 8-й дни, фторурацил 750 мг/м ² в 1-й и 8-й дни
митомицин С 8 мг/м ² 1-й день, митоксантрон 8 мг/м ² 1-й день, метотрексат 30 мг/м ² 1-й день
золендровая кислота 4 мг 1 раз в 28 дней
Памидроновая кислота 90 мг в/в 1 раз в 28 дней
Липосомальный доксорубин 30 мг/м ² 1 раз в 3 недели
Паклитаксел 80 мг/м ² 1-й, 8-й, 21-й дни, Транстузумаб 4 мг/кг в/в затем 2 мг/кг еженедельно
Капецитабин 1000 мг/м ² с 1-го по 14-й дни, Лапатиниб 1250 мг/м ² ежедневно
п Бевацизумаб 10 мг/кг в/в 0-й и 14-й дни, паклитаксел 90 мг/м ² в/в 1-й, 8-й, 15-й дни
Бевацизумаб 15 мг/кг в/в 0-й день, доцетаксел 75-100 мг/м ² в/в 1-й день
Бевацизумаб 15 мг/кг в/в 0-й день, Гемцитабин 1250 мг/м ² в/в 1-й, 8-й день
Тегафур 800-1000 мг/м ² внутрь ежедневно до суммарной дозы 30г, повторение цикла через 2-3 недели

Низкий риск: пациенты с длительным безрецидивным периодом, положительными гормональными рецепторами, или только костным поражением, без поражения

внутренних органов.

Проведение гормонотерапии у менопаузальных больных ингибиторами ароматазы: летрозол по 2,5 мг ежедневно длительно или анастрозол по 1 мг ежедневно длительно при прогрессировании процесса больным назначаются антиэстрогены – тамоксифен или торемифен при дальнейшем прогрессировании процесса 3 линия гормонотерапии – фулвестран по схеме – 500 мг нагрузочная доза, затем по 250 мг 1 раз в 28 дней. В настоящее время закончены исследования по увеличению дозы фулвестрана, в котором показана достоверно большая активность фулвестрана в режиме: фулвестран – 500 мг 1 день, 14 день, затем по 500 мг 1 раз в 28 дней.

При рефрактерности к фулвестрану переходят на химиотерапию.

У женщин в пременопаузе при наличии 8 и более метастатических лимфатических узлов после завершения ПХТ и при достижении стабильного клинического эффекта, продолжающейся менструальной функции показано выключение функции яичников (агонисты рилизинг-гормонов ЛГГ(трипотрелин 3,75 мг каждые 28 дней в течение 2 лет; гизерелин 3,6 мг каждые 28 дней в течение 2 лет), или овариэктомия) с последующим назначением антиэстрогена- тамоксифена по 20 мг или торемифена по 60 мг в сутки до прогрессирования процесса.

Схемы химиотерапии, не содержащие антрациклинов:

1) паклитаксел 135 мг/м² 1-й день, винорельбин 20 мг/м² 1-й, 8-й дни;

2) винорельбин 30 мг/м² 1-й и 5-й дни, доксорубин 50 мг/м² 1-й день;

3) винорельбин 20-25 мг/м² 1-й и 15-й дни, цисплатин 80 мг/м² 1-й день;

4) винорельбин 25 мг/м² 1-й и 8-й дни, фторурацил 750 мг/м² 1-й и 8-й дни;

5) капецитабин 2500 мг/м² с 1-го по 14-й дни, винорельбин 25 мг/м² 1-й, 8-й дни;

6) капецитабин 2500 мг/м² с 1-го по 14-й дни, гемцитабин 1000 мг/м² 1-й, 8-й дни;

7) доцетаксел 75 мг/м² 1-й день, гемцитабин 1000 мг/м² 1-й, 8-й дни, винорельбин 25 мг/м² 1-й, 8-й дни;

8) гемцитабин 1000 мг/м² 1-й, 8-й дни, паклитаксел 100 мг/м² 1-й, 8-й дни;

9) карбоплатин 300-400мг/м² 1-й день, капецитабин 2500 мг/м² с 1-го по 14-й дни;

10) этопозид 50-100мг/м² в 3 приема 1-5дн;

При гиперэкспрессии Her 2/neu (+3) в схему лечения химиотерапии включается трастузумаб 8 мг/кг – нагрузочная доза, в последующем по 6 мг/кг каждые 3 недели. У больных с прогрессированием на таргетной терапии трастузумабом возможен переход на вторую линию таргетной терапии с включением лапатиниб - 1250 мг 1 раз в сутки) в комбинации с капецитабином или паклитакселем.

Для больных с люминальным В типом РМЖ рекомендована таргетная терапия лапатинибом 1500 мг в комбинации с гормональной терапией – ингибиторами ароматазы.

При наличии костных метастазов при любых стадиях заболевания включение в схему лечения бисфосфонатов (памидроновая кислота, золендроновая кислота, деносумаб).

При необходимости - подключение ЛТ.

При наличии метастазов головного мозга:

Химиолучевая терапия с включением всех тропных препаратов, проникающих через ГЭБ, в т.ч. и темодала. Больным РМЖ с изъязвленной опухолью, осложненной

инфицированием, кровотечением, выполняется паллиативная мастэктомия с санитарной целью. Лечение дополняется химиолучевой, гормональной терапией.

Методика лучевой терапии.

Дистанционная лучевая терапия проводится по методике конвенционального (стандартного) или конформного облучения РОД 1,8-2,0-2,5 Гр 5 фракций в неделю до СОД 60-64 Гр в самостоятельном режиме, СОД 50-60 Гр («Boost») в послеоперационном режиме после органосохраняющих операций, СОД 40-50 Гр после радикальных мастэктомий. Используется непрерывный курс лучевой терапии. Облучение проводится на гамматерапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Техника лучевой терапии: Лучевая терапия молочной железы и зон регионарного метастазирования (надподключичной, подмышечной) осуществляется тормозным излучением ускорителя (6 МэВ) или на гамма-терапевтических аппаратах (1,25 МэВ), а парастеральной зоны – путем чередования фотонного и электронного пучков или только электронным излучением до 20 МэВ в зависимости от глубины залегания цепочки парастеральных лимфатических узлов. Облучение парастеральной зоны с помощью ^{60}Co или только фотонным пучком с энергией свыше 4 МэВ чревато развитием постлучевого пульмонита, медиастинита, перикардита. Предоперационную лучевую терапию во многих научных центрах мира не проводят.

Послеоперационное облучение передней грудной стенки после мастэктомии или облучения оставшейся молочной железы после радикальной резекции осуществляется фотонным пучком 1,25 МэВ или 6 МэВ с тангенциальных полей, направленных таким образом, чтобы в зону 100%-й изодозы попадало не более 2 см легочной ткани.

Тангенциальные поля. Границы:

Верхняя – уровень грудинно-ключичного сочленения (угол Луиса); если необходимо, верхняя граница может быть расположена выше, чтобы включить всю молочную железу.

Медиальная – вдоль середины грудины.

Нижняя – на 2 см ниже субмаммарной (переходной) складки.

Латеральная – на 2 см латеральнее пальпируемой ткани молочной железы, обычно вдоль среднеподмышечной линии.

В послеоперационном периоде после мастэктомии границы тангенциальных полей следующие:

Верхняя – угол Луиса.

Медиальная – срединная линия тела.

Нижняя – на уровне субмаммарной складки противоположной железы.

Латеральная – средняя подмышечная линия.

При нетипичной локализации послеоперационного рубца и расположении его за пределами обозначенных границ полей облучения рекомендуется дополнительное облучение зоны рубца с захватом тканей не менее чем на 2 см за его пределами. Такое облучение должно осуществляться электронным пучком или с помощью контактной лучевой терапии.

Надподключичное поле.

Облучение надподключичных и подмышечных лимфатических узлов происходит с переднего поля и наклоном пучка на 10–15° к одноименной стороне, чтобы избежать облучения пищевода и трахеи.

Верхний край поля – на уровне верхнего края перстнещитовидного углубления.

Медиальная граница – середина грудины.

Латеральная граница – медиальный край головки плеча; при необходимости облучения всей подмышечной впадины боковая граница должна быть расширена до латерального края головки плеча, которая должна быть прикрыта защитным блоком.

Нижняя граница соприкасается с верхней границей тангенциального поля на уровне прикрепления второго ребра к груди (угол Луиса).

Всегда обязательно защищаются свинцовым блоком гортань, пищевод, трахея.

Заднее подмышечное поле используется при необходимости облучения всей подмышечной зоны.

Медиальная граница расположена на 1 см кнутри от края грудной клетки.

Верхняя граница – верхний край ключицы.

Боковая граница – латеральный край головки плеча.

Нижняя граница – тот же уровень, что и нижний край надподключичного поля.

Парастеральное поле. Границы:

Медиальный край – средняя линия грудины.

Латеральный край – на 4-5 см латеральнее средней линии;

Медиальный край – средняя линия грудины.

Верхний край – нижний край надподключичного поля.

Нижний край – основание мочеvidного отростка грудины.

При облучении нескольких смежных полей расстояние между границами этих полей следует определять в зависимости от выбранного вида энергии и излучения.

Размеры поля облучения выбираются индивидуально при лучевой подготовке с помощью УЗИ, компьютерного томографа, рентгеносимуляторов.

Стандартное послеоперационное облучение проводится в режиме обычного фракционирования дозы (РОД 2Гр, СОД- 40Гр) на молочную железу, грудную стенку и зоны регионарного метастазирования. При наличии в учреждении электронного пучка, у больных, подвергшихся радикальной резекции, зона послеоперационного рубца может дополнительно облучаться в дозе 12 Гр.

Рак молочной железы у мужчин

Рак молочной железы у мужчин лечится также, как и рак молочной железы у женщин при центральной локализации опухоли. Следует отметить, что органосохраняющие операции у мужчин не выполняются. Во всех случаях производится мастэктомия.

Рак Педжета

При отсутствии опухолевого узла в молочной железе проводится только хирургическое лечение (мастэктомия по Madden или Patey). Допустимо выполнение широкой центральной резекции с послеоперационной лучевой терапией на молочную железу. При наличии опухоли в молочной железе болезнь Педжета лечится как рак соответствующей стадии.

Отечно-инфильтративный рак

При рецептор положительной опухоли у больных в постменопаузе лечение может быть начато с гормонотерапии: тамоксифен по 20 мг ежедневно или торемифен 60 мг либо ингибиторы ароматазы у больных в постменопаузе. Эффективность гормонотерапии оценивается не ранее, чем через 3 месяца после начала лечения. В случае прогрессирования больная переводится на 2 линию гормонотерапии – ингибиторы ароматазы или антиэстрогены, в зависимости от того, какой препарат использовался в первой линии гормонотерапии, при

прогрессировании на второй линии гормонотерапии, больная переводится на 3 линию гормонотерапии – фулвестраном (режимы введения описаны выше). При прогрессировании на фулвестране пациентка переводится на химиотерапию. Принципы химиотерапии те же, что и при лечении метастатического рака молочной железы.

Лучевая терапия по радикальной программе (РОД 2 Гр 5 фракций на молочную железу и регионарные зоны, суммарная доза 60 Гр). В промежутке между первым и вторым этапами может быть выполнена двусторонняя орхиэктомия (до начала лечения таким больным выполнить трепан-биопсию для изучения гормонорецепторного статуса опухоли).

В дальнейшем наблюдении – либо паллиативная мастэктомия (при возобновлении роста опухоли или метастазов в лимфатических узлах).

Профилактические мероприятия:

- Избегать травматизации молочных желез;
- При появлении вышеописанных жалоб своевременное обращение за медицинской помощью;
- Своевременное лечение доброкачественных опухолей молочных желез.

Наблюдения, сроки и объем обследования

После окончания специального лечения в течение первых двух лет больные наблюдаются каждые 3 месяца, на третьем году – каждые 4 месяца, на 4-5 году – 1 раз в полгода, затем 1 раз в год.

При наблюдении в течение первых 5 лет раз в полгода необходим общий анализ крови, в последующем это исследование проводится 1 раз в год.

При каждом посещении необходим осмотр онкологом,

Схема контрольных исследований пациенток РМЖ

Временной интервал операции	Клиническое исследование	Анализ крови, включая онкомаркеры (CEA, CA15-3)	КТ (с контрастом) органов грудной клетки и брюшной полости	Маммография
3 месяца	x	x		
6 месяцев	x	x	x	
9 месяцев	x	x		
12 месяцев	x	x	x	x
18 месяцев	x	x	x	
24 месяца	x	x	x	x
30 месяцев	x	x	x	
3 года	x	x	x	x
4 года	x	x	x	x
5 лет	x	x	x	x
6 лет	x	x	x	x
7 лет	x	x	x	x

Примечание: x – показано проведение данного вида исследования.

онкогинекологом.

Рентгенологическое исследование легких в течение первых 3 лет необходимо выполнять 1 раз в полгода, затем 1 раз в год.

В объем контрольного обследования входит УЗИ молочных желез, послеоперационных рубцов, регионарных зон, печени, маммография противоположной молочной железы, рентгенография ОГК.

16. Индикаторы эффективности лечения

- Маммография;
- КТ данные;
- МРТ данные;
- Уменьшение размеров образования и увеличенных лимфоузлов;
- Удовлетворительные показатели крови, мочи, биохимические показатели;
- Заживление послеоперационной раны;
- Относительно удовлетворительное состояние больной;
- Отсутствие отдаленных метастазов при скинтиграфии (ФЭКТ) скелета по показаниям;
- Отсутствие отдаленных метастазов ПЭТ по показаниям.

17. Критерии оценки проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

- Процент вновь выявленных пациентов со злокачественными новообразованиями легких, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов с установленным диагнозом рака лёгких, получавших начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рак лёгких) x 100%;
- Процент онкологических больных, получавших химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получавших химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/ Количество всех больных раком лёгкого после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;
- Процент рецидивов рака лёгкого у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака лёгкого в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рак лёгких) x 100%.

18. Рецензенты:

- Кожахметов Б.Ш. – зав.каф.онкологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей, д.м.н., проф.
- Абисатов Г.Х. – зав.каф.онкологии, маммологии Казахстанско-Российского медицинского университета, д.м.н., проф.

Список использованной литературы

1. Клинические рекомендации ESMO, 2010.
2. Клинические рекомендации ASKO, 2006.
3. Онкология. Клинические рекомендации /2-е изд. Под редакцией проф. В.И. Чиссова, проф. С.Л.Дарьялова.- М., 2009.
4. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний /под редакц. Переводчиковой Н.И. –М., 2011.

Список разработчиков протокола:

- Талаева Ш.Ж. - д.м.н., Ли И.Н.- к.м.н., Кайбуллаев Б.А.-врач, к.м.н.,
- Ким В.Б. –радиолог, д.м.н., Есентаева С.Е. – химиотерапевт, д.м.н.

УДК: 618.14-006.6

Н.Н. Мезинова

Центральная городская клиническая больница г.Алматы

Рак тела матки. Настоящее и прошлое

Аннотация. Цель исследования - изучить возможные причины роста заболеваемости раком тела матки.

Материалы и методы: материалами служили 34 больные раком тела матки, поступивших с маточным кровотечением в ЦГКБ в 2007-2011годы и 32 больные раком тела матки, прооперированных в КазНИИОиР в 1965-1969 годы.

Методы исследования: клинические, лабораторные, статистические. У всех больных диагноз верифицирован морфологическим исследованием соскоба эндометрия или удаленной опухоли. Степень ожирения определялась по ИМТ. Ожирение III степени определялось при ИМТ больше 40. Полученные данные подвергнуты статистической обработке, достоверность различий между сравниваемыми группами оценивалась по критериям Стьюдента. Различия между показателями считались достоверными при $P \leq 0,05$.

Установлено, что возраст современных менопаузальных больных достоверно выше, чем 40 лет назад. Современные больные раком тела матки достоверно чаще, чем 40 лет назад, позже вступают в менопаузу, меньше рожают. Рак чаще выявляется в миоматозно-измененной матке. Наблюдается тенденция к увеличению эндокринно-обменных заболеваний - ожирения, сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензией, чаще выявляется ожирение III степени.

Полученные данные свидетельствуют в пользу влияния старения организма и эндокринно - обменных заболеваний на рост заболеваемости раком тела матки.

В последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости раком тела матки (РТМ). Во многих странах РТМ занял первое место среди злокачественных опухолей половых органов. Предполагается, что причиной учащения РТМ может быть увеличение продолжительности жизни, эндокринно-обменных заболеваний, применение заместительной гормонотерапии в постменопаузе (Бохман Я.В., 1989; Вишневская Е.Е., 1989; Гинекология по Эмилю Новаку, 2002)[1,2,3].

Цель исследования

- сравнение ряда клинических параметров больных РТМ, обследованных в 2007-2011гг. и в 1965-1969гг.

Материалы и методы

Проведено обследование 66 больных РТМ. У 34 РТМ был диагностирован в ЦГКБ г. Алматы, куда женщины поступали с маточным кровотечением и при морфологическом исследовании соскоба слизистой матки установлено наличие аденокарциномы. Все препараты консультированы в городском онкологическом диспансере, куда

больные поступали для лечения. 32 больные являлись пациентками Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в 1965-1969 г.г., где они получали лечение по поводу РТМ [6]. Исходное клинико-лабораторное обследование включало: сбор анамнеза, общеклиническое исследование, изучение антропометрических данных. Степень ожирения определялась по индексу массы тела. При ИМТ 25-29,9 - диагностировалась избыточная масса тела, при ИМТ - 30-34,9 кг/м² - 1 степень ожирения, при ИМТ - 35-39,9 кг/м² - 2 степень ожирения, при ИМТ 40 и более кг/м² 3 степень ожирения. Наличие артериальной гипертензии и клинического сахарного диабета 2 типа - по заключению терапевта, эндокринолога, у которых больные находились на диспансерном учете, а также терапевтов тех учреждений, куда больные были госпитализированы. У пациенток КазНИИОиР, с научными целями проводился тест на толерантность к глюкозе для выявления латентного диабета. В виду того, что в ЦГКБ такой тест не проводился, учтены только больные с наличием клинического СД 2 типа. Больным, которые госпитализировались в ЦГКБ, производилось трансвагинальное ультразвуковое сканирование, оценивались размеры и структура М-ЭХО, матки и яичников. В 1965-1969гг. больные УЗИ не подвергались, и наличие миомы выявлялось при гинекологическом исследовании и по заключению морфологов, исследовавших экстирпированную матку. Достоверность различий клинико-лабораторными показателями в сравниваемых группах оценивалось по критериям Стьюдента. Различия между клинико-лабораторными показателями считались достоверными при $p \leq 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение

Клиническая характеристика больных РТМ представлена в таблице. Первую группу составили 34 больных РТМ, который диагностирован в 2007-2011гг., вторую -32 больных РТМ, диагностированного в 1965-1969гг. Из таблицы следует, что в обеих группах больных преобладают женщины в постменопаузе. Ни одна постменопаузальная больная не получала заместительную гормонотерапию.

РТМ у женщин до наступления менопаузы составил в первой группе 26,5%, во второй- 15,6%. Средний возраст доменопаузальных больных первой группы был меньше, чем второй ($47,3 \pm 1,5$ против $52,0 \pm 2,9$ лет). Особого внимания заслуживает, тот факт, что у доменопаузальных пациенток обеих групп в течение длительного времени имели место маточные кровотечения, по поводу которых неоднократно проводились выскабливания полости матки. Гистологическое исследование соскоба эндометрия свидетельствовало о наличии гиперпластического процесса. Гормональное лечение с целью профилактики

рецидивов гиперплазии, как правило, не проводилось, или было неэффективным. На диспансерном учете пациентки не состояли.

В диссертационной работе К.Т. Исиной [4], защищенной в 1968 году, было выявлено, что при рецидивирующих гиперплазиях эндометрия наблюдаются такие же сопутствующие заболевания как у больных РТМ. После диагностических выскабливаний полости матки большинство менструальных циклов остаются ановуляторными. Автор предложила относить к предракам гиперпластические процессы эндометрия у женщин с эндокринно-обменными нарушениями.

Большинство больных РТМ были в постменопаузе. Возраст современных менопаузальных больных РТМ на 11 лет превышает возраст больных в 70-ые годы прошлого столетия. Больные с продолжительной менопаузой (от 19 до 33 лет) составили 52%, тогда как во второй группе не было ни одной пациентки с такой длительной менопаузой. В сравниваемых группах высокий процент женщин, у которых менопауза наступила в возрасте 50 лет и старше (76%-73%). По нашим данным, у здоровых женщин в 70-е годы прошлого столетия в среднем менопауза наступала в 47,3±1,5 лет [6]. В руководствах последних лет указано, что менопауза в среднем наступает в 50-52 года. У 44% менопаузальных больных РТМ первой группы, менопауза наступила в возрасте старше 52 лет. Известно, что у женщин, примерно, с 35 лет большинство менструальных циклов становятся ановуляторными, снижается возможность наступления беременности. После 40 лет все менструальные циклы ановуляторные, т.е. организм женщины испытывает влияние только эстрогенов. И чем длительнее продолжаются ановуляторные менструальные циклы, тем чаще возникают гормонозависимые новообразования репродуктивных органов. Эти данные позволяют заключить, что увеличение продолжительности жизни, позднее наступление менопаузы может быть одной из причин роста заболеваемости РТМ. Многие исследователи указывают, что для больных РТМ характерна недостаточность репродуктивной функции, проявляющаяся первичным и/или вторичным бесплодием, малочисленными родами [1,2,3]. Среди анализируемых нами больных в первой группе.

Таблица 1 - Клиническая характеристика больных раком тела матки, диагностированного в 2007-2011гг. (1гр.) в сравнении с больными 1965-1969гг. (2гр.)

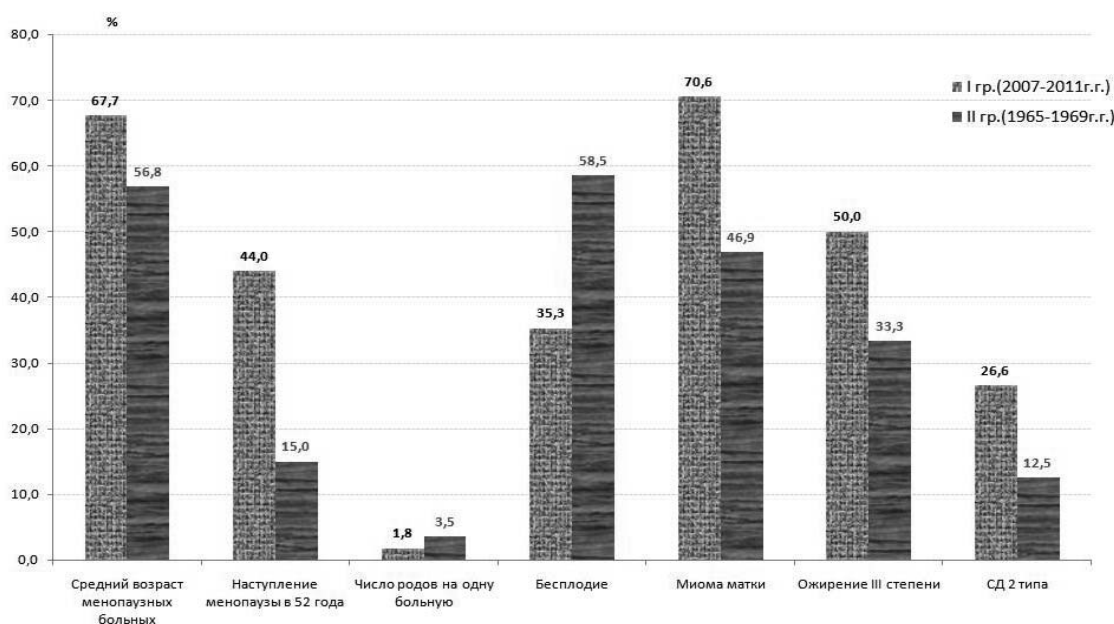
Клинические данные	1 группа, n=34	2 группа, n=32
	Абс/ч %	Абс/ч %
РТМ до менопаузы	9 26,5±7,6	5 15,6±6,4
РТМ в менопаузе	25 73,5±7,6	27 84,4±6,4
Средний возраст доменопаузальных больных (лет)	47,3±1,5	52,0±2,9
Больные с ДМК	8 88,9	5 100
Средний возраст менопаузальных больных (лет)	67,7±2,1*	56,8±2,0
Продолжительность менопаузы к моменту выявления РТМ		
До 3 лет	5 20±5,8	9 33,3±6,1
От 4 до 18 лет	7 28±8,9*	18 66,7±9,1
19-33 лет	13 52±9,9*	-
Наступление менопаузы в 50 лет и старше	19 76±7,3	20 74±4,6
Наступление менопаузы в 52 года	11 44±8,5*	4 15±4,9
Число беременностей на одну больную	4,5±1,1	5,4±0,7

Число родов на одну больную	1,8±0,6*	3,5±0,5
Бесплодие	12 35,3±8,2*	18 58,5±8,7
Миома матки	24 70,6±7,8*	15 46,9±8,8
ИМТ кг/м2 из числа с ожирением 30 и выше 40 и более	14 41,7±8,4 7 50±9,1	15 46,9±8,8 5 33,3±8,9
СД 2 типа с клиническими проявлениями	9 26,6±7,5	4 12,5±5,8
Артериальная гипертензия	21 61,8±8,3	15 46,9±8,8

Примечание * - p<0,05

была только одна женщина, страдавшая первичным бесплодием, во второй - одна девственница. Среди живущих половой жизнью и беременевших на одну пациентку приходилось 4,5±1,1 и 5,4±0,7 аборт и 1,8±0,6 - 3,5±0,5 родов. В последние годы число родов на одну больную РТМ уменьшилось почти в 2 раза. Снизилась также частота бесплодия - 58,5% в предыдущие годы до 35,3% у современных больных. Возможно, уменьшение числа родов и бесплодия объясняется использованием современными женщинами контрацептивных средств. Среди поступивших больных РТМ в ЦГКБ у 4-х выявлен ВМК, которая была введена от 10 до 23 лет тому назад. Эти данные свидетельствуют, с одной стороны, об отсутствии диспансерного наблюдения за женщинами с ВМК, с другой стороны, о возможности развития хронического эндометрита, снижении местного иммунитета. Последние исследования свидетельствуют, что причиной развития гиперпластических процессов эндометрия может быть нарушение тканевой рецепции, инфекционно-воспалительные изменения эндометрия, не только гиперэстрогения, но и гиперпролактинемия [9].

Представленные в таблице данные указывают на нередкое развитие РТМ в миоматозно-измененной матке и увеличение выявляемости миомы матки у пациенток РТМ в последние годы (с 46,9% до 70,6%). Клинические и данные ультразвукового исследования свидетельствуют о том, что миома обычно была небольших размеров, соответствующая величине матки при 6-7, 8-9 недельной беременности. Только у одной пациентки выявлена миома величиной, соответствующей 12-13 недельной беременности. Большинство больных не знали о наличии у них миомы матки, так как не обращались к гинекологам в течение многих лет. Исследования Е.И. Матасовой [5], А.С. Патрушевой [8], О.Л. Смахиной [10] подтверждают частое развитие РТМ в миоматозно-измененной матке. А.С. Патрушева проанализировала заключения морфологов по 347 больным РТМ, прооперированных в КазНИИОиР и ГОД (городской онкодиспансер) в 70-80 годы прошлого столетия и выявила, что у 172 (49,6%) женщин РТМ развился в миоматозной матке. При обследовании 350 женщин с бессимптомной миомой в пре- и постменопаузе с использованием аспирационной биопсии и морфологического исследования соскоба эндометрия у 213 (49,3%), из них установлено наличие железисто-кистозной гиперплазии и/или полипов эндометрия, атипическая гиперплазия у 9,4%, рак эндометрия у 3,3%. Автор показала, что относительный риск развития РТМ в миоматозной матке увеличивался в 43 раза у женщин с наличием ожирения, СД, артериальной гипертензии; в 12-20 раз при предшествующих гиперпластических процессах эндометрия. Были изданы рекомендации о необходимости обследования женщин группы риска по РТМ путем аспирационной биопсии. В настоящее время возможности трансвагинального ультразвукового исследования позволяют выявить по показателю М-ЭХО женщин,



Сравнительные клинические данные менопаузальных больных РТМ в 2007-11 гг. (I группа) и 1965-69 гг. (II группа)

которым необходимо произвести с диагностической целью выскабливание слизистой полости матки. Однако ни одна больная из анализированных современных 34 больных РТМ не подвергалась диспансерному наблюдению. Одна менопаузальная пациентка (8 лет менопауза) после появления кровянистых выделений по собственной инициативе провела УЗИ ОМТ, при котором врач установил показатель М-ЭХО 0,8см и выставил диагноз гиперплазия эндометрия, порекомендовал использовать дюфастон. Женщина безуспешно применяла дюфастон в течение 6 месяцев и только после усиления кровотечения поступила в стационар, где была выявлена аденокарцинома. Врач ультразвуковой диагностики не должен выставлять морфологический диагноз и тем более назначать лечение. При указанном показателе М-ЭХО, который в 2 раза превышает допустимый у женщины с менопаузой 8 лет, необходимо было рекомендовать выскабливание полости матки с диагностической целью. Полученные нами данные подтверждают высокую частоту ожирения в сравниваемых группах больных РТМ - 41,7-46,9%. Обращает внимание увеличение в последние годы числа женщин с ожирением третьей степени. Значительно возросла частота артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 типа. Известно, что ожирение представляет наибольший интерес, как фактор риска развития данной патологии. Увеличение массы жировой ткани возникает в результате изменений множества факторов энергетического гомеостаза. В жировой ткани происходит ароматизация андростендиона в эстрон, а последний активно превращается в эстрадиол [11]. Кроме того, при ожирении снижается синтез в печени глобулина, связывающего половые стероиды, и протеинов, связывающих инсулиноподобный фактор роста (ИПФР). В результате этих изменений повышается биодоступность эстрадиола и ИПФР 1 типа, что приводит к значительному увеличению, пролиферативных процессов в эндометрии [12]. Следовательно, в настоящее время имеется возможность профилактики гиперпластических процессов путем нормализации метаболических нарушений, а также доклинической диагностики РТМ.

Выводы

1. Рак тела матки в текущее время, так же как и 40 лет назад, в основном развивается в постменопаузе.
2. Возраст постменопаузальных больных раком тела матки в настоящее время на 11 лет старше, чем 40 лет назад, продолжительность менопаузы у 52% составляет более 19 лет, у 44% больных менопауза наступает старше 52 лет.
3. У больных доменопаузального возрастного периода развитию рака эндометрия предшествуют длительные, рецидивирующие маточные кровотечения, обусловленные гиперпластическими процессами эндометрия.
4. Современные больные РТМ чаще страдают ожирением 3 степени, артериальной гипертензией, сахарным диабетом 2 типа.
5. Особого внимания заслуживает факт увеличения развития РТМ в пре- и постменопаузе в миоматозно-измененной матке небольших размеров.
6. Необходимо усилить внимание гинекологов, терапевтов, эндокринологов, на женщин, страдающих ожирением, СД 2 типа, рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия, с наличием миомы в пре и постменопаузе – как к группе риска по РТМ, требующим диспансеризации с использованием 2 раза в год трансвагинального УЗИ.

Список литературы

1. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. М.: Медицина, 1989.- С. 275-296.
2. Вишневская Е.Е. Справочник по онкогинекологии.- Минск, 1980.
3. Гинекология по Эмилю Новаку.- М., 2002.-С. 665-700.
- Исина К.Т. Клинико-гормональная характеристика больных с предраками эндометрия. Автореф. дисс. к. м.н.- Алма-Ата, 1968.
3. Матасова Е.И. Диагностика и лечение сочетанных гиперпластических процессов мио-эндометрия: ... автореф. дис. к.м.н.к.- Алма-Ата, 1994.
4. Мезинова Н.Н. Функциональное состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в процессестарения, при предраке и раке тела матки: ... автореф. дисс.

5. Мезинова Н.Н., Богданова А.Г., Кожаназарова Ю.С. Краевые и возрастные особенности эндокринной системы при раке матки и молочной железы.- Алма-Ата, 1977.-С. 38-59.
6. Патрушева А.С. Патогенетическое обоснование формирования групп риска. Диагностика, профилактика рака эндометрия у больных миомой матки: ... автореф. дисс. канд. мед. наук.- Алма-Ата, 1982.
7. Станевич И.В., Сидорова И. С. и др. Клинические, морфологические и молекулярные особенности гиперпластических заболеваний матки, практические выводы// Мат. 12 форума «Мать и дитя».- М., 2011.- С. 424.
8. Рак тела матки / Под редакцией О.Л. Смахиной.- Алматы, 1980.
9. Bulcz.PE. N. //Engl. Med. J.- 1994.- Vol. 330, №15.- P. 1062-1069.
10. Kaaks R., Lukanova A., Kuznez M.S. // Cancer Epidemiol. Bio- markers Prevent.- 2002.-Vol. 11.-P.1591-1543.

Тұжырым

Зерттеудің максаты - жатыр денеа қатерлі ШӘШЦ саны жетеуің МҮмкін себептерін анықтау.

Әдәттер мен материалдар: материал ретінде ОЦКА - ға 2007 -2011ж жатырдан қан кетумен тҮскен 34 наукас және жатыр денесің қатерлі ісігіне 1965 -1969ж ЦзОжРГЗИ ота жасалған 32 наукас алынды.

Зерттеу әдістері: клиникалық, зертханалық, статистикалық. Барлық наукастарда диагноз эндометрий жағындысын немесе алып тасалған іді морфологиялықзерттеумен верификацияланған. Семздік дәрежесі ДСИ (ИМТ) - мен анықталды. ІІ дәрежелі семіздік ДСИ 40 - тан жоғарыларда анықталды. Алынған мәліметтер статистикалық еңдеуден етті, салыстырмалы топтардың айырмашылықтары Стьюдент критерийімен бағаланды. Керсетіштер айырмашылығы $P < 0,05$ болғанда дұрыс деп есептелді.

Қазіргі кездегі менопаузадағы наукастар саны 40 жыл бұрынғымен салыстырғанда айтарлықтай жоғары екені нақтыланған. Қазіргі кездегі жатырдың қатерлі ісігімен ауыратын наукастарда, 40 жыл бұрынғымен салыстырғанда, менопауза кеш басталады және си-

рек босанады. Қатерлі Шк жиі миоматозды езгерген жатырда анықталады. Эндокринді - зат алмасу ауруларының (семіздік, қант диабеті 2 түрі, артериальды гипертензия, іімі ІІІ дәрежелі семіздік) жоғарылауға тенденциясы байқалады.

Алынған мәліметтер ағзаның қартаюының және эндокринді - зат алмасу ауруларының, жатыр денеа қатерлі ШӘШЦ есуіне әсеріт дәлелдейді.

Summary

The purpose of the study - to examine possible reasons for the increasing incidence of cancer of the corpus uteri.

Materials and Methods: The material included 34 patients with uterine body cancer presenting with uterine bleeding in the City Clinical Hospital in 2007-2011 and 32 patients with uterine body cancer who treated in Oncology and Radiology institute in 1965-1969 years.

Methods: This study used Clinical, laboratory, and statistical. All of patients whom verified diagnosis Cancer Uteri using of morphological investigation of scraping endometrium or the operative material. The degree of obesity was defined by BMI. Obesity is determined by third grade BMI greater than 40. The obtained data were statistically processed, significance of differences between investigated groups was assessed by Student criteria. The difference between the indices were considered significant at $P < 0,05$.

Our investigation showed the age of post-menopausal patients is more than 40 years ago. The point of menopause was started in women oldest 52 age. More often the cancer of uteri combined with myoma uteri. There is a tendency to an increase in endocrine-metabolic diseases: obesity, diabetes type 2, arterial hypertension. The third degree of obesity was prevalent.

According to our investigation the increasing of life period and the endocrine - metabolic disorders could be the cause of rise of uterine cancer.

УДК: 618.14+/.146-006.6-08-059

М.Р.Кайрбаев, Ж.К. Чингисова, Е.К. Кукубасов, Р.Ш. Шалбаева, Ж. Досаханов
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Роль неоадьювантной полихимиотерапии в лечении онкогинекологического рака

Аннотация. Современная лекарственная терапия рака является перспективным методом лечения злокачественных опухолей, в том числе онкогинекологического рака.

Материал и методы. Клинический материал составил 50 больных РШМ и 73 пациенток РТМ.

При исследовании выделены по 2 группы: в первую группу (основную) включено 20 пациенток РШМ, которым проведен метрономный курс полихимиотерапии и 35 больных РТМ, которым проведены неоадьювантные курсы полихимиотерапии. Всем больным проведено оперативное вмешательство.

Полученные результаты с применением полихимиотерапии в неоадьювантном режиме при раке шейки и тела матки свидетельствовали об эффективности лечения этих больных.

Применение метрономной полихимиотерапии показало значительную эффективность у ранее не леченых больных РШМ - 95% (частичная регрессия+стабилизация процесса). Восстановление функции мочевого пузыря, после нервосберегающих операций происходит в среднем на 11±4,7 суток раньше, что существенно сказывается на качестве жизни пациенток с РШМ и имеет положительный экономический эффект.

Метод комплексной терапии с применением неоадьювантной полихимиотерапии по предложенной схеме у больных раком тела матки позволил получить: терапевтический эффект в 74,3% случаев; непосредственный эффект был выше у больных II стадией (степень регрессии более 75% установлена в 71,4±5,9% случаев); оценка лекарственного патоморфоза установила II-III степени повреждения в 88,5% случаев.

Проблема онкогинекологического рака продолжает оставаться актуальным вопросом научных исследований в онкологии. Среди злокачественной патологии репродуктивной системы у женщин рак тела матки выходит на 2 место, а рак шейки матки на 3 место в экономически развитых странах и России (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2010) [1].

Исследования по вопросам применения химиотерапии при лечении больных раком тела матки не теряют своей актуальности. Проведение неоадьювантной полихимиотерапии при раке тела матки оказалось эффективным при наличии ряда неблагоприятных прогностических факторов. Так при умеренно- и низкодифференцированных опухолях эндометрия применение двух курсов неоадьювантной внутриартериальной полихимиотерапии позволяет добиться 80%-ой регрессии первичных опухолей у 75%

больных (Байназарова А.А., 2001) [2].

Рак шейки матки относится к числу тех опухолей, у которых возможности дополнительного использования химиотерапевтических препаратов весьма ограничены, в силу известной незначительной их эффективности при этой патологии.

Определенные достижения лекарственной терапии по разработке принципов и режимов комбинированной химиотерапии с цикловым последовательным введением противоопухолевых препаратов привели к новой волне использования лекарственных средств, в том числе и при лечении рака шейки матки.

Современная лекарственная терапия рака является перспективным методом лечения злокачественных опухолей. Актуальным является расширение ее возможностей за счет совершенствования стандартных методик и создания новых схем по механизму действия противоопухолевых агентов (Резцова В.В., 2007; Fleming G.A., 2008 [3, 4]. Правильное ее использование с другими традиционными методами (хирургическим и лучевым) лечения создает реальную возможность помощи онкологическим больным (Акимов А.А., 2001) [5].

Материал и методы

Клинический материал исследования составил 50 больных раком шейки матки. Распределение больных в группах были сопоставимы по основным клиническим признакам. 20 больным (I группа, пациентки с опухолью более 4,0 см.) раком шейки матки проведено комбинированное лечение, включающее полихимиотерапию в метрономном режиме и оперативное лечение. 30 больных (II группа, пациентки с опухолью не более 4,0 см.) получили лечение в объеме хирургического вмешательства. Распределение больных по стадиям выглядело следующим образом: Ib1 стадия установлена у 16 (32,0±4,9%) больных, Ib2 стадия выявлена у 13 (26,0±5,5%), IIa1 стадия диагностирована у 14 (28,0±5,7%) женщин, процент больных, имевших IIb2 стадию, составил 14,0±5,6% - 7 пациенток.

Исследования по раку тела матки основаны на 73 больных. Распределение пациентов в сравниваемых группах (1 и 2) были сопоставимы по основным клиническим признакам. 35 больным раком эндометрия проведено комплексное лечение, включающее неоадьювантную химиотерапию, оперативное лечение и послеоперационный курс лучевой терапии. Распределение по стадиям было следующим: I стадия установлена у 44 (60,3±4,7%) больных. Из них в основной (первой) группе пациенток с I стадией было 21 (60,0±5,7%) человек, в сравниваемой (второй) 23 (60,5±5,7%). II стадия процесса выявлена у 20,5±4,0% больных; в основной группе процент больных, имевших II стадию, составил 20,0±5,6%, в контрольной - 21,1±4,7%. Пациенток с III стадией было

19,2±3,3%, в основной (1) группе – 20,0±4,6%, во второй 18,4±4,5%.

По характеристике лечебного воздействия при раке шейки матки были выделены 2 группы больных. В первую группу включено 20 пациентов с Ib2 и IIa2 стадией, которым проведен метронульный курс полихимиотерапии по схеме: цисплатин 60 мг/м² 1 день + иринотекан 60 мг/м² в 1, 8, 15 дни, в последующем выполнено оперативное вмешательство. Всем больным назначалась стандартная антиэметическая терапия, включающая в себя премедикацию кортикостероидами и блокаторами H2 гистаминовых рецепторов в процессе инфузии и в течение 3 последующих дней.

Оценка лечебного эффекта основывалась на анализе истории болезни, физикальных методов обследования, УЗИ органов малого таза. Общий анализ крови выполнялся трижды в течение цикла химиотерапии. Биохимические показатели и осмотр проводились перед и после проведения метронульного курса. Оценка терапевтического эффекта проводилась после курса полихимиотерапии. Лечение проводилось при количестве нейтрофилов более 1,5 на 10⁹ и количестве тромбоцитов более 100 тыс. в мл. Снижение доз предусматривалось при стойкой нейтропении не поддающейся коррекции.

По характеристике лечебного воздействия при раке тела матки выделены следующие 2 группы больных: в первую группу включено 35 больных умеренно- и низкодифференцированной формой I-III стадии рака эндометрия, которым проведены неoadъювантные курсы полихимиотерапии по схеме: цисплатин 50 мг/м² + 5фторурацил 500-700 мг/м² + циклофосфан 500 мг/м², в последующем выполнено оперативное вмешательство. В послеоперационном периоде проведена дистанционная лучевая терапия. Во вторую группу вошли 38 больных с умеренно- и низкодифференцированной формой I-III стадии рака эндометрия, получившие комбинированное лечение в объеме хирургического лечения и послеоперационного курса дистанционной лучевой терапии. Выбор объема хирургического лечения соответствовал стандартам оперативного лечения. Основным объемом операции являлась радикальная гистерэктомия второго типа. В случае поражения придатков основной объем дополнялся оментэктомией.

Общее состояние было удовлетворительным у большинства пациентов и равнялось 0-1 по шкале ECOG.

Весь материал был внесен в компьютерную базу данных. Статистическая обработка материала проводилась методом общей и корреляционной статистики с использованием компьютерного статистического пакета программы SPSS for Windows (версия 15.0).

Результаты исследований.

Для оценки непосредственной эффективности проведенной полихимиотерапии выделяются три градации степени регрессии опухоли после проведения химиотерапии, при которых регрессия опухоли соответствовала от 100% до 75%, 75-50% и менее 50%. Эффективным ответом на цитостатическое воздействие считается резорбция опухоли в пределах от 100% до 50%.

Непосредственные результаты лечения рака шейки матки (РШМ). В результате проведения полихимиотерапии (ПХТ) в метронульном режиме по данным ультразвукового исследования общий положительный эффект от проведенного лечения (100-50%) наблюдался у 95,0% больных, из них эффективность 100-75% отмечена у 35,0%. У

5,0% больных ответ на проведенную химиотерапию был слабым.

Из представленных данных в таблице 1 можно видеть, что у большинства женщин эффективность химиотерапии была выше 50%.

Таблица 1 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком шейки матки в зависимости от стадии процесса

Стадия n=20	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
Ib2 стадия	4 30,8±4,2	8 61,5±4,7	1 7,7±2,4
IIa2 стадия	3 42,9±5,9	4 57,1±4,6	0
Всего	7 35,0±6,4	12 60,0±5,6	1 5,0±2,3

* - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05

Согласно приведенным данным, степень регрессии опухолей достигала значений от 100 до 75% и от 75 до 50% у большинства пролеченных больных РШМ, что свидетельствует об эффективности проводимого предоперационного курса ПХТ.

Непосредственные результаты от проведения ПХТ в зависимости от гистологических форм приведены в таблице 2. Регрессия опухоли отмечена у больных с плоскоклеточной неороговевающей карциномой у 25,0±4,7% наблюдалась регрессия 100-75%, у 75,0±6,4% больных – эффективность 75-50%. У больных с плоскоклеточной ороговевающей карциномой степень регрессии 100% - 75% достигнута у 57,1±5,9% больных регрессия на 75% - 50% достигнута у 42,9±8,4% больных. У пациентки с мезонефرويدной аденокарциномой степень регрессии была ниже 50%.

Таблица 2 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком шейки матки в зависимости от гистологической формы опухоли

Гистологическая форма	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
Плоскоклеточный неороговевающий (n=12)	3 25,0±4,7	9 75,0±6,4*	-
Плоскоклеточный ороговевающий (n=7)	4 57,1±5,9*	3 42,9±8,4	-
Мезонефرويدная аденокарцинома (n=1)	-	-	1 100,0
Всего (n=20)	7 35,0±6,4	12 60,0±5,6	1 5,0±2,3

* - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05

Ультразвуковые исследования проводили до и после метронульного курса ПХТ. Средний объем опухоли эндометрия до лечения у больных раком шейки матки Ib2 стадии составил 91,27±16,84см³. В процессе лечения отмечается уменьшение объема опухоли до 42,71±7,82см³. Индекс эффективности составил 2,1.

Динамика регрессии опухоли в зависимости от стадии процесса представлена в таблице 3. Более выраженный ответ на проведение химиотерапии наблюдался при IIa2 стадии (коэффициент эффективности – 3,6). В этой группе больных средний объем опухоли до лечения составил 92,75±17,67см³, после проведения ПХТ объем уменьшился до 25,68±4,72см³.

Таблица 3 – Динамика регрессии опухоли шейки матки в зависимости от стадии процесса

Стадии процесса (n=20)	Объем опухоли в см ³		Индекс эффективности
	До лечения	После ПХТ	
Ib2 стадия	91,27±16,84	42,71±7,82	2,1
Ila2 стадия	92,75±17,67	25,68±4,72*	3,6

* - достоверность показателей регрессии объема опухоли в сравнении с объемом до лечения $p < 0,05$

В процессе химиотерапии были отмечены токсические побочные эффекты – гематологические и негематологические. Наиболее частым проявлением гематологической токсичности была лейкопения. Фебрильной нейтропении не было отмечено ни у одной больной. Негематологические осложнения в виде тошноты и рвоты были не выраженными. Алоpecia наблюдалась в 100% случаев. Смертей, связанных с токсичностью химиотерапии не было (таблица 4).

Таблица 4 – Гематологическая и негематологическая токсичность химиотерапии

Проявления токсичности	Степень				
	1	2	3	4	Всего
Анемия	5 (25%)	-	-	-	5 (25%)
Лейкопения	7 (35%)	1 (5%)	-	-	8 (40%)
Нейтропения	-	-	-	-	-
Тромбоцитопения	-	-	-	-	-
Алоpecia	-	-	-	-	20 (100%)
Тошнота/рвота	-	2 (10%)	-	-	2 (10%)
Диарея	3 (15%)	-	-	-	3 (15%)
Фебрильная нейтропения	-	-	-	-	-

Результаты применения метрономной полихимиотерапии, показали значительную эффективность у ранее не леченых больных – 95% (частичная регрессия+стабилизация процесса). В целом лечение удовлетворительно переносится, случаев отмены препаратов, либо прекращения лечения ввиду выраженной токсичности отмечено не было ни в одном из случаев.

У пациенток, получавших химиотерапию, не было отмечено существенных изменений в гематологических показателях, не было отмечено ни одного случая отмены препарата, либо прекращения лечения ввиду прогрессирования.

Всем пациенткам после метрономного курса ПХТ после нормализации клинико-лабораторных показателей произведено оперативное вмешательство. Оперативное лечение проводилось в объеме: Лапаротомия. Радикальная гистерэктомия III типа.

Пациентки вне зависимости от проведенной предоперационной терапии, были разделены на 2 группы. В первой группе, пациентки оперированы в обычном объеме: Лапаротомия. Радикальная гистерэктомия III типа. Во второй группе, пациенткам произведена нервосберегающая радикальная гистерэктомия III типа.

Из 50 пациенток, нервосберегающие операции проведены 14 (28%) пациенткам. Функция мочевого пузыря у данных пациенток восстанавливалась в среднем на 12-14 послеоперационные сутки (таблица 5).

Таблица 5 – Восстановление функции мочевого пузыря после нервосберегающих операций.

Таблица 6 – Характеристика операций. Интра- и послеоперационные осложнения

Осложнения	Количество, %	
	Нервосберегающая РГ (n=14)	Радикальная гистерэктомия (n=36)
Кровотечение	-	-
Мочеточниково-влагалищный свищ	-	1 (2,8%)
Нагноение послеоперационной раны	-	-
Дисфункция мочевого пузыря	1 (7,1%)	15 (41,7%)
Атония мочевого пузыря	-	1 (2,8%)
Полная эвентерация	-	-
Смерть	-	-
Характеристика оперативных вмешательств	Количество	
	Нервосберегающая РГ (n=14)	Радикальная гистерэктомия (n=36)
Продолжительность	198±22,6 мин.	161±19,8 мин.
Объем кровопотери	560±70,5 мл.	430±65,5

Таблица 6а

Функции органов	Нервосберегающая радикальная гистерэктомия III типа	Радикальная гистерэктомия III типа
Восстановление функции мочевого пузыря	12,6±3,4 сутки	23,4±4,5 сутки

Как видно из таблицы, восстановление функции мочевого пузыря, после нервосберегающих операций происходило в среднем на 11±4,7 суток раньше.

Характеристика оперативных вмешательств и осложнений интра-, послеоперационных представлена в таблице 6.

Продолжительность нервосберегающих операций была в среднем чуть больше 3 часов, когда средняя продолжительность операций без выделения нервных пучков на 30 минут менее продолжительна. Объем кровопотери при радикальной гистерэктомии около 400,0 мл. Незначительно больше кровопотеря при нервосберегающих радикальных гистерэктомиях. Однако достоверной разницы не выявлено. Анализ послеоперационных осложнений показал, что после радикальной гистерэктомии III типа в большинстве случаев встречалась дисфункция мочевого пузыря у 15 (41,7%) пациенток и атония мочевого пузыря у одной больной, что составило 2,8%. В течение послеоперационного периода данное осложнение было купировано у всех больных. Одна (2,8%) пациентка выписана с осложнением мочеточниково-влагалищный свищ. Через 2 месяца проведена операция по устранению свища.

Одной из задач исследования было изучить влияние коротких курсов ПХТ на инвазию опухоли в лимфоваскулярное пространство и метастазы в регионарных лимфатических узлах.

Таким образом, хирургическое лечение проведено всем 50 больным. Морфологическая характеристика послеоперационного материала представлена в таблице 7. Как видно из таблицы, в группе больных получавших ПХТ в метрономном режиме, опухолевые эмболы в сосудах и/или лимфатических щелях выявлены у 3 (15%)

пациенток, против 9 (30,0%) в группе с хирургическим лечением на I этапе. Сложно говорить о прямом влиянии химиотерапии на данный факт ввиду малочисленности исследуемого материала. Метастазы в лимфатические узлы обнаружены у 4 (20%) пациенток I группы, у больных, не получавших полихимиотерапию опухолевые клетки в тазовых лимфоузлах выявлены в 8 (26,7%) случаях.

Анализом данных морфологического исследования установлено, что метастазирование в лимфоваскулярное пространство больше в 2 раза в группе больных, которым не проводилась химиотерапия. И на 6,7 % больше обнаружено метастазов в тазовых лимфатических узлах.

По результатам гистологического исследования ориентировались в плане проведения послеоперационного лечения. У 13 (26%) больных выявлены метастазы в лимфоваскулярное пространство и тазовые лимфатические узлы. Данным больным назначена послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия.

Таблица 7 – Морфологическая характеристика опухоли

		Количество случаев абс., %	
		I группа	II группа
Гистологическая структура	Плоскоклеточный неороговевающий рак	12 (60,0±7,5)	17 (56,7±7,6)
	Плоскоклеточный ороговевающий рак	7 (35,0±5,5)	13 (43,3±6,3)
	Мезонефроидная аденокарцинома	1(5,0±1,7)	0
Глубина инвазии	нет инвазии	0	0
	до 0,5см	2 (10,0±3,2)	3 (10,0±3,4)
	до 1 см	8 (40,0±5,7)	11 (36,7±6,1)
	более 1 см	10 (50,0±6,2)	16 (53,3±7,5)
Инвазия в цервикальный канал	нет инвазии	13 (65,0±7,6)	11 (36,7±6,1)
	есть инвазия	7 (35,0±5,5)	19 (63,3±8,1)
Опухолевые эмболы в сосудах или лимфатич. щелях	нет	17 (85,0±8,5)	21 (70,0±8,3)
	есть	3 (15,0±3,5)*	9 (30,0±5,8)
Метастазы в лимфоузлы	нет метастазов	16 (8,0±8,2)	22 (73,3±8,5)
	есть метастазы	4 (20,0±4,2)	8 (26,7±5,6)
Край резекции влагалища	нет опухолевых клеток	19 (95,0±8,8)	29 (96,7±9,5)
	есть опухолевые клетки	1 (5,0±1,7)	1 (3,3±1,8)
Кардинальные и кресцово-маточные связи	нет опухолевых клеток	17 (85,0±8,5)	27 (90,0±9,1)
	есть опухолевые клетки	3 (15,0±3,5)	3 (10,0±3,4)
* - достоверность показателей метастазирования в лимфоваскулярное пространство в сравнении со II группой p<0,05			

Непосредственные результаты лечения рака тела матки (РТМ).

В результате проведения неоадьювантной полихимиотерапии по данным ультразвукового исследования общий положительный эффект от

проведенного лечения (100-50%) наблюдался у 74,3% больных РТМ, из них эффективность 100-75% отмечена у 45,7%. У 25,7% больных ответ на проведенную химиотерапию был слабым.

Из представленных данных в таблице 8 следует, что при I стадии заболевания число случаев при всех степенях эффективности было одинаковым по 33,3%. Общий положительный эффект наблюдался у 66,6% больных РТМ.

Таблица 8 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком тела матки в зависимости от стадии процесса

Стадия n=35	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
I стадия	<u>7</u> 33,3±8,0	<u>7</u> 33,3±8,0	<u>7</u> 33,3±8,0
II стадия	<u>5</u> 71,4±5,9 *	<u>1</u> 14,3±7,6	<u>1</u> 14,3±7,6
III стадия	<u>4</u> 57,1±5,9	<u>2</u> 28,6±7,6	<u>1</u> 14,3±8,4
Всего	16 45,7±8,4	10 28,6±7,6	9 25,7±7,4
* - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05			

У больных с II стадией злокачественного процесса показатель общей эффективности составил 85,7%. Степень регрессии опухоли в пределах от 100 до 75% отмечена в 71,4±5,9% (p<0,05), от 75 до 50% и менее 50% в одинаковом числе случаев (14,3±7,6%).

Среди больных III стадией рака тела матки непосредственный эффект наблюдался также у 85,7% больных, однако отмечены различия в достижении процента регрессии опухолевого процесса, так частота полных регрессий процесса была несколько ниже - в 57,1%, что связано со степенью распространенности опухоли. Степень регрессии опухоли в пределах от 75 до 50% установлена в 28,6% случаев соответственно, менее 50% - у одной больной.

Согласно приведенным данным, степень регрессии опухолей II и III стадии достигала значений от 100 до 75% и от 75 до 50% у большинства пролеченных больных РТМ, что свидетельствует об эффективности проводимых предоперационных курсов ПХТ.

В таблице 9 приведены показатели непосредственных результатов ПХТ у больных раком тела матки в зависимости от возрастного периода. В группе больных репродуктивного возраста было одинаковое число случаев (50,0±8,2%) ответивших на химиотерапию и не давших ответа на нее, при этом регрессия опухоли отмечена от 75 до 50%. В группе пременопаузальных больных регрессия опухоли от 100 до 75% зарегистрирована в 45,5±8,4%, от 75 до 50% - в 36,3±8,1% случаев. И только у двух женщин опухоль уменьшилась менее чем на 50%. У женщин в менопаузе этот показатель оказался несколько выше 50,0% и 22,7% при регрессии 100-75% и 75-50% соответственно. Как видно, больших различий в степени регрессии опухоли под влиянием ПХТ во 2-ой и 3-ей возрастных группах не наблюдалось.

Таблица 9 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком тела матки в зависимости от возрастного периода

Возрастные группы (n=35)	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
Репродуктивный	-	<u>1</u> 50,0±8,5 *	<u>1</u> 50,0±8,5 *

Таблица 10 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком тела матки в зависимости от гистологической формы опухоли

Гистологическая форма	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
Умереннодифференцированная аденокарцинома (n=24)	<u>15</u> 62,5±5,7	<u>4</u> 16,7±4,4	<u>5</u> 20,8±4,8
Низкодифференцированная аденокарцинома (n=7)	<u>1</u> 14,2±5,9 **	<u>3</u> 42,9±8,4	<u>3</u> 42,9±8,4
Другие формы (n=4)	-	<u>3</u> 75,0±7,3 *	<u>1</u> 25,0±7,3 *
Всего (n=35)	<u>16</u> 45,7±8,4	<u>10</u> 28,6±7,6	<u>9</u> 25,7±7,4
* - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05			
** - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,01			

Пременопаузальный	<u>5</u> 45,5±8,4	<u>4</u> 36,3±8,1	<u>2</u> 18,2±6,5
Менопаузальный	<u>11</u> 50,0±8,5	<u>5</u> 22,7±7,1	<u>6</u> 27,3±7,5
Всего (n=35)	<u>16</u> 45,7±8,4	<u>10</u> 28,6±7,6	<u>9</u> 25,7±7,4
- достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05			

Непосредственные результаты от проведения ПХТ в зависимости от гистологических форм приведены в таблице 10. Регрессия опухоли отмечена у больных с умереннодифференцированными формами у 62,5±5,7% наблюдалась регрессия 100-75%, у 16,7±4,4% больных – эффективность 75-50%, и степень регрессии опухоли менее 50% зарегистрирована у 20,8±4,8%. У больных с низкодифференцированной аденокарциномой степень регрессии 100% - 75% достигнута у 14,3±5,9% больных регрессия на 75% - 50% достигнута у 42,9±8,4% больных.

Ультразвуковые исследования проводили в процессе комплексного лечения рака эндометрия для контроля динамики объема опухоли под влиянием ПХТ. Средний объем опухоли эндометрия до лечения у больных раком тела матки основной группы составил 5,7±1,7см³. В процессе лечения отмечается уменьшение объема опухоли до 3,9±1,8см³ после 1 курса полихимиотерапии и 2,8±1,9см³ после 2 курса.

Динамика регрессии опухоли в зависимости от стадии процесса представлена в таблице 11.

В группе больных I стадии рака тела матки средний объем опухоли до лечения составил 5,2±2,5см³, после проведения двух курсов ПХТ объем уменьшился до 2,7±1,7см³. Индекс эффективности составил после 1го курса 1,4 и после 2 курса 1,9.

Более выраженный ответ на проведение химиотерапии наблюдался при II и III стадиях (коэффициент эффективности после первого курса - 1,5). Причем, при II стадии эффект был выше. Объем опухоли до лечения при II и III стадиях составил 6,6±3,9см³ и 7,4±1,7см³; после 2 курса ПХТ объемы достигли 2,9±0,8см³ и 3,7±0,9см³ соответственно (p<0,05). Коэффициент эффективности после 2го курса химиотерапии при II стадии – 2,3, тогда как при III стадии 2,0.

Таблица 11 – Динамика регрессии опухоли в полости матки в зависимости от стадии процесса

Стадии процесса (n=35)	Объем опухоли в см ³			Индекс эффективности	
	До лечения	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ
I стадия	5,2±2,5	3,7±2,1	2,7±1,7	1,4	1,9
II стадия	6,6±3,9	4,4±1,1	2,9±0,8*	1,5	2,3
III стадия	7,4±1,7	4,9±1,3	3,7±0,9*	1,5	2,0
* - достоверность показателей регрессии объема опухоли в сравнении с объемом до лечения p<0,05					

Эффективность применения ПХТ была проанализирована у больных раком тела матки в различных возрастных группах (таблица 12). Объем опухоли до лечения у больных репродуктивного возраста составил 7,5±2,8см³, у пременопаузальных больных – 4,8±1,1см³, у больных в менопаузе – 5,9±1,2см³.

Таблица 12 – Динамика регрессии опухоли в полости матки у больных раком тела матки в различные возрастные периоды

Возрастные группы (n=35)	Объем опухоли в см ³			Коэффициент эффективности	
	До лечения	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ
Репродуктивный	7,5±2,8	4,7±1,7	3,8±1,5	1,6	2,0
Пременопаузальный	4,8±1,1	3,4±0,9	2,3±0,8*	1,4	2,1
Менопаузальный	5,9±1,2	4,1±1,4	3,0±0,9*	1,4	2,0
* - достоверность показателей регрессии объема опухоли в сравнении с объемом до лечения p<0,05					

Во всех возрастных группах после проведения 1 курса ПХТ отмечена тенденция к уменьшению объема опухоли (p<0,05), тогда как после 2 курса наблюдалась достоверная разница между величиной опухоли до и после лечения (p<0,01 и p<0,05). Индекс эффективности в этих группах от 2,0 до 2,5.

Во II возрастной группе уже после 1 курса ПХТ зарегистрировано значительное уменьшение опухолей от 6,8±1,4см³ до 4,4±0,9 см³ (p<0,05), и к моменту оперативного лечения этот показатель был равен 2,7±0,8см³ (p<0,01). Проведенный анализ показывает, что возраст больных не оказывает особого влияния на уменьшение размеров опухоли в процессе ПХТ.

Прослежена динамика изменений объема опухоли при различных гистологических вариантах (таблица 13). Наибольший объем опухоли до лечения (10,8%) наблюдался при опухолях железисто-плоскоклеточной и светлоклеточной формы, которые были объединены в группу других форм опухоли. У этих больных РТМ отмечался наиболее выраженный эффект от проведения химиотерапии, коэффициент составил 2,3, однако разница в показателях была недостоверной.

Таблица 13 – Динамика регрессии опухоли в полости матки в зависимости от гистологической формы

Гистологи- ческая форма (n=35)	Объем опухоли в см ³			Индекс эффект-сти	
	До лечен.	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ
Умереннодиф- ференцированная аденокарцинома	5,2±1,3	3,4±1,2	2,5±1,0	1,6	2,1
Низкодифферен- цированная аде- нокарцинома	5,6±0,9	3,8±1,2	3,2±1,1*	1,5	1,8
Другие формы	10,8±3,6	7,8±2,5	4,6±2,1	1,4	2,3

* - достоверность показателей регрессии объема опухоли в сравнении с объемом до лечения $p < 0,05$

Достоверные результаты уменьшения объема опухоли под воздействием цитостатических агентов получены при низкодифференцированных формах аденокарциномы эндометрия. В этой группе больных до лечения объем опухоли составил $5,6 \pm 0,9 \text{ см}^3$, после проведения 2х курсов химиотерапии объем уменьшился до $3,2 \pm 1,1 \text{ см}^3$ ($p < 0,05$), коэффициент эффективности составил 1,8.

Таким образом, применение полихимиотерапии в неoadъювантном режиме при раке шейки и тела матки является одним из важных моментов в современном лечении этих больных, и позволили сделать следующие выводы:

- В группе больных получавших ПХТ в метронежном режиме, опухолевые эмболы в сосудах и/или лимфатических щелях выявлены у 15% пациенток, против 30,0% в группе с хирургическим лечением на I этапе. Сложно говорить о прямом влиянии химиотерапии на данный факт ввиду малочисленности исследуемого материала. Метастазы в лимфатические узлы обнаружены у 20% пациенток, в группе не получавших полихимиотерапию опухолевые клетки в тазовых лимфоузлах выявлены в 26,7% случаях.

- Применение метронежной полихимиотерапии показало значительную эффективность у ранее не леченых больных РШМ – 95% (частичная регрессия+стабилизация процесса). Лечение больными переносится удовлетворительно, случаев отмены препаратов, либо прекращения лечения ввиду выраженной токсичности отмечено не было ни в одном из случаев.

- Восстановление функции мочевого пузыря, после нервосберегающих операций происходит в среднем на $11 \pm 4,7$ суток раньше, что существенно сказывается на качестве жизни пациенток с РШМ и имеет положительный экономический эффект.

- Сравнение хирургического лечения инвазивно-го РШМ при традиционной и нервосберегательной технике РГ показало, что нет достоверной разницы в продолжительности операции, объеме кровопотери. Выявлена положительная корреляционная зависимость между нервосберегающей операцией и сроками восстановления функции мочевого пузыря и отрицательная с развитием послеоперационных осложнений.

- Метод комплексной терапии с применением неoadъювантной полихимиотерапии по предложенной схеме у больных раком тела матки позволил получить:

а) терапевтический эффект в 74,3% случаев.

б) непосредственный эффект был выше у больных II стадией (степень регрессии более 75% установлена в $71,4 \pm 5,9\%$ случаев).

в) оценка лекарственного патоморфоза установила II-III степени повреждения в 88,5% случаев ($p < 0,05$).

- Непосредственные результаты больных РТМ показали, что наиболее выраженный эффект от химиотерапевтического лечения наблюдается при II и III стадиях злокачественного процесса не зависимо от возраста. При этом более выраженный эффект отмечается при II стадии заболевания.

- Имеется тенденция лучшего ответа на цитостатическое воздействие при низкодифференцированных аденокарциномах, железисто-плоскоклеточном и светлоклеточной формах эндометриоидной аденокарциномы.

Список литературы

1. Давыдов М.И., Аксель Е. М. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России и стран СНГ в 2008 г. // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина. РАМН. - 2010. - С. 52-62.
2. Байназарова А. А. Внутриаартериальная полихимиотерапия в комплексном лечении рака тела матки: автореф. ... докт. мед. наук. - Алматы, 2001. - 39 с.
3. Резцова В.В. Роль повреждений ДНК в регрессии опухолей после химиотерапии // Вопр. онкол. - 2007. - Т. 53, № 3. - С. 262-268.
4. Fleming G. Adjuvant Therapy for High-risk Adenocarcinoma of the Uterus // ASCO, 2008. - P 230-233.
5. Акимов А. А., Иванов С.Д., Хансон К.П. Апоптоз и лучевая терапия злокачественных новообразований // Вопр. онкол. - 2003. - Т. 49. - С. 261-9.

Summary

M.R.Kayrbaev, Zh.K. Chingissova, E.K. Kukubasov, R.Sh. Shalbaeva, Zh.A.Dossakhanov

The role of neoadjuvant chemotherapy in the treatment of gynecological cancer

Keywords: cervical cancer, uterine cancer, neoadjuvant chemotherapy

We have studied two groups of patients: the main group of 20 patients with cervical cancer underwent metronomic and the group of 35 patients with cancer of the uterine body underwent neoadjuvant chemotherapy. All patients underwent surgical treatment.

The use of metronomic chemotherapy showed significant efficiency of treatment of patients with cervical cancer- 95% (partial response and stabilization process.)

Bladder function after nerve-sparing surgery is restored in 11 $\pm$ 4.7 days earlier, which significantly affects the quality of life of patients with cervical cancer and has a positive economic effect.

Complex therapy with the use of neoadjuvant chemotherapy according to the proposed scheme for patients with cancer of the corpus uteri yielded: therapeutic effects in 73.4% of cases, the effect was greater with patients with stage I (the degree of regression of 75% was in 71.4 $\pm$ 5.9% cases), drug pathomorphosis II-III degree damage is set in 88 cases.

The results of application of chemotherapy in treatment of patients with cervical cancer and cancer of the uterine body prove the efficiency of treatment of these patients

Тұжырым

М.Р.Қайрбаев, Ж.К.Чингисова, Е.К.Кукубасов, Р.Ш.Шалбаева, Ж.Досаханов

Онкогинекологиялық қатерлі ісіктерін емдеудегі неoadъювантты полихимиотерапияның маңызы

Бұл жұмыста 2 топтағы науқастар зерттелді: жатыр мойны қатерлі ісігі сырқатымен ауырған негізгі топтағы 20 науқасқа полихимиотерапияның

(ПХТ) метрономды курсы және жатыр денесінің қатерлі ісігімен ауырған 35 науқасқа адьюванты емес полихимиотерапия курсы жүргізілді.

Метрономды полихимиотерапияны қолдану жатыр мойны қатерлі ісігі сырқатымен емделмеген науқастардың емдеу нәтижесінің 95% кетерілгені байқалды (жартылай регрессия + процесстің тұрақталуы). Нервкорғау операциясынан кейін қуық қызметінің орнына келуі орташа есеппен 11+4,7 тәулікке ерте болады, бұл жатыр мойны қатерлі ісігі сырқатымен ауырған науқастардың өмір сүру сапасына біршама әсер етеді және оң экономикалық нәтиже береді.

Жатыр қатерлі сырқатымен ауырған науқастарға ұсынылған кесте бойынша адьюванты емес ПХТ қолданылған комплексті емдеу - келесі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді: терапиялық әсер 74,3% жаздайда; тәжірибесі 2 сатылы науқастарда жазары

нәтиже берді (75%-дан жазары регрессия дәрежесі $71,4 \pm 5,9\%$ жаздайда анықталды); 88,5% жаздайда II-III дәрежедегі дерлік патоморфоз анықталды.

Жатыр денесінің қатерлі ісігімен және жатыр мойны қатерлі ісігімен ауыратын науқастарды адьюванты емес ПХТ қолдану арқылы алынған нәтижелер, осы науқастарға емнің тиімді екендігінің куәсі болады.

Түпінді сөздер жатыр мойнының қатерлі ісігі, жатыр денесінің қатерлі ісігі, неоадьюванты полихимиотерапия.

M.R.Kayrbaev, Zh.K. Chingissova, E.K. Kukubasov, R.Sh. Shalbaeva, Zh.A.Dossakhanov

The role of neoadjuvant chemotherapy in the treatment of gynecological cancer

Keywords: cervical cancer; uterine cancer; neoadjuvant chemotherapy

УДК:618.14+/.146-006.6-08--059

Чингисова Ж.К., Кайрбаев М.Р., Кукубасов Е.К.,
Шалбаева Р.Ш., Досаханов Ж.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Выживаемость больных раком тела и шейки матки при использовании неоадьювантной полихимиотерапии

Аннотация. Работа основана на анализе выживаемости больных раком тела (РТМ) и шейки (РШМ) матки, получивших лечение с использованием неоадьювантной полихимиотерапии (НПХТ). НПХТ при РТМ увеличила как общую (86,9%), так и безрецидивную (70,0%) выживаемость больных против 80,2% и 56,2% соответственно при комбинированном лечении. При РШМ с НПХТ общая пятилетняя выживаемость составила 75,0%, безрецидивная 66,7%, тогда как после сочетанной лучевой терапии показатели были 64,0% и 46,6%, являющаяся основным и общепринятым методом лечения местнораспространенного РШМ.

Рак тела матки (РТМ) относится к ведущей патологии в онкогинекологии экономически развитых стран. Так среднегодовой прирост стандартизованного показателя заболеваемости женщин РТМ в России составляет 3,1% [1]. Ежегодно в мире выявляется около 400000 первичных больных РШМ, из которых почти половина умирают в течение первого года в связи с поздним диагностированием заболевания [2]. В Республике Казахстан процент запущенных форм РШМ (III-IV стадии) остается высоким, составляя в 2007 году в среднем 27,5%, однако в отдельных регионах эта цифра достигает 50,6% [3]. Высокие показатели запущенности РШМ, а также рост заболеваемости среди женщин молодого возраста диктуют необходимость разработки новых и совершенствования уже существующих методов комбинированного и комплексного лечения. Стандартными методами лечения местнораспространенных форм РШМ считаются лучевая терапия, хирургический метод или их комбинация [4]. Однако более чем у 50% больных возникают рецидивы заболевания уже в первые 2 года после окончания лечения (Сидоренко Ю.С.). Изучение неблагоприятных исходов сочетанной лучевой терапии 371 больной с местнораспространенным РШМ показало, что генерализация процесса у 26,3% больных наступает в течение первого года от начала лечения. Короткий период между лечением и прогрессированием опухоли у этих больных свидетельствует о недостаточной эффективности местно-регионарной лучевой терапии и наличии микрометастазов опухоли, не диагностируемых на этапе обследования к моменту выбора лучевого лечения [5].

По данным литературы известно [1, 6], что подавляющее большинство случаев прогрессирования заболевания и смертности от рака эндометрия приходится на первые три года жизни после лечения [7]. Кроме того, результаты лечения при наблюдении больных раком тела матки в течение трех и пяти лет не показали существенных разли-

чий в показателях, поэтому трехлетний период считается основным показателем отдаленных результатов лечения больных раком эндометрия.

Материал и методы

Клинический материал исследования составили больные раком тела (РТМ) и шейки матки (РШМ). По характеристике лечебного воздействия при раке тела матки выделены следующие 2 группы больных: в первую (основную) группу включено 35 больных умеренно- и низкодифференцированной формой I-III стадии рака эндометрия, которым проведены неоадьювантные курсы полихимиотерапии по схеме: цисплатин 50 мг/м² + 5фторурацил 500-700 мг/м² + циклофосфан 500 мг/м², в последующем выполнено оперативное вмешательство. В послеоперационном периоде проведена дистанционная лучевая терапия. Во вторую группу (контрольную) вошли 38 больных с умеренно- и низкодифференцированной формой I-III стадии рака эндометрия, получившие комбинированное лечение в объеме хирургического лечения и послеоперационного курса дистанционной лучевой терапии.

При раке шейки матки проводилась системная неоадьювантная полихимиотерапия (НПХТ) у 27 больных с морфологически подтвержденным диагнозом. Химиопрепараты вводились в периферическую либо центральную вену после предварительной гипергидратации и премедикации по следующей схеме: цисплатин 75 мг/м² в 1 день, гемзар 800-1000 мг/м² в 1 и 8 дни. С повторением курсов каждые три недели.

Общее состояние было удовлетворительным у большинства пациентов и равнялось 0-1 по шкале ECOG.

Весь материал был внесен в компьютерную базу данных. Статистическая обработка материала проводилась методом общей и корреляционной статистики с использованием компьютерного статистического пакета программы SPSS for Windows (версия 15.0).

При определении выживаемости использован актуальный способ Life tables и метод Kaplan-Meier, влияние изучаемых параметров на показатели выживаемости изучено с помощью регрессионной модели пропорционального риска Кокса.

Результаты исследований

При изучении выживаемости больных раком тела матки в исследовании анализируются как трехлетние, так и пятилетние исходы заболевания (таблица 1). При этом показатели пятилетней выживаемости рассчитывались

актуриальным методом.

Таблица 1 – Результаты лечения больных раком тела матки по видам лечения

Виды лечения	Выживаемость (М±m)%	
	3 года	5 лет
Комплексное (основная группа)	88,4±2,1	86,9±2,3
Комбинированное (контрольная группа)	82,0±2,1*	80,2±2,2*

Примечание - * - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$ статистическая достоверность между группами по сравнению с комплексным лечением

Как видно из таблицы, общая 3-летняя выживаемость для пациентов основной группы составила 88,4±2,1%. В группе больных РТМ, где больным проводили комбинированное лечение, показатель был 82,0±2,1%, при сочетании лучевой терапии показатель составил 67,4±2,3%.

Отдаленные результаты 3х и 5-летней выживаемости больных раком эндометрия показали, что общая 5-летняя выживаемость у больных, получивших комплексное лечение, была на 6,7% и 21,8% выше, чем при комбинированной терапии соответственно.

В работе были оценены отдаленные результаты лечения в зависимости от возраста, стадии и гистологической дифференцировки опухоли (таблица 2). Обращают на себя внимание данные о влиянии этих факторов на выживаемость больных.

Таблица 2 – Отдаленные результаты лечения больных раком тела матки в зависимости от возраста, стадии и гистологической структуры (в%)

группы исследования		выживаемость	
Репродуктивный возраст	группы	3 года	5 лет
	I- Основная	100	100
	II - Контрольная	100	100
Пременопаузальный возраст	I- Основная	83,1±2,3	81,2±2,1*
	II - Контрольная	77,2±2,5	75,4±2,2
Менопаузальный возраст	I- Основная	81,8±3,5*	77,4±3,2*
	II - Контрольная	69,1±3,3	66,0±3,1*

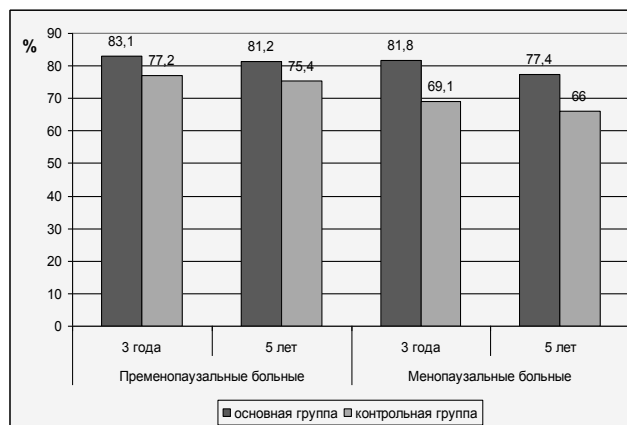


Рисунок 1 - Выживаемость больных РТМ в зависимости от возраста (пременопаузальные, менопаузальные больные) по видам лечения (%)

Первая стадия	I- Основная	97,4±1,3	95,9±1,1
	II – Контрольная	95,6±1,4	93,8±1,2
Вторая стадия	I- Основная	91,3±3,1*	89,8±3,1*
	II – Контрольная	82,9±3,0	80,7±2,9
Третья стадия	I- Основная	75,2±2,7	73,1±2,7
	II – Контрольная	67,7±2,8	65,1±2,6
Умеренно-дифференцированная	I- Основная	90,6±1,9	89,7±1,8*
	II – Контрольная	86,4±1,7	84,8±1,8
Низко-дифференцированная	I- Основная	83,8±2,2*	82,1±2,1*
	II – Контрольная	77,4±2,3	75,6±2,2

* $p < 0,05$ между группами исследования

Анализируя отдаленные результаты лечения больных раком тела матки с учетом возраста, особое внимание уделено выживаемости пациенток пременопаузального и менопаузального периодов жизни. По анализу результатов лечения больных раком тела матки с учетом возрастного периода, вне зависимости от методики лечения, наименьшая общая пятилетняя выживаемость отмечена у больных менопаузального возраста 71,7%. У женщин пременопаузального возраста пятилетние результаты достигли 78,3%. 5-летняя выживаемость больных раком эн-

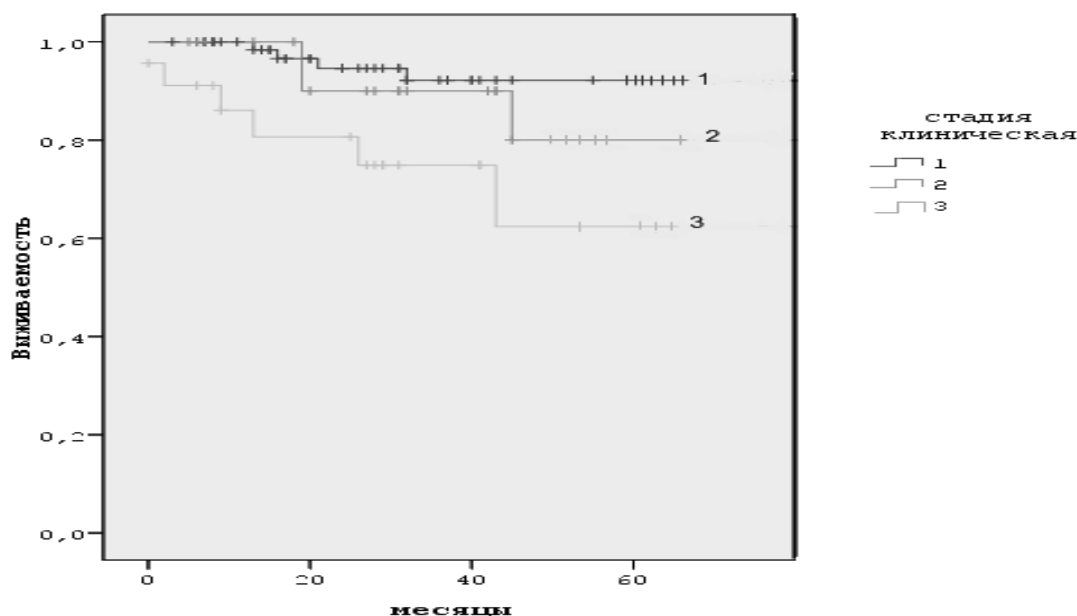


Рисунок 2 – Общая пятилетняя выживаемость в зависимости от стадии РТМ (Kaplan-Meier)

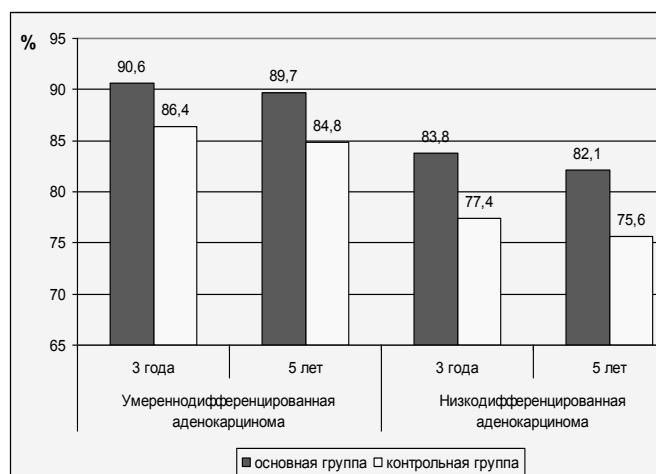


Рисунок 3- Выживаемость больных РТМ в зависимости от степени дифференцировки опухоли (умереннодифференцированная, низкодифференцированная) по видам лечения (%)

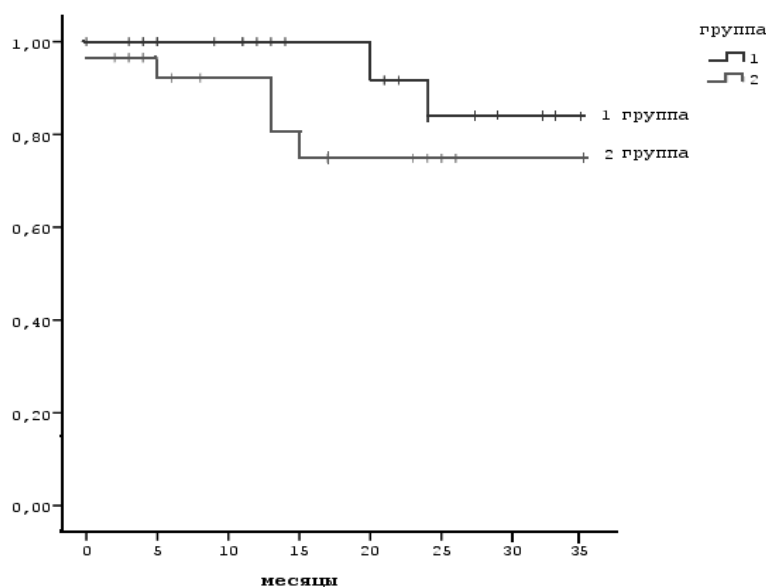


Рисунок 4 - Безрецидивная выживаемость больных раком тела матки основной и контрольной групп (Kaplan-Meier)

дометрия пременопаузального возраста при комплексном лечении была на 5,8% больше, чем при комбинированной терапии. В менопаузальном возрасте общая 5-летняя выживаемость составила 77,4% при комплексном лечении больных РТМ, пациентки дожили до 5-летнего срока наблюдения при комбинированном лечении в 66,0% случаях (рисунок 1). Показатели 5-летней выживаемости у пациенток репродуктивного периода составили 100%, как в основной, так и в контрольной группе.

Рассматривая 5-летнюю выживаемость с учетом стадии болезни, можно отметить, что данный признак оказывает влияние на отдаленные результаты лечения и является одним из факторов прогноза. Так при сравнении выживаемости больных с первой стадией (94,6%) с другими определяется достоверная разница по сравнению с пациентками,

имевшими вторую (85,3%) и третью (69,1%) стадии (рисунок 2).

При сопоставлении аналогичных данных между собой по 3-летней выживаемости отмечается общая тенденция улучшения результатов лечения при комплексной терапии больных РТМ. При рассмотрении отдаленных результатов лечения групп при комплексном и комбинированном лечении в зависимости от стадии злокачественного процесса отмечено, что данный показатель достоверно выше у больных основной группы при II стадии 89,8% против 80,7% в контрольной соответственно. При I и III стадиях разница в выживаемости была 95,9% против 93,8% и 73,1% против 65,1% в основной и контрольной группах соответственно.

При оценке отдаленных результатов лечения больных РТМ с учетом степени дифференцировки опухоли необходимо отметить, что более высокая 5-летняя выживаемость имела место у больных с умереннодифференцированной эндометриоидной аденокарциномой эндометрия (87,7%).

Проведение комплексной терапии при умереннодифференцированных аденокарциномах позволяло достичь 89,7% пятилетней выживаемости против 84,8% при проведении комбинированного лечения. Снижение показателей выживаемости наблюдалось у больных с низкодифференцированной формой, пятилетние результаты при комплексном и комбинированном методе лечения составили 82,1% и 75,6% соответственно. Подобное соотношение было и в показателях результатов 3-летней выживаемости больных РТМ (рисунок 3).

Следует остановиться на безрецидивном периоде выживаемости больных раком тела матки. Показатель безрецидивной выживаемости также был выше в группе комплексного лечения больных 80,2±1,3% против 75,2±1,8% при комбинированном лечении ($p < 0,05$) (рисунок 4).

Безрецидивная трехлетняя выживаемость определена в группе больных менопаузального возраста и установлена 93,8±2,0% и 72,7±1,9% в основной и контрольной (комбинированное лечение) группах соответственно.

Отдаленные результаты при применении системной

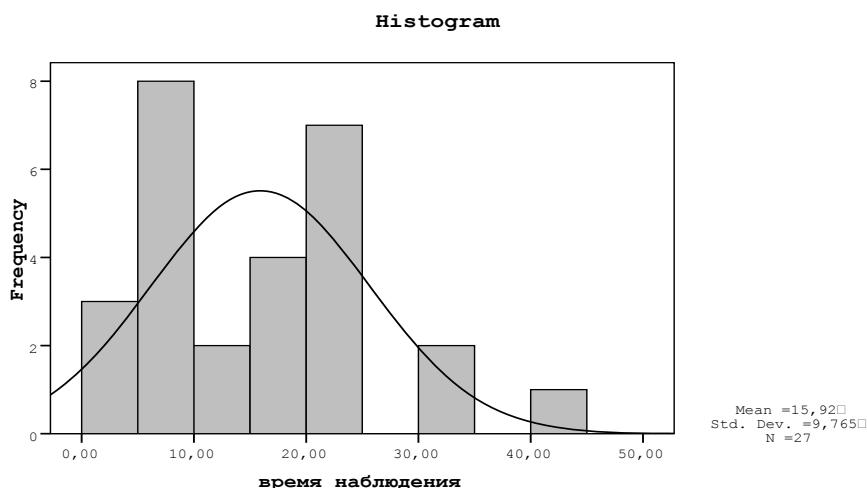


Рисунок 5 – Сроки наблюдения за больными, получившими системные курсы неoadъювантной полихимиотерапии в плане комплексного лечения

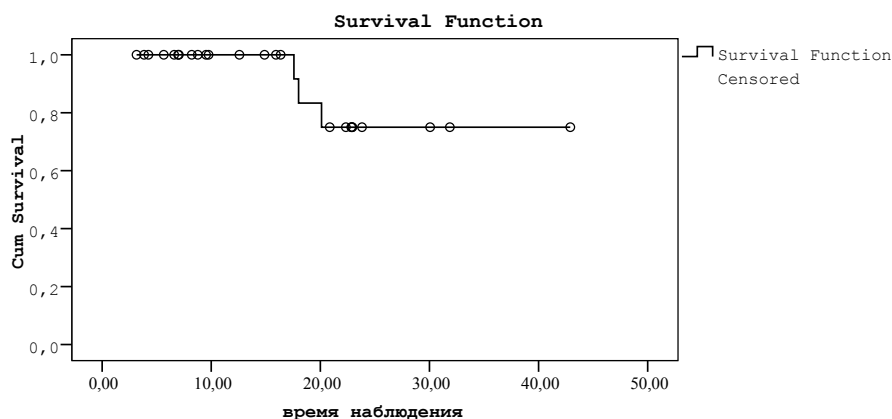


Рисунок 6 - Общая выживаемость больных после комплексного лечения с неoadъювантной внутривенной химиотерапией (Kaplan-Meier)

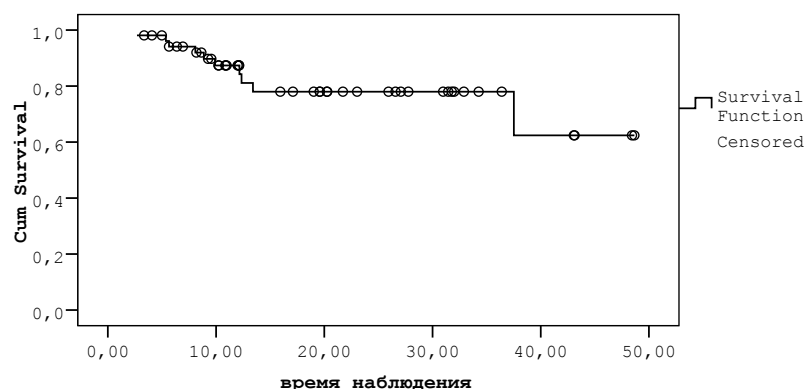


Рисунок 7 - Кумулятивная выживаемость больных местнораспространенным РШМ после сочетанной лучевой терапии (Kaplan-Meier)

полихимиотерапии у больных раком шейки матки Среднее время наблюдения за больными, лечение которых начато с проведения неoadъювантных курсов системной неoadъювантной полихимиотерапии составило $15,92 \pm 1,88$ месяца (медиана 15,93 месяца) с минимальным сроком 3,15 месяца и максимумом 42,91 месяца (рисунок 5).

Как видно из представленного рисунка 5, срок наблюдения за большинством пациенток был в пределах 25 месяцев, меньшее количество больных прослежено 30 и 40 месяцев, фактическая выживаемость оценена в сроке наблюдения 42 месяца. Результаты терапии оценены у всех пролеченных больных этой группы.

На первом году наблюдения не умерла ни одна больная, от прогрессирования основного заболевания умерло по 1 больной на 17, 18 и 20 месяце наблюдения. С рецидивом заболевания на сегодняшний день живы 2 больных.

Из рисунка 6 видно, что 1-летняя выживаемость составляет 100%, при этом данный показатель сохраняется до 1,5 лет наблюдения. К середине второго года показатель выживаемости снижается до $91,7 \pm 8,0\%$. К концу двух лет живы $83,3 \pm 10,8\%$ больных. А общая 4-х и 5-летняя выживаемость равна $75,0 \pm 12,5\%$.

Показатель 5-летней безрецидивной выживаемости у больных, получивших системную неoadъювантную химиотерапию, составил $66,7 \pm 7,2\%$.

Установлено, что относительный риск смерти после проведения системной неoadъювантной полихимиотерапии имеет пик в сроке 18 - 20 месяцев, составляя 0,7, и снижается в последующем до минимальных значений.

Основной целью неoadъювантной химиотерапии является уменьшение первичной опухоли и ее метастазов

для создания лучших условий для проведения в дальнейшем радикального хирургического лечения.

В исследуемой группе больных, через 3 недели после завершения неoadъювантной полихимиотерапии радикальное хирургическое лечение удалось выполнить в 17 случаях, что составило 62,9%.

При анализе результатов лечения оказалось, что показатель кумулятивной выживаемости выше в тех случаях, когда больным после проведения системной неoadъювантной полихимиотерапии удалось выполнить радикальное хирургическое лечение. Так, у

оперированных больных показатель общей 5-летней выживаемости составил $80,0 \pm 7,9\%$, а у пациенток, которые не были оперированы, общая 5-летняя выживаемость оказалась равной $71,4 \pm 7,1\%$, разница не достоверна ($p > 0,05$).

Традиционно сочетанная лучевая терапия является основным и общепринятым методом лечения местнораспространенного РШМ. Отдаленные результаты сочетанной лучевой терапии, проведенной по радикальной программе, оценены у 53 пациенток. Максимальный срок наблюдения составил 48,6, минимальный – 2,7 месяцев (рисунок 7).

Из рисунка 7 видно, что кривая выживаемости имеет резкое падение к концу первого года наблюдения. При этом на первом году показатель общей выживаемости у больных местнораспространенным РШМ, получивших сочетанную лучевую терапию составил 78,0%. В оставшийся промежуток времени отмечается дальнейшее падение кривой выживаемости на отметке 36 месяцев. Общая пятилетняя выживаемость после сочетанной лучевой терапии, рассчитанная с помощью модели пропорционального риска Кокса, составила $64,0 \pm 7,0\%$. Три года без признаков заболевания живы $53,0 \pm 2,4\%$, а показатель 5-летней безрецидивной выживаемости равен $46,6 \pm 2,4\%$.

Таким образом, проведение комплексной терапии при раке тела и шейки матки с применением неoadъювантной полихимиотерапии показало перспективность метода лечения.

НПХТ у больных раком тела матки увеличивает как общую ($86,9\%$), так и безрецидивную выживаемость больных ($70,2\%$) против $80,2\%$ и $56,2\%$ соответственно при комбинированном лечении. Проведение комплексной терапии при РТМ имело более выраженный эффект на отдаленные результаты при II стадии заболевания.

НПХТ увеличивает общую 5-летнюю выживаемость больных местнораспространенным раком шейки матки, получивших в составе комплексного лечения неoadъювантные курсы системной полихимиотерапии и равна $75,0 \pm 12,5\%$, 5-летняя безрецидивная выживаемость составила $66,7 \pm 27,2\%$. Процент резектабельности РШМ после проведения неoadъювантной химиотерапии составил 62,9%.

Список литературы

1. Мерабишвили В.М. Лалианци Э.И., Чепик О.Ф., Субботина О.Ю. Рак тела матки: динамика заболеваемости, смертности и выживаемости больных. //Вопр.онкол. - 2012. - Т.58, № 3. - С.339-345.
2. Мерабишвили В.М. Лалианци Э.И., Чепик О.Ф., Субботина О.Ю. Динамика наблюдаемой и относительной выживаемости больных раком шейки матки (популяционное исследование) // Вopr. онкол.- 2012.- Т.58, № 3.- С. 333-338.
3. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2007 год.- Алматы, 2007. - 101 с.
4. Waggoner S. Cervical cancer//Lancet.- 2003.- Vol 361. - P.2217-2225.
5. Fleming G. Adjuvant Therapy for High-risk Adenocarcinoma of the Uterus //ASCO, 2008. - P 230-233.
6. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. - М.: Медицина, 1989. - 463с.
7. Манжура Е.П., Вакуленко Г.А., Мицкевич В.Е. и соавт. Патогенетическое обоснование лечения агрессивных форм рака эндометрия // Матер. V съезда онкологов и радиологов СНГ. - Ташкент, 2008. - С. 391.

Тұжырым

Ж.К.Чингисова, М.Р.Кайрбаев, Е.К.Кукубасов, Р.Ш.Шалбаева, Ж.Досаханов

Неоадьювантты полихимиотерапияны қолданудағы жатыр мойын мен жатыр денесінің қатерлі ісігі бар науқастардың өміршендігі.

Бұл жұмыс жатыр денесі қатерлі ісігі және жатыр мойны қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың адьювантты емес полихимиотерапияны қолдану арқылы комплексті ем алған науқастардың өмір сүру ұзақтығын зерттеуге негізделген. Жатыр мойны денесінің қатерлі ісігінде адьювантты емес полихимиотерапияны қолдану,

құрама емнің нәтижелеріне (80,2% және 56,2%) қарағанда жалпы өмір сүру ұзақтығын (86,9%) және рецидивсіз кезеңді (70,0%) жоғарылатты. Жатыр мойны қатерлі ісігінде жалпы 5 жылдық өмір сүру ұзақтығы 75,0% рецидивсіз кезең 66,7% құрады, ал жергілікті таралған жатыр мойны қатерлі емдеудегі негізгі және жалпылама қабылданған әдіс болып табылатын үйлесімді сәулемен емдеуден кейінгі көрсеткіштер 64,0% және 46,6% болды.

Түйінді сөздер жатыр мойының қатерлі ісігі, жатыр денесінің қатерлі ісігі, неоадьювантты полихимиотерапия.

Summary

Chingissova Zh.K., Kayrbaev M.R., Kukubasov E.K, Shalbaeva R.Sh., Dossakhanov Zh.A.

Survival of patients with uterus and cervix cancer using neoadjuvant chemotherapy

Current work is based on survival analyses of patients with endometrial and cervical cancer who underwent neoadjuvant chemotherapy (NACT). NACT resulted in increased indexes of overall survival (86.9%) and disease free survival (70%) in endometrial cancer patients compared to 80.2% and 56.2% accordingly. In cervical cancer NACT resulted in 75% overall survival and 66.7% disease free survival. After radiation therapy which is a standard treatment of such patients overall and disease free survival of patients with locally advanced cervical cancer were 64.0% and 46.6% accordingly.

Keywords: cervical cancer; uterine cancer; neoadjuvant chemotherapy, the survival rate

УДК: 616.24-006.6-08 \

А.А. Бейсебаев, Э.Т. Баймухаметов, М.И. Карасаев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы, РК

Опыт выполнения одномоментной двусторонней лимфодиссекции при раке легкого

Рак легкого представляет чрезвычайно важную проблему для здравоохранения и населения Республики Казахстан. Актуальным является поиск и разработка наиболее патогенетически обоснованных методов оптимизации хирургического лечения, путем внедрения функционально-сберегающих операций, расширения зон лимфодиссекции в сочетании с химиолучевой терапией.

В последние годы разрабатываются проблемы органосохраняющего лечения рака легкого. В отличие от реконструктивно-пластических операций резекции легкого стали выполняться с эндовидеоторакоскопической поддержкой [Лемехов В. Г., 2005]. Всемирный опыт резекции легкого и одномоментной двусторонней внутригрудной лимфодиссекции путем торакотомии или срединной стернотомии состоит из единичных операций [Давыдов М. И., Полоцкий Б. Е., 2003; Mokoto Y., 2003; Hata E., 2004]. Принимая во внимание эту направленность в торакальной онкохирургии при резекции легкого предлагается производить лимфодиссекцию и контралатеральной грудной полости методом эндовидеоторакоскопии.

Цель работы - повышение эффективности лечения немелкоклеточного рака легкого

Объектами исследования были больные раком легкого.

Обследование включало традиционные исследования (рентгенологические методы, ФБС, трансторакальные пункционные биопсии).

Методы лечения: хирургический (удаление пораженной доли легкого, всего легкого с лимфодиссекцией и видеоассистированной контралатеральной внутригрудной лимфодиссекцией) и адъювантная ПХТ по показаниям.

Операция выполняется последовательно в два этапа. Сначала производится лимфодиссекция со здоровой стороны с односторонней вентилизацией, при этом пациент укладывается на пораженную сторону. Затем поворот на здоровый бок и выполняется из торакотомного доступа долевая резекция (лоб- или билобэктомия) или пневмонэктомия с лимфодиссекцией. Мы остановились именно на такой последовательности выполнения данного оперативного вмешательства, так как после выполнения лоб- или билобэктомии оставшиеся доли (доли) могут не обеспечить потребность организма в кислороде. Но с другой стороны имеется вероятность того, что после выполнения лимфодиссекции на стороне не пораженного легкого основной процесс будет признан не резектабельным.

Лимфодиссекция носит тотальный характер – удаляются все группы лимфатических узлов с обеих сторон.

Благодаря отдельной интубации легкое на стороне эндовидеоторакоскопической лимфодиссекции выключается из дыхания. Спавшиеся и неподвижное легкое обеспечивает пространство и создает оптимальные условия для выполнения манипуляций. Хирургические манипуляции производятся преимущественно из 4-х точек с миниторакотомным доступом. Данный доступ позволяет

комбинированное использование инструментов (для отрытых операций и торакоскопических), что значительно облегчает выполнение манипуляций в плевральной полости. Выведение увеличенного изображения на монитор так же облегчает задачу хирурга.

Операции выполнены 24 пациентам. Возраст больных колебался от 42 до 65 лет. Соотношение лиц мужского и женского пола 6:1. У 10 больных патологический процесс локализовался слева, у 14 – справа.

Больным выполнены следующие объемы оперативных вмешательств.

Таблица – Объем оперативных вмешательств

Резекция легкого и двусторонняя лимфодиссекция	Кол-во больных	
	абс.	%
Верхняя лобэктомия справа	7	29,2
Средняя лобэктомия справа	1	4,2
Нижняя билобэктомия справа	6	25,0
Верхняя лобэктомия слева	6	25,0
Нижняя лобэктомия слева	2	8,3
Пневмонэктомия слева	2	8,3
Всего	24	100,0

По данным гистологического исследования послеоперационных препаратов поражения контралатеральных лимфатических узлов выявлено в одном случае.

Методика двусторонней лимфодиссекции с использованием видеоассистированной техники является щадящей так как не производится вскрытие обеих плевральных полостей. Послеоперационные осложнения сведены к минимуму. Летальность отсутствует.

Адекватность выполнения двусторонней лимфодиссекции подтверждается гистологическим методом исследования.

Состояние внутригрудных лимфатических узлов является основным фактором прогноза хирургического лечения больных. При гистологическом подтверждении вовлечения в опухолевый процесс лимфатических узлов следует проводить адъювантную химиотерапию.

Список литературы

1. Hata E., Ikeda Sh., Kavano R., Yokota T. Системная двусторонняя медиастинальная лимфодиссекция по поводу рака легкого стернотомным доступом: Докл. // Российско-японская международная конференция «Стратегия лечения рака легкого в XXI веке: что мы должны сделать сейчас и в будущем». Рос. онкол. научн. центр. - М., 2004. - № 4. - С. 101-104.
2. Mokoto Y., Nobuo O., Naoki I. et al. Проблема двусторонней медиастинальной лимфодиссекции при раке легкого // Haigan. Jap. J. Lung Cancer. - 2003. - 43. № 2. - P. 121-130.
3. Давыдов М. И., Полоцкий Б. Е. Современные принципы выбора лечебной тактики и возможности хирургического лечения немелкоклеточного рака легкого // Новое в

терапии рака легкого (терапия рака легкого начала XXI века): Рос. онкол. науч. центр. М., 2003. - С. 41-53.

4. Лемехов В. Г., Барчук А. С., Клеменко В. Н. Эндовидеоторакоскопия в онкологической практике // СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. - 144 с.

Тұжырым

А.А.Бейсебаев, Э.Т.Баймұхамедов, М.И.Карасаев

Өкпенің қатерлі ісігі кезіндегі бір мезетті екі жақта лимфодиссекцияны орындаудағы тәжірибесі Қазақстан Республикасы тұрғындары және денсаулық сақтау ісі үшін өкпе қатерлі ісігін білу маңызы зор.

Жұмыс мақсаты: өкпе қатерлі ісігі ұсақ жасушалы емес түріндегі ем нәтижесін арттыру.

Ота кезекті 2 кезеңмен жүргізіледі. Алғашында лимфодиссекция сау жағына жасалады, сосын бөліктік резекциялар лоб- немесе билобэктомия немесе зақымдалған өкпенің лимфодиссекциямен бірге пневмонэктомиясы жасалады.

Лимфодиссекция жалпылама сипатта болады.

Ота 24 науқасқа жасалынды. Науқастардың жас аралығы 42 мен 65 жаста.

Ер адамдармен әйел адамдар ара – қатынасы 6:1. 10 науқаста үрдіс сол жағында, 14 де оң жағында орналасты. Операциядан кейінгі асқынулармен өлім бұл науқастар арасында болмады. Гистологиялық зерттеулер нәтижесіне байланысты қарама-қарсы жақтың лимфа түйіндерінің зақымдалуы бір науқаста болды.

Видео көмекпен бірге жасалынған 2 жақты лимфодиссекция отасы мүше сақтаушы оталарға жатады.

Екі жақты лимфодиссекция отасының нәтижелілігі гистологиялық тексеру әдісімен нақтыланады.

Кеуде ішілік лимфа түйіндері жағдайы науқастардың

хирургиялық отадан кейінгі болжамына көп әсер етеді.

Түйінді сөздер ұсақ клеткалы емес өкпенің қатерлі ісігі, екі жақта лимфодиссекция.

Summary

A.A.Beysebaev, E.T.Baimukhametov, M.I.Karasayev

Experience in performing simultaneous bilateral lymphadenectomy in lung cancer Lung cancer is an extremely important issue for the health and population of the Republic of Kazakhstan. In recent years, developed organ preservation treatment of lung cancer.

Objective: To increase the effectiveness of treatment non-small cell lung cancer Operations are performed in two stages. First the dissection with a healthy side, then lobar resection (forehead or bilobectomy) or pneumonectomy with lymph node dissection of the affected lung. LND is total.

Surgery was performed 24 patients. Age of patients ranged from 42 to 65 years. The ratio of male and female 6:1. In 10 patients the pathological process was localized to the left, 14 - on the right.

Postoperative complications and mortality in this group of patients were observed. According to the histological study of post-operative medications lesions of contralateral lymph nodes was noted in one case.

1. Using bilateral videoassisted lymphadenectomy technique is sparing. Mortality is missing.

2. Properly executed bilateral lymphadenectomy confirmed by histological studies.

3. Hilar lymph node status is a major predictor of surgical treatment.

Keywords: non-small cell lung cancer, bilateral lymphadenectomy.

УДК 616. 33- 066.- 089 - 036. 8

Е.Б. Ижанов

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Неoadъювантная химиотерапия местнораспространенного рака желудка

Аннотация. Приведен литературный обзор актуальности проведения предоперационной химиотерапии для больных местнораспространенным раком желудка. Представлены сравнительные результаты лечения 128 больных местнораспространенным раком желудка, из которых 62 проведена комбинация неoadъювантная терапия и операция. Применение схем неoadъювантной терапии в 50% случаев привело к различной степени регрессии опухоли. Не выявлено увеличения показателей послеоперационных осложнений и летальности.

Ключевые слова: рак желудка, неoadъювантная химиотерапия, хирургическое лечение.

Рак желудка остается одной из главных и нерешенных проблем современной онкологии. Хирургический метод лечения по-прежнему является ведущим в лечении данной нозологической единицы. Однако отдаленные результаты лечения в большинстве стран мира остаются неутешительными. Одной из основных причин неудовлетворительных результатов лечения и плохих прогнозов является поздняя диагностика заболевания и несовершенство имеющихся методов терапии [1]. В настоящее время удельный вес больных раком желудка, выявленных в 1-2 стадии, когда, по мнению абсолютного большинства авторов, возможно радикальное излечение больного, не превышает 20-25%, в то время как около 50% больных выявляется в 3 стадии опухолевого процесса. В этом случае применение только одного локального хирургического метода воздействия оказывается недостаточным. Большое количество исследований адъювантной (послеоперационной) терапии рака желудка не выявило убедительных данных улучшения безрецидивной и общей выживаемости этой категории больных, поэтому продолжается поиск новых методов и схем лечения. Весомый интерес заслуживает предоперационная или неoadъювантная химиотерапия рака желудка.

Неoadъювантная терапия проводится перед основным видом лечения. По мнению сторонников данного вида лечения [2] одним из важнейших критериев обоснования является тот факт, что до проведения оперативного вмешательства не нарушена анатомическая целостность как кровеносных, так и лимфатических сосудов. Таким образом, проведение предоперационной системной терапии позволяет терапевтическим агентам наиболее точно достигать опухоли и, естественно, более эффективно реализовывать свое действие. Все это позволяет, во-первых, уменьшить массу опухоли, что при определенных обстоятельствах может позволить выполнить оперативное вмешательство в меньшем объеме, например, избежать резекции интимно прилежащих к опухоли соседних

структур; во-вторых, начать раннее цитостатическое воздействие на микрометастазы.

Проведение оперативного вмешательства для большинства пациентов оказывается весьма большой нагрузкой и, естественно, что у многих пациентов в послеоперационном периоде возникает ряд состояний (послеоперационные осложнения, агастральный (пострезекционный) астенический синдром и т.д.), что значительно увеличивают сроки реабилитации. Таким образом, ряду пациентов изначально исключается возможность проведения адъювантных курсов системной терапии. Предоперационная же терапия предоставляется в таком виде, что пациент в ожидании операции и достижения конечной цели переносит ее более благополучно. Наконец еще одним важным моментом является то, что появляется возможность определения индивидуальной чувствительности опухоли к химиопрепаратам, что немаловажно для определения дальнейшей тактики лечения. В тоже время неoadъювантная химиотерапия имеет и ряд специфических недостатков: 1) отсрочка основного вида лечения; 2) увеличение отказов больных от радикального лечения после достижения определенного эффекта от предоперационного лечения и субъективного улучшения состояния; 3) формируются клоны опухолевых клеток малочувствительных к химиопрепаратам.

H.Bunte в хирургической клинике Мюнстера изучил результаты предоперационной химиотерапии при раке желудка. Автор отмечает, что из 68 больных с первично неоперабельными опухолями в 19 случаях удалось перевести опухоль в операбельное состояние с максимальной продолжительностью жизни больных 30 месяцев [3].

Аджани и соавторы [4] выполнили одноветвевое испытание фазы II, включающее 48 пациентов потенциально операбельным раком желудка. Предоперационно проведено 3 курса полихимиотерапии по схеме этопозид, доксорубин и цисплатин. По завершении курсов полихимиотерапии резектабельность составила 85%, из которых 77% больным выполнены радикальные вмешательства. Во время проведения химиотерапии отмечалась достаточно выраженная токсичность (в основном, нейтропения), проявления которой купировались медикаментозно. Было доложено об одном летальном случае после операции, осложнения были связаны с проведением химиотерапии.

В последующем Аджани с соавторами [5] использовали схожий режим неoadъювантной терапии, включающий 2 курса: цисплатин, FU и этопозид. После проведенного оперативного вмешательства также было проведено 3 курса аналогичной полихимиотерапии. Всем пациентам удалось выполнить оперативное вмешательство, у 72% больных операции носили радикальный характер. В результате исследования доложено об одном

случае послеоперационной летальности, связанной с полихимиотерапией.

Лейчман и соавторы [6] доложили предварительные результаты исследования, в котором 38 пациентов с потенциально резектабельными опухолями желудка получили 2 курса предоперационной химиотерапии, включающей 5- FU, лейковорин и цисплатин. В последующем больным проводилась послеоперационная интраперитонеальная химиотерапия: FUDR, цисплатин и внутривенное введение натрия тиосульфата. В результате 92% пациентов подвергнуты лапаротомии, из которых 87% случаев оказались резектабельными. Послеоперационная интраперитонеальная химиотерапия была возможна у 68% пациентов исследования. Было доложено об одном летальном случае, связанном с лечением. Вместе с тем, имели место ряд организационных нарушений при проведении исследования: не было проведено клиническое стадирование опухоли перед исследованием (с помощью КТ или эндоскопии); послеоперационное морфологическое исследование показало, что у 14 пациентов выявлена 0 или I стадия заболевания. Еще у 7 пациентов имели место опухоли II стадии.

Крукес и соавторы [7] доложили долгосрочные результаты фазы II исследования. В заключительном докладе сообщалось о 59 пациентах раком желудка, перенесших комбинированное лечение с неоадьювантной химиотерапией. Уровень резектабельности составил 71%. Послеоперационная летальность составила 5%. Медиана выживаемости этой группы пациентов была оценена как превышающая 4 года. Так как эти пациенты не проходили предоперационную лапароскопию, поэтому невозможно оценить степень распространенности опухолевого процесса и в исследование могла войти пациенты как с местнораспространенными опухолями, так и с ранними формами.

Келсен и соавторы [8] выполнили 2 исследования, включающих предоперационную химиотерапию с последующим послеоперационной интраперитонеальной химиотерапией. В первом исследовании использован режим FAMTX предоперационно и послеоперационный интраперитонеальный режим - FU + цисплатин. Группу исследования составили 56 больных, дооперационно на основании КТ и эндоскографии которым определена T2-4 степень инвазии. В последующем, морфологическим исследованием подтверждено, что абсолютное большинство имели опухоли IIIA или IIIB стадии. Токсичность была удовлетворительной, основным побочным эффектом была миелосупрессия, проявляющаяся нейтропенической лихорадкой у 60% пациентов. Уменьшение стадии произошло у 51% пациентов, уровень операбельности был 89%, уровень резектабельности - 74% (61% радикальные и 20% - паллиативные). Медиана выживаемости для всех пациентов составила 15.3 месяца.

Последующее исследование составила [9] группа из 35 пациентов с 2 курсами предоперационной химиотерапии цисплатином и FU и последующим послеоперационным интраперитонеальным лекарственным лечением флуксоредином и лейковорином. Всем пациентам проводилась перед лечением лапароскопия и эндоскопическая стадия желудка, при этом у всех пациентов отмечены T3 инвазивные опухоли или опухоли с положительными метастатическими лимфоузлами. Предоперационная токсичность была удовлетворительная, не ставшая причиной послеоперационных осложнений и смертности. Резектабельность составила 82%; установленная средняя продолжительность жизни составила 22,6 месяца.

Каннингем с соавторами (MAGIC Trial) провели рандомизированное исследование влияния ECF- режима химиотерапии для пациентов со стадией опухолевого процесса $\geq$ IIA [10]. В исследование включено 503 клинических случая, из которых 74% имели локализованное поражение (аденокарциномы) какого-либо из отделов желудка; в 11% случаев отмечена кардиоэзофагеальная карцинома с аденогенным гистологическим вариантом и еще 15% случаев представлены аденокарциномами нижнегрудного и абдоминального отдела пищевода. Пациентам проводились 3 предоперационных курса системной терапии эпирубицином, цисплатином и фторурацилом. Вслед за неоадьювантной терапией следовало оперативное вмешательство, после чего пациентам проводилось еще 3 курса адьювантной полихимиотерапии теми же препаратами. Контрольную группу сравнения составили пациенты, перенесшие только хирургическое лечение. До начала исследования авторами прогнозировалось значительное увеличение количества послеоперационных осложнений и летальности. Изучена 5-летняя выживаемость для больных исследуемых групп. Так в группе полихимиотерапии 5-летняя выживаемость составила 36%, в то время как для только хирургии она составила 23%. Авторами отмечено значительное увеличение сроков появления рецидивов и прогрессирования.

Последующее исследование MAGIC эффективности периоперативной полихимиотерапии, проводимое в Великобритании, получило кодовое название NCRI ST03 и начато во втором квартале 2007 года. Это ассоциированное исследование, в котором под руководством Великобритании открыты для участия Международные сайты в стремлении набрать в общей сложности 1100 пациентов с резектабельными формами аденокарцином желудка и кардиоэзофагеальной зоны (тип III Siewert), которые будут рандомизированы по периоперативной химиотерапии ECX (эпирубицин, цисплатин, капецитабин) плюс антивазкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGF) моноклональное антитело бевацизумаб (авастин). ECX схема был выбрана в качестве химиотерапии для данного исследования в связи с удобством перорального длительного применения капецитабина, который заменяет 5FU и, возможно, уменьшит связанные с длительным его введением неудобства. Существует перспективная надежда на улучшение результатов лечения пациентов.

Исследование эффективности предоперационной терапии французской группы [11] включало 2 ветви: первая - это только хирургическое лечение (n=111) и основную группу составили больные (n=113) местнораспространенным раком желудка, которым перед операцией проведено 2 курса химиотерапии по схеме 5-фторурацил + платинол и в послеоперационном периоде 4 курса аналогичной схемы химиотерапии. К сожалению, данное исследование нельзя назвать абсолютно корректным, поскольку больные получали разное количество курсов химиотерапии как до операции, так и после нее. Вместе с тем, 5-летняя безрецидивная выживаемость в группе комбинированного лечения значительно превысила таковую в группе хирургического лечения (34% по сравнению 21% соответственно; p=0,0033). Показатель общей выживаемости в группе комбинированного лечения также оказался значительно выше чем в группе хирургического лечения и составил 38% против 24% соответственно (p=0,021). Таким образом, авторы сделали вывод о том, что т.н. неоадьювантная полихимиотерапия должна быть стандартом лечения

местнораспространенных форм рака желудка, при этом, назначение химиотерапии до операции переносится больными значительно легче, чем после операции.

Материалы и методы

В отделении онкохирургии органов ЖКТ Казахского НИИ онкологии и радиологии проведено сравнительное исследование эффективности лечения 128 больных местнораспространенным раком желудка, из которых 62 больным (основная группа) проведено комбинированное лечение - неоадьювантная полихимиотерапия + операция и 66 пациентам - только хирургическое лечение. Средний возраст больных в группе комбинированного лечения составил $50,0 \pm 21,48$ лет, в группе хирургического лечения - $57,5 \pm 20,51$ лет. Полихимиотерапия проводилась по схеме: таксотер- 75 мг/м^2 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м^2 2- 5-ый дни + лейковорин 50 мг/м^2 также 2-5 дни.

Результаты и их обсуждение

Во всех 128 случаях выполнена тотальная гастрэктомия, причем почти в 91% только при хирургическом лечении и более чем в 88% при комбинированном лечении операции носили комбинированный характер. При хирургическом методе лечения у 16 больных из 66 отмечено 19 ($28,8 \pm 0,46$) различного рода осложнений. Среди них наиболее часто встречающиеся - послеоперационный панкреатит и послеоперационная пневмония по 4 осложнения ($6,1 \pm 0,24$). В 2-х случаях ($3,0 \pm 0,17$) в раннем послеоперационном периоде отмечены послеоперационные кровотечения. Несостоятельность швов пищевода-кишечного анастомоза (ПКА) отмечена в 2 случаях ($3,0 \pm 0,17$).

В группе комбинированного лечения послеоперационные осложнения отмечены у 15 из 62 оперированных больных; количество осложнений составило 18 ($29,0 \pm 0,46$). В данной группе больных также отмечено превалирование так называемых «терапевтических» осложнений - послеоперационных пневмонии и панкреатита ($8,0 \pm 0,27$ и $6,2 \pm 0,25$ соответственно). Несостоятельность швов ПКА отмечена у двух больных ($3,2 \pm 0,18$).

Из 128 больных, перенесших тотальную гастрэктомию по поводу местнораспространенного РЖ, умерло 4. Общая летальность составила 3,1%. В разрезе групп исследования летальность распределилась равномерно: по 2 случая в группе комбинированного и в группе хирургического лечения - $3,2 \pm 0,18$ % и $3,0 \pm 0,17$ % соответственно.

Прослежена годовичная выживаемость у 124 больных из 128, переживших ранний послеоперационный период и пролеченных по сравниваемым схемам. Хирургическую группу составили 64 пациента, в группе комбинированного лечения отслежены ближайшие (2 года) и отдаленные (5 лет) результаты лечения для 60 пациентов.

По данным авторов, изучавших отдаленные результаты, при хирургическом лечении более 50% рецидивов и метастазов у больных возникают в первые два года после операции. Этот срок для больных раком желудка III и более стадии является критическим в отношении прогрессирования заболевания [10]. В таблице 1 представлены данные о двухлетней выживаемости изучаемых групп больных.

Таблица 1- Двухгодичная выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умер-ло	2-летняя выживаемость	Безрецидивная 2-летняя выживаемость
Хирургический	64	33	31 ($48,4 \pm 5,03$)	26 ($41,6 \pm 4,95$)
Комбинированный	60	28	32 ($53,3 \pm 5,03$)	28 ($46,7 \pm 5,03$)

Отмечается увеличение количества пациентов, переживших двухлетний срок наблюдения без метастазов и рецидивов при комбинированном лечении - $46,7 \pm 5,03$ против $41,6 \pm 4,95$. Аналогично, отмечается увеличение общей выживаемости в группе комбинированного лечения - $53,3 \pm 5,03$ по сравнению с $48,4 \pm 5,03$ при хирургическом.

Пятилетние результаты лечения прослежены также у 124 больных (см. таблица 2).

Таблица 2 - Пятилетняя выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умер-ло	5-летняя выживаемость	Безрецидивная 5-летняя выживаемость
Хирургический	64	53	11 ($17,2 \pm 3,80$)	10 ($15,7 \pm 0,65$)
Комбинированный	60	47	13 ($21,7 \pm 4,15$)	11 ($18,3 \pm 3,90$)

В группе хирургического лечения по настоящее время живы 11 ($17,2 \pm 3,80$) человек, в то время как в группе комбинированного лечения пятилетний рубеж перешагнули 13 ($21,7 \pm 4,15$) пациентов. Безрецидивная пятилетняя выживаемость также выше в группе комбинированного лечения - $18,3 \pm 3,90$ против $15,7 \pm 3,65$ в группе хирургического лечения. Отмечается снижение темпов смертности после лечения как в группе хирургического, так и в группе комбинированного лечения в сравнении первых двух и последующих 3 лет. Так, если в первые 2 года умерло 51,6% и 46,7% больных в группах хирургии и комбинированного лечения, то в последующие годы эти цифры составили 31,3% и 30,0% соответственно. Эти показатели соответствуют литературным данным о наибольшем обнаружении прогрессирования опухолевого процесса и смертности пролеченных больных именно в первые два года после радикального вмешательства.

Хирургическое лечение проведено 128 больным местнораспространенными формами рака желудка, из которых 59 выполнена D2 лимфодиссекция и 69 больным - D3 лимфодиссекция.

Анализ частоты и характера послеоперационных осложнений показал, что отмечается незначительное, статистически недостоверное увеличение количества послеоперационных осложнений в группе D3 лимфодиссекции: 30,3% против 27,1%. Не отмечено специфических для каждого из уровней лимфодиссекции осложнений. В послеоперационном периоде отмечено 4 летальных случая, по 2 в каждой из исследуемых групп ($3,4 \pm 0,13$ и $2,8 \pm 0,12$ соответственно).

С учетом послеоперационных летальных случаев рассчитана выживаемость для 124 больных - для 57 больных в группе D2 лимфодиссекции и 67 больным - в группе D3 лимфодиссекции. В таблице 3 представлены данные о двухлетней выживаемости для больных, перенесших D2 и D3 объемы лимфодиссекции.

Таблица 3 - Двухгодичная выживаемость больных в группах D2 и D3 лимфодиссекции

Объем лимфо-диссекции	Кол-во больных	Умерло	2-летняя выживаемость	Безрецидивная 2-летняя выживаемость
D2	57	28	29 (50,9 ± 5,04)	27 (47,3 ± 5,03)
D3	67	33	34 (50,7 ± 5,04)	31 (46,2 ± 5,02)

Как следует из данных таблицы не отмечено разницы в двухлетней общей выживаемости больных местнораспространенными формами рака желудка в сравнении D2 и D3 лимфодиссекции – 50,9±5,04 против 50,7±5,04 соответственно. Нет значительной разницы и в показателях безрецидивной двухлетней выживаемости – 47,3 ± 5,03 по сравнению с 46,2 ± 5,02 соответственно. Пятилетние результаты лечения прослежены также у 124 больных (таблица 4).

Таблица 4 - Пятилетняя выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умерло	5-летняя выживаемость	Безрецидивная 5-летняя выживаемость
D2	57	46	11 (19,3 ± 3,98)	9 (15,8 ± 3,67)
D3	67	54	13 (19,4 ± 3,98)	12 (18,0 ± 3,86)

В группе D2 лимфодиссекции к настоящему моменту живы 11 (19,3 ± 3,98) человек, в то время как в группе D3 лимфодиссекции – 13 (19,4 ± 3,98) пациентов. Безрецидивная пятилетняя выживаемость несколько выше в группе D3 лимфодиссекции, однако эта разница статистически недостоверна ($p > 0,05$) – 18,0 ± 3,86 против 15,8 ± 3,67 в группе D2 лимфодиссекции.

Таким образом, проведение неoadъювантной полихимиотерапии больным местнораспространенными формами рака желудка не ухудшает непосредственные результаты и улучшает отдаленные результаты лечения. Не выявлено различий в отдаленных результатах D2 и D3 лимфодиссекции, что делает нецелесообразным выполнение суперрасширенной лимфодиссекции при местнораспространенных раках желудка.

Список литературы

1. Noguchi Y., Imada T., Matsumoto A. et al. Radical surgery for gastric cancer. A review of the Japanese experience // *Cancer*.- 1989.-Vol. 64.-C.2053.
2. Ng C.G., Husband J.E., MacVicar A.D. et al. Correlation of CT with histopathological findings in patients with gastric and gastro-oesophageal carcinomas following neoadjuvant chemotherapy. // *Clin. Radiol*.- 1998.- Vol. 53.-C.422.
3. Gastrointestinal Tumor Study Group. The concept of locally advanced gastric cancer // *Cancer*.- 1990.- Vol. 66.-C.2324.
4. Ajani J.A., Ota D.M., Jessup J.M. et al. Resectable gastric carcinoma. An evaluation of preoperative and postoperative chemotherapy // *Cancer*.- 1991.- Vol. 68.-C.1501.
5. Ajani J.A., Mayer R.J., Ota D.M. et al. Preoperative and post-

- operative combination chemotherapy for potentially resectable gastric carcinoma // *J. Nat. Cancer Inst.*- 1993.- Vol. 85.-C.1839.
6. Leichman L., Silberman H., Leichman C.G. et al. Preoperative systemic chemotherapy followed by adjuvant postoperative intraperitoneal therapy for gastric cancer: a University of Southern Caledonia pilot program // *J. Clin. Oncol.*- 1992.- Vol. 10.-C.1933.
7. Krookes J.E., O'Connell M.J., Wieand H.S. et al. A prospective, randomized evaluation of intensive-course 5- fluorouracil plus doxorubicin as surgical adjuvant chemotherapy for resected gastric cancer // *Cancer*.- 1991.- Vol. 67.-C.2454.
8. Kelsen D., Atiq O., Saltz L. et al. FAMTX (fluorouracil, methotrexate, Adriamycin) is as effective and less toxic than EAP (etoposide, Adriamycin, cisplatin): a random assignment trial in gastric cancer // *Proc ASCO*.- 1991.- Vol. 10.-C.137.
9. Kelsen D., Karpeh M., Schwartz G. et al. Neoadjuvant therapy of high-risk gastric cancer: a phase II trial of preoperative FAMTX and postoperative intraperitoneal fluorouracil-cisplatin plus intravenous fluorouracil // *J. Clin. Oncol.*- 1996.- Vol. 14.-C.1818.
10. Cunningham D., Rao S., Starling N. et al. Randomised multi-centre phase III study comparing capecitabine with fluorouracil and oxaliplatin with cisplatin in patients with advanced oesophagogastric cancer: the REAL 2 trial // *Proc. Am. Soc. Clin. Oncol.*- 2006.- Vol. 25.- 182 S.
11. Leong T., Michael M., Foo K. et al. Adjuvant and neoadjuvant therapy for gastric cancer using epirubicin / cisplatin / 5-fluorouracil (ECF) and alternative regimens before and after chemoradiation // *Br. J. Cancer*.- 2003.- Vol.89. N8.-C. 1433-1438.

Summary

E.B.Izhanov

Neoadjuvant chemotherapy of locally advanced gastric cancer

Comparative results of treating 128 patients with locally advanced gastric carcinoma, of which 62 carried a combination of neoadjuvant therapy and surgery. In-off schemes neoadjuvant therapy in 50% of cases led to varying degrees of tumor regression. There is no evidence the increasing rate of postoperative complications and mortality.

Key words: gastric cancer, neoadjuvant chemotherapy, surgical treatment

Тұжырым

Е.Б. Ижанов

Жергілікті таралған асқазанның қатерлі ісігінің неoadъювантты полихимиотерапиясы.

Асқазанның жергілікті таралған рагымен наукастарына арналған операция алдындағы химиотерапия туралы әдебиеттер қорсетілген. Асқазанның жергілікті таралған рагымен ауыратын 128 науқас емінің салыстырмалы нәтижелері көрсетілген. Солардың ішінде 62 науқасқа неoadъюванттық терапия және оперативтік ем жасалған. Неoadъюванттық терапияның белгілі схемамен жүргізу 50% жағдайда ісіктердің әртүрлі дәрежедегі регрессиясына әкелді. Операциядан кейінгі асқынулар мен өлім санының көрсеткіштерінің артуы анықталмады.

Негізгі сөздер: асқазан рагы, неoadъюванттық химиятерапия, хирургиялық ем.

Г.М. Курманова

Центральный военный госпиталь КНБ РК

Состояние тромбоцитограммы у больных пурпурой Шенлейн-Геноха

Аннотация. Острые лейкозы (ОЛ) представляют собой гетерогенную группу опухолевых заболеваний системы крови - гемобластозов, которые характеризуются первичным поражением костного мозга морфологически незрелыми кроветворными (бластными) клетками с вытеснением ими нормальных элементов и инфильтрацией ими различных тканей и органов. Клиническое наблюдение представляет интерес тем, что тромбоз глубоких вен лица явился первичным признаком острого лейкоза. Течение острого лейкоза характеризовалось значительным угнетением всех ростков кроветворения, развитием тяжелых осложнений, в том числе тромбоза глубоких вен лица справа и тромбоза кавернозного синуса

Изучение различных изменений в системе крови при заболеваниях имеют важное диагностическое значение. Количественный состав и морфология клеток крови у человека в норме характеризуется достаточно высокой стабильностью, которая связана с постоянством действия регуляторных механизмов, направленных на поддержание гомеостаза. Особый интерес вызывает изучение морфофункциональных показателей тромбоцитов при различных заболеваниях крови. Однако о тромбоцитах известно меньше, чем о других форменных элементах, до сих пор нет четкой цитометрической классификации тромбоцитов. В настоящее время широко применяются автоматические анализаторы крови, эритроцитарные параметры которых активно используются клиницистами в диагностике анемий. В то время, как интерпретация тромбоцитограмм не нашла должного применения при автоматизированном анализе крови. В литературе имеются лишь единичные работы, посвященные оценке тромбоцитопоза с помощью анализаторов (Почтарь М.Е., 2003; Колодей СВ. и соавтор., 2001).

Целью исследования явилось изучение тромбоцитарного звена гемограммы у больных пурпурой Шенлейн-Геноха с помощью автоматического анализатора крови.

Методы исследования: количество тромбоцитов и их гистограммы определяли на современном автоматическом полианализаторе крови японской фирмы «SYSMEX». Оценивали следующие показатели кровяных пластинок:

PLT - количество тромбоцитов;

MPV (mean platelet volume) - средний объем тромбоцитов. Этот показатель характеризует размер тромбоцита. Для определения размера тромбоцитов этот показатель является более достоверной, чем визуальная оценка диаметра тромбоцитов крови, который зависит от формы клеток (Колодей СВ. и соавт., 2001);

PDW (platelet distribution width) - ширина распределения тромбоцита по объему, который отражает степень

анизоцитоза тромбоцитов;

P-LCR - уровень больших тромбоцитов.

Качественные показатели тромбоцитов были оценены у 30 обследуемых больных пурпурой Шенлейн-Геноха. В качестве контроля изучали тромбоцитограммы 15 здоровых лиц (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что средний объем тромбоцитов (MPV, fl) достоверно увеличивался при абдоминальной форме до $(9,92 \pm 0,95)$ fl и при смешанной форме - $(9,95 \pm 0,79)$ fl, против контрольных показателей ($p < 0,05$). При остальных формах заболевания достоверных различий не наблюдалось, хотя показатели MPV были несколько выше контрольных результатов. Данная тенденция свидетельствует о возрастании числа «молодых» пластинок в крови.

Таблица 1- Характеристика качественных индексов тромбоцитов у больных пурпурой Шенлейн-Геноха

Клинические формы	M PV, fl m±t	P DW, fl m±t	PLCR, % M ± t
Кожная n=6	8,78 ±0,86	11,56 ±1,56 P<0,05	23,76 ±1,12 P<0,05
Кожно-суставная n=12	9,12 ±0,78	11,89 ±0,73 P<0,05	23,57 ±0,98 P<0,05
Абдоминальная n=5	9,92 ±0,95 P<0,05	13,89 ±0,95 P<0,05	25,39 ±1,23 P<0,05
Почечная n=2	8,91 ±0,67	12,89 ±1,01 P<0,05	24,95 ±1,15 P<0,05
Смешанная n=5	9,95 ±0,79 P<0,05	12,97 ±1,12 P<0,05	24,58 ±1,04 P<0,05
Контроль. группа n=15	8,85 ±0,97	10,91 ±0,96	19,21 ±1,17

P - достоверность различий по сравнению с контрольной группой.

Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW, fl) претерпевала выраженные изменения у больных пурпурой Шенлейн-Геноха в сравнение с контролем при всех клинических вариантах заболевания ($p < 0,05$). Степень анизоцитоза тромбоцитов была наиболее выраженной у больных с абдоминальной формой, при которой PDW

составила ($13,89 \pm 0,95$) fl.

Уровень больших тромбоцитов (P-LCR, %) у всех обследуемых больных был достоверно выше контрольных данных ($p < 0,05$).

Таким образом, для больных пурпурой Шенлейн-Геноха были характерны качественные изменения тромбоцитов в сторону увеличения форм с большим объемом и с анизоцитозом, а также наблюдался несколько увеличенный уровень больших тромбоцитов в крови.

Список литературы

1. Почтарь М.Е., Луговская С.А., Морозова В. Цитохимическая диагностика в лабораторной гематологии /Методическое руководство. Атлас.-М., 2003.
2. Колодей С.В., Розенберг Ю.М., Шурхина Е.Е. Тромбоз, гемостаз и реология.-М., 2001.
3. Колодей С.В., Шурхина Е.Е., Цветаева Н.В. . Гематология и трансфузиология.-М., 2003.

Тұжырым

Г.М. Курманова

Жедел лейкоздың тромбофилиялық маскісі

ҚР ҰҚК орталық әскери госпиталі

Қанның автоматикалық анализаторы қазіргі кезде кең қолданады, клиницистер олардың эритроциттарлы параметрлерін анемияны анықтауда белсенді қолдануда. Бірақ тромбоцитограмманың талда-

уы автоматтандырылған қанның талдауында кең қолданылмады. Шенлейн – Генох пурпурасымен ауыратын науқастардың гемограммасының тромбоциттарлы бөлігін қанның қазіргі кездегі автоматтандырылған жаратылай талдағышында зерттегенде, тромбоциттердің түрлерінің үлкен көлемді болып ұлғаюы жағына және анизоцитоз болуымен сапасының өзгеруі анықталды, сондай – ақ қандағы үлкен тромбоциттердің деңгейі бақылаудағы көрсеткіштерден әлдеқайда жоғары болды.

Түйінді сөздер жедел лейкоз, тромбоз, асқыну.

Summary

G.M.Kurmanova

Central Military Hospital NSC RK

Trombophilic mask acute leukemia

It is now widely used an automatic blood analyzers, erythrocytic parameters of which are widely used by clinicians in the diagnosis of anemia. But the interpretation of thrombositogram did not find proper application with automated blood analysis. In the study of platelet of haemogram in patients with Schonlein Henoch purpura, by the modern automatic semianalizer of blood revealed a qualitative changes in increasing of forms with the high-volume and anisocytosis, and there was an increased level of several large platelets in the blood was significantly higher than the control data.

Key words: acute leukemia, thrombosis, complications

УДК: 616.155.392.036.11

Г.М. Курманова

Центральный военный госпиталь КНБ РК, г.Алматы

Тромбофилические маски острого лейкоза

Аннотация. Острые лейкозы (ОЛ) представляют собой гетерогенную группу опухолевых заболеваний системы крови - гемобластозов, которые характеризуются первичным поражением костного мозга морфологически незрелыми кроветворными (бластными) клетками с вытеснением ими нормальных элементов и инфильтрацией ими различных тканей и органов. Клиническое наблюдение представляет интерес тем, что тромбоз глубоких вен лица явился первичным признаком острого лейкоза. Течение острого лейкоза характеризовалось значительным угнетением всех ростков кроветворения, развитием тяжелых осложнений, в том числе тромбоза глубоких вен лица справа и тромбоза кавернозного синуса.

Острый лейкоз - злокачественное заболевание органов кроветворения, характеризующееся клеточной гиперплазией в кроветворных органах. Созревание прекращается на самых ранних, бластных этапах созревания. Патологические процессы, возникающие в системе кроветворения имеют свое отражение во всех тканях организма. Острые лейкозы возникают внезапно, симулируя острые заболевания (грипп, ангину и т.д.). Теория возникновения заболевания полиэтиологична. Для острого лейкоза характерны - острые расстройства кровообращения и язвенно-некротические осложнения, геморрагический синдром. По литературным данным (В.Г.Лычев, Р.А.Комиссарова и др., 1980) у 1/3 больных острым лейкозом на разных этапах заболевания развивается ДВС -синдром, при котором возможны переходы от тромботических осложнений к геморрагическим и наоборот. В литературе (Неймарк Е.З., 1975) описаны отдельные случаи тромбозов мозговых вен и синусов при заболеваниях крови. Ведущим симптомом острого лейкоза в полости рта является кровоточивость десен и язвенно-некротические поражения слизистой оболочки. По данным Ю.Н.Поповой, только у 8 больных из 87 не было изменений в полости рта. Описанное ниже клиническое наблюдение представляет интерес тем, что тромбоз глубоких вен лица явился первичным признаком острого лейкоза.

Больная Б., 1955 г.р. поступила в стоматологическое отделение ЦВГ КНБ РК 05.04.2011г с диагнозом: тромбоз глубоких вен лица справа, тромбоз кавернозного синуса. Заболела остро 03.04. -появились боли в горле при глотании, увеличились подчелюстные лимфоузлы с обеих сторон, повысилась температура до 38,0 градусов. 04.04.11 появился отек в подглазничной, скуловой, щечной областях справа, боли в костях и общая слабость. Утром 05.04.11 больная обратилась за медицинской помощью. При поступлении - общее состояние тяжелое, температура 39,0, выраженная общая слабость, резко выраженная асимметрия лица за счет отека мягких тканей подглазничной, скуловой и щечной областей справа. Кожные покровы бледные, чистые. Правая глазная щель закрыта за счет отека век. Кожа

век гиперемирована. В около-ушножевательной области справа - врожденная, поверхностная капиллярная гемангиома = 6,5 на 7 см, без признаков воспаления. При пальпации скуловой, подглазничной и щечной областей справа определяется незначительная болезненность. Увеличены и болезненны подчелюстные и шейные лимфоузлы с обеих сторон. Рот открывается свободно, слизистая полости рта и зева - чистая, бледная, влажная, блестящая. Десны плотные, зубы интактные, переходная складка в области 765432 зубов отечная, сглажена, пальпация слегка болезненная. Перкуссия зубов 7654321 - безболезненная. Границы легких в пределах нормы, дыхание везикулярное. Сердечные тоны приглушены, ритмичные, АД 120/75 мм.рт.ст., пульс - 84 уд. в мин. Печень и селезенка не увеличены. За время осмотра у больной увеличился отек на лице справа, появился отек и гиперемия век левого глаза. Больная осмотрена окулистом - выраженная инъекция сосудов склеры, картина начальных застойных сосков зрительных нервов. Лор - органы без особенностей, на ППН пневматизация пазух не нарушена. Больная осмотрена нейрохирургом -рекомендовано ЯМРТ. При исследовании системы гемостаза-гипокоагуляция, время свертываемости крови, на момент осмотра - 21 мин. Больная госпитализирована в реанимационное отделение. Общий анализ крови от 05.04.11 - эритроциты - $3,4 \cdot 10^{12}$ в 1 мкл, НЬ 85 г/л, Цв показатель - 0,79, гематокрит - 28%, тромбоциты - $85 \cdot 10^9$ /л, лейкоциты - $1,0 \cdot 10^9$ /л, п.-4, с-25, лимф.-40, мон.-1, СОЭ - 74 мм.ч, анизоцитоз ++, лейкоцитоз++. В нейтрофилах - выраженная токсическая зернистость. Больная консультирована гематологом. В миелограмме - пунктат малоклеточный, представлен в основном лимфоцитами (24,2%) и бластами (47,2%). Красный и гранулоцитарный ростки сужены. На основании клинико-гематологического статуса выставлен диагноз - острый лейкоз. Больная переведена в гематологическое отделение ТГКБ, где больная дообследована. На основании цитохимического исследования, иммунофенотипирования выставлен диагноз острый промиелоцитарный лейкоз.

Описанное клиническое наблюдение представляет интерес тем, что тромбоз глубоких вен лица явился первичным признаком острого лейкоза. Течение острого лейкоза у этой больной характеризовалось значительным угнетением всех ростков кроветворения, развитием тяжелых осложнений, в том числе тромбоза глубоких вен лица справа и тромбоза кавернозного синуса.

Список литературы

1. Баркаган З.С. Гемморагические заболевания и синдромы.-М.,180.
2. Боровский Е.В., Кташкилейсон А.А., Виноградова Т.Ф., Абрамова Е.И.заболевания слизистой оболочки полости рта, губ // М.-1980
3. Неймарк Е.З. ...Тромбозы внутричерепных синусов и вен //М.-1975.

*Summary**G.M.Kurmanova**Central Military Hospital NSC RK**State trombositogrammy patients with Schonlein-Henochpurpura*

Acute leukemias (AL) are heterogeneous group of tumorous diseases of the blood - hemoblastoses, which are characterized by a primary bone marrow by morphologically primitive hematopoietic (blast) cells with displacement of normal elements and infiltration of various tissues and organs. Clinical supervision is of interest because of deep venous thrombosis of face was the primary sign of acute leukemia. The flow of acute leukemia was characterized by a significant inhibition of all germs of blood, severe complications, including deep venous thrombosis of face on the right and cavernous sinus thrombosis.

Key words: acute leukemia, Schonlein-Henochpurpura, platelets, complications

*Тұжырым**Г.К. Курманова**Шенлейн-Генох пурпурасы бар науқастардың тромбоцитограмманың күйі**ҚР ҰҚК орталық әскери госпиталі*

Жедел лейкоздар қан жүйесінің ісік ауруларының ішіндегі жетілмеген қан түзуші (бластты) жасушалардың сүйек майын біріншілік зақымдануымен және олардың қалыпты элементтерді ығыстыруымен, әр түрлі тіндер мен мүшелерде шоғырлануымен сипатталатын гетерогенді тобы – гемобластоздарды құрайды. Клиникалық бақылаулар беттің терең көк тамырларының тромбозы жедел лейкоздың алғашқы белгісі болуымен қызықтырады. Жедел лейкоздың ағымы барлық қан түзуші өсінділеріне қысым көрсетумен, ауыр асқынулардың дамуымен, соның ішінде оң жақ беттің терең көк тамырларының тромбозымен және кавернозды синустың тромбозымен сипатталды.

Түйінді сөздер жедел лейкоз, Шенлейн-Генох пурпурасы, тромбоциттер, асқыну

С.С. Аширова

Казахский ННН онкологии и радиологии, г.Алматы

Современное состояние и перспективы развития онкологических кабинетов

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 261 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» Правительство Республики Казахстан своим Постановлением от 29.03.2012 года утверждает Программу развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы [1]

Таблица 1 Онкологические кабинеты в РК

годы	РК	Акмолинская	Актюбинская	Алматинская	Атырауская	Восточно-Каз.	Жамбылская	Западно-Каз.	Карагандинская	Кызылординская	Костанайская	Мангыстауская	Павлодарская	Северо-Каз.	Южно-Каз.	г.Алматы	г.Астана
2011	263	18	18	21	7	27	16	17	26	8	22	4	14	17	27	13	8
2012	289	18	18	22	7	34	18	18	29	9	25	8	14	17	31	13	8

Согласно Этапам реализации Программы в «Направление 4. Развитие и совершенствование инфраструктуры онкологической службы и укрепление ее материально-технической базы» указано довести до утвержденного норматива количество онкологических кабинетов (1 кабинет на 50000 населения, но не менее 1 должности в районных поликлиниках).

В 2013 году планируется открытие 54 онкологических кабинетов, в 2014 году - 27, 2015 году - 20 кабинетов.

Онкологические кабинеты - первичное звено в системе онкологической помощи. Они создаются в составе поликлиники (городской, районной), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических отделений многопрофильной больницы.

Работу онкологические кабинеты строят в соответствии с «Положением о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 12.08.2011года №540. [2]

Онкологические кабинеты (ОК) организуют в соответствии со штатными нормативами, утвержденными приказом Министра здравоохранения РК от 7 апреля 2010 года №238 [3].

В 2011 году по РК функционировало 263 онкологических кабинетов и в 2012 году их стало - 289 (таблица 1).

Как видно из таблицы 1 за год увеличилось число ОК в Восточно-Казахстанской области на 7, Южно-Казахстанской и Мангыстауской областях добавилось по 4, Карагандинской и Костанайской по 3, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях по 2 и 1 онкокабинету.

Базовыми задачами, стоящими перед онкологическими кабинетами (ОК), являются:

- учет больных злокачественными новообразованиями (ЗН), проживающих на территории деятельности кабинета, контроль за своевременным направлением извещений на них в онкологические диспансеры;

- оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным ЗН и с подозрением на них;

- диспансерное наблюдение за больными ЗН.

Одной из основных задач ОК является - учет больных со злокачественными новообразованиями.

С целью обеспечения учета больных в ОК и

учреждениях общей лечебной сети, в которых больному впервые был установлен диагноз ЗН, вне зависимости от ведомственной подчиненности указанных медицинских учреждений, заполняется учетная форма «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования» (ф. №90/У) утвержденная приказом Минздрава РК. «Извещение» заполняется на всех больных, которым был установлен диагноз данного ЗН впервые, в том числе:

- на больных, самостоятельно обратившихся в лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью;

- на больных, выявленных при диспансеризации, на профилактических осмотрах, при реализации скрининговых программ;

- на больных, выявленных при медицинском освидетельствовании;

- на больных, выявленных при обследовании и лечении в стационаре медицинского учреждения, в частности, при диагностике ЗН во время оперативного вмешательства;

- на больных, которым был установлен диагноз ЗН на вскрытии («Извещение» в этом случае должно быть заполнено в прозектуре, патологоанатомическом отделении (лаборатории) медицинского учреждения);

- на больных, которым был установлен диагноз ЗН после смерти и информация получена при сверке сведений об умерших от ЗН по данным ЗАГС и статистических управлений со сведениями онкологических учреждений;

- на больных с преинвазивным раком (carcinoma in situ).

«Извещение» должно быть заполнено в день установления диагноза, выслано в онкологическое учреждение регионального уровня по месту постоянного жительства больного в 3-дневный срок с момента заполнения.

Онкологический кабинет осуществляет изъятие дубликатов «Извещения», уточнение и верификацию информации, внесенной в «Извещение». Стадия опухолевого процесса у больных ЗН может быть уточнена с учетом данных, полученных во время хирургического вмешательства, если оно произведено не позднее, чем через два месяца после установления диагноза.

Онкологический кабинет осуществляет контроль за полнотой учета посмертно выявленных заболеваний. Ежемесячно сотрудники ОК должны сверять число

умерших от ЗН, состоявших на учете, с данными отделов ЗАГС.

На умерших от ЗН, не состоявших при жизни на учете в ОК, заполняют «Извещение» с отметкой «Учен посмертно». Кроме того, на всех учтенных посмертно составляется «Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования» (ф.№027-2/У).

«Извещение» является основным источником информации при составлении базы данных (БД) Национального канцер-регистра, который формируется в ИАЦ КазНИИОиР и годовых статистических отчетов территориального онкологического учреждения по форме №7 «Отчет о больных и заболеваниях злокачественными новообразованиями».

БД cancer-registra является основным источником для расчетов комплекса аналитических данных по состоянию онкологической ситуации в целом по Республике и отдельно по регионам. Аналитические данные по онкологической службе Республики публикуются в

ежегодном статистическом сборнике института. [4]

Список литературы

1. Қазақстан Республикасында онкологиялық көмекті дамытудың 2012-2016 жылдарға арналған бағдарламасы. Программа развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы. -Астана, 2012.-90с.
2. Қазақстан Республикасының халқына онкологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы ереже. Положение о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан.- Астана, 2011.- 51с.
3. Приказ №238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №6173).- Астана, 2010.
4. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеусов Д.М., Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы).- Алматы, 2012.- 108 с.

Ажигалиев Нариман Ажигалиевич

Вы прошли достойный путь гражданина и сына нации от врача до доктора медицинских наук, профессора, академика Международной академии информатизации. Высоквалифицированный специалист, онколог-радиолог, вдумчивый, активный научный сотрудник, хороший организатор. Вы на протяжении 50 лет занимались разработкой методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.

В 1965 г. впервые организовали и возглавили отделение ускорителей. В разные годы возглавляли отделением лучевой терапии лимфом, отделением клинической радиологии. Были главным радиологом Минздрава Казахской ССР, консультантом ЦКБ Управделами Президента РК.

Вы являетесь автором более 370 научных работ, 3 монографий, имеете 22 авторских свидетельства на изобретения, патенты и методические рекомендации.

Основные направления Ваших научных исследований посвящены применению электронного и тормозного излучения медицинских ускорителей при лечении злокачественных опухолей. Впервые в Советском Союзе с 1965 г. Вами начато лечение злокачественных опухолей электронами высоких энергий. Проведены научные исследования, отработаны и внедрены новые методы лучевой терапии на линейных ускорителях.

Под Вашим руководством проведены совместные грантовые исследования с учеными ближнего и дальнего зарубежья: программа по использованию оксигенации опухолей с применением барокамеры, программа «Модификатор» по применению радиомодифицирующих агентов в лучевой терапии, участие в исследовании по изучению и внедрению нового радиосенсибилизатора гипоксических клеток АК-2123 (Япония, Россия).

Вы являетесь создателем школы специалистов по лучевой терапии в Казахстане. Под Вашим руководством подготовлены 12 кандидатов и докторов медицинских наук.

Вами проводилась научно-общественная работа: как главный радиолог МЗ Казахской ССР, член Всесоюзной проблемной комиссии по лучевой терапии Научного Совета при АМН СССР, заместитель председателя БРИЗа, член специализированного диссертационного совета. Вы



дважды избирались депутатом Индерского райсовета Атырауской области, награждены значками «Отличник здравоохранения СССР», «Изобретатель СССР», медалью «Ветеран труда», почетными грамотами.

Вы обладаете такими качествами как трудолюбие, ответственность, требовательность, чуткость, внимательность, скромность и принципиальность. Вы пользуетесь большим уважением коллектива.

Поздравляем с Юбилеем! Желаем здоровья и душевного спокойствия.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии

Савхатов Доспул Хайназарович

Глубокоуважаемый Доспул Хайназарович! Поздравляем Вас со славным юбилеем!

Вся Ваша жизнь была связана с медициной и медицинской наукой. Вы прошли достойный путь от врача до доктора медицинских наук.

1969 год – золотой медалист становится студентом Алматинского Государственного медицинского института. Успешно закончив, работали врачом-хирургом в Центральной районной больнице. Ваш пылкий ум и целеустремленность приводят в целевую клиническую ординатуру г.Москвы. Вы становитесь специалистом по ЛОР-онкологии под руководством заслуженного деятеля Российской Федерации. Стремление к знаниям и совершенствование в профессии является основой выполнения в дальнейшем кандидатской и докторской научных работ. Ваши исследования были посвящены вопросам эпидемиологии, диагностики и лечения злокачественных опухолей верхних дыхательных путей. Вы являетесь автором разработки пластики нижней губы после тотального ее удаления. С 2004 по 2007 гг. Вы проходили зарубежную стажировку в гг.Марсель, Париж и Ренн по реконструктивно-пластической хирургии.



В разные годы Вы работали в институте, начиная от рядового врача до гнс, заведующего отделением. С 2009 по 2011 годы Вы являлись заместителем директора по научно-клинической работе, возглавляя самый сложный участок в деятельности института. А также в этой должности Вы успешно проводили специализированные Советы по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Вами осуществлялась большая научно-общественная работа по проведению IV-V съездах онкологов и радиологов стран СНГ, по подготовке молодых кадров – резидентов, по специализации врачей онкослужбы, как заместителя главного редактора в журнале «Онкология и радиология Казахстана».

Вы - отличник здравоохранения РК, имеете ряд почетных грамот и благодарностей Министерства здравоохранения и ряда общественных организаций.

Вас отличает профессионализм, организаторский талант, внимательность к людям. Вы заслуженно пользуетесь уважением коллектива.

Сотрудники института, друзья и коллеги от всей души поздравляют Вас с Юбилеем. Желают Вам больших творческих успехов.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии